



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JANUARI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab 1 Pendahuluan 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

 A. Visi 2

 B. Misi 2

 C. Motto 2

 D. 7 Nilai Budi Utama 2

 E. Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

 A. Profil Pelayanan 5

 a. Kunjungan Pasien Rawat Inap 5

 b. Kunjungan Pasien Rawat Jalan..... 5

 c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA 6

 d. Profil Tempat Tidur Profil Tempat Tidur..... 7

 B. Profil Pelayanan Antrian Online 8

 a. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online bulan Terakhir 8

 b. Analisa 9

 C. Indikator Kerja 10

 a. BOR, LOS, BTO dan TOI 2024 (Januari – bulan terakhir) 10

 b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI 10

 c. Klaim Pending 11

 a) Analisis 11

 b) Tindak Lanjut..... 11

 D. Data Mutu/Keselamatan Pasien 11

 E. Permasalahan Rumah Sakit 50

 F. Profil SDM 55

 a. Komposisi dan Distribusi SDM 55

 b. Update STR/SIP..... 58

 G. Kemajuan Piutang..... 59

 a. Data Piutang yang Belum Terbayar..... 59

 b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang..... 59

 c. Update IKS..... 60

 H. Program Nasional 71

 a. PONEK 71

 b. TB Dots 82

 c. HIV..... 90

 d. Stunting & Wasting..... 98

 e. KBRIS 104

Bab IV Data Utilitas Unit..... 107

 A. Pelayanan Medis..... 107

 a. Tabel Data Kamar Operasi..... 107

 b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan 108

c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap.....	111
d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)	114
B. Penunjang Medis	115
a. Tabel Data Laboratorium.....	115
b. Tabel Data Radiologi.....	116
c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	119
d. Tabel Data Laundry.....	120
e. Tabel Data CSSD.....	121
f. Tabel Data Instalasi Gizi	122
g. Tabel Instalasi Rekam Medis	123
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	124
Bab VI Penutup.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Januari Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

A. VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

B. MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

C. MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

D. 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :

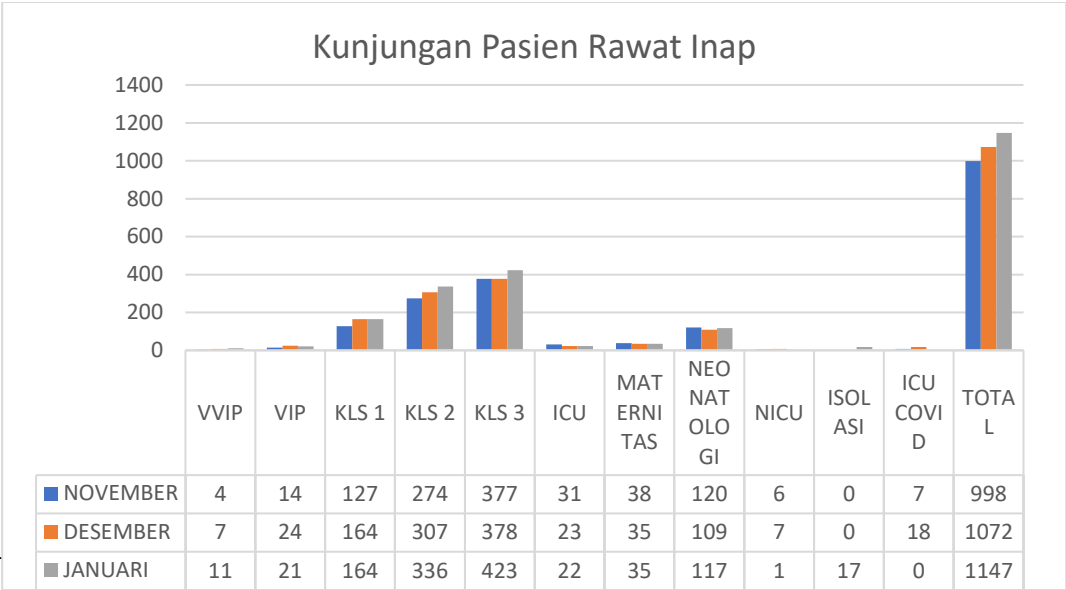
No	Jabatan	Nama	No SK Jabatan	Tanggal Jabatan
1	PLT Direktur RS Prima Husada	dr. Nur Mazidah	01.204/DPM/I-KEP/DIR/II/2024	1 Februari 2024
2	Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	1451/I-KEP/DIR/X/2020	1 November 2020
		Dwi Novianti, Amd.AK, S.Kes	397/I-KEP/DIR/V/2021	28 Mei 2021
3	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	002.4/DPM/I-KEP/DIR/II/2024	2 Agustus 2023
4	PLT Kepala Bidang Penunjang Medis	Putri Indah Purnamasari, Amd. Keb	1153/I-KEP/DIR/XI/2023	13 Februari 2024
5	Kepala Bidang Keperawatan	Ns. Very Susanto, S.Kep	974.1/I-KEP/DIR/X/2023	4 Oktober 2023
6	Kepala Bidang Umum dan Keuangan	dr. Endy Wira Pradana, MMRS	136.132/DPM/I-KEP/DIR/VI/2023	10 Juni 2023
7	Kepala Instalasi Rawat Inap	dr. Catur Ari Setianto, Sp.S	004.4/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
8	1) Kepala Ruang Rawat Inap 2C	Indah Maulhayati, S.Kep.Ns	006.4/I-KEP/DIR/II/2023	2 Januari 2023
	2) Kepala Ruang Rawat Inap 6A, 7A, 8A	Murwani Suryaning Sapartinah, S. Kep., Ns	1154/I-KEP/DIR/XI/2023	13 November 2023
	3) Kepala Ruang Rawat Inap 3C	Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns	428.58/I-KEP/DIR/VI/2021	22 Juni 2021
	4) Kepala Ruang Rawat Inap 3A, 4A	Wiwit Indah Yanti, S.Kep.,Ns	1190.21/I-KEP/DIR/VIII/2020	15 Agustus 2020
	5) Kepala Ruang Rawat Inap 5C	Amilatul Kholifah	659/I-KEP/DIR/VII/2023	1 Juli 2023
	6) Kepala Ruang Rawat Inap Maternitas	Siti Zaimah, AMd.Keb	1196.7/I-KEP/DIR/VII/2022	26 Juli 2022
	7) Kepala Ruang Neonatologi	Dhora Putri Meryda, S.Kep.Ns	2272.4/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
9	Kepala Instalasi Kamar Operasi	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.16/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
	Kepala Ruang IKO	Siti Durotul Ibadiah., S. Kep.,Ns	039.22/I-KEP/DIR/II/2018	2 Januari 2018
10	Kepala Intensive Care Unit	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.14/I-KEP/DIR/2019	2 Januari 2019
	Kepala Ruang ICU	Risma Indra Setiyani, S.Kep.,Ns	651/I-KEP/DIR/V/2022	26 Mei 2022
11	PLT Kepala Instalasi Gawat Darurat	dr. Andira Aulia Rahma	205/I-KEP/DIR/III/2023	1 Maret 2023
	Kepala Ruang IGD	Afni Nur Ainy, S.Kep.Ns	2272.3/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
12	Kepala Instalasi Rawat Jalan	dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK	004.4.2/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
	Kepala Ruang Rawat Jalan	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	2272.1/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
13	Kepala Instalasi Farmasi	Apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm	777.1/I-KEP/DIR/VIII/2023	08 Agustus 2023
14	Kepala Instalasi Rekam Medik	Rina Tri Wahyuni, AMd.RMIK	2272.6/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022

15	Kepala Instalasi Laboratorium	dr. Ari Putriani, Sp. PK	004.25/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
	Kepala Unit Laboratorium	Yoga Eka Ramadhani Ariwa, AMd.AK	1345.4/I-KEP/DIR/VIII/2022	26 Agustus 2022
16	Kepala Instalasi Radiologi	dr. Agung Setyawan, Sp.Rad	401/I-KEP/DIR/VI/2019	17 Juli 2020
	Kepala Unit Radiologi	Ayu Bintang Tinara, Amd. Rad	004.28/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
17	Kepala Unit Sterilisasi (CSSD) dan Laundry	Ahmad Taufan Fauzi, Amd. Kep	120/I-KEP/DIR/II/2024	30 Januari 2024
18	Kepala Instalasi Gizi	-	-	-
	Kepala Unit Gizi	Veni Lestari Puri Purnami., Amd. Gz	004.30/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
19	Kepala Bidang Umum	dr. Endy Wira Pradana, MMRS	136.132/DPM/I-KEP/DIR/VI/2023	10 Juni 2023
	1) Kesekretariatan	Mahesa Yudistiranti,S.AP	1255.3/I-KEP/DIR/XII/2023	01 Desember 2023
	2) Kepala Unit SDM & Diklat			
	3) Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi	Novi Ratnasari, S.E	103.1/I-KEP/DIR/II/2021	26 Februari 2021
	4) Kepala Unit SIMRS & IT	Ramadhian Anshari, S.Kom	153.14/I-KEP/DIR/III/2021	26 Maret 2021
	5) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	-	-	-
	6) Kepala Unit Security & Parkir	M. Rizal., S.E	004.40/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
	7) Kepala Unit Umum Cleaning Service	Erik Ardinata	155/E-KEP/DIR/II/2024	30 Januari 2024
	8) Kepala Unit Asuransi Center	Nur Rizkiah Amalia	1560/I-KEP/DIR/X/2022	5 Oktober 2022
20	Ketua Komite Medis	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	1185/I-KEP/DIR/VII/2022	25 Juli 2022
21	Ketua Komite Keperawatan	Artika Wulandari, S.Kep., Ns	839/I-KEP/DIR/VIII/2023	14 Agustus 2023
22	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz	116/I-KEP/DIR/II/2023	6 Februari 2023
23	Ketua Komite PPI	dr. Aida Musyarofah, Sp.OG	-	-
	IPCN	Sherly Rosita, S.Kep.,Ns	068.2/I-KEP/DIR/II/2020	3 Februari 2020
24	Ketua Komite Etik Rumah Sakit	dr. Ari Putriani, Sp.PK	001.4/I-KEP/DIR/II/2022	4 Agustus 2022
25	Ketua Komite Farmasi & Terapi	dr. Sadi Hariono, MMRS	175.3/I-KEP/DIR/II/2022	1 Februari 2022-
26	Ketua Tim P2K3RS	-	-	-
27	Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A.,M.Biomed	001.5/I-KEP/DIR/II/2022	1 Januari 2022

BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

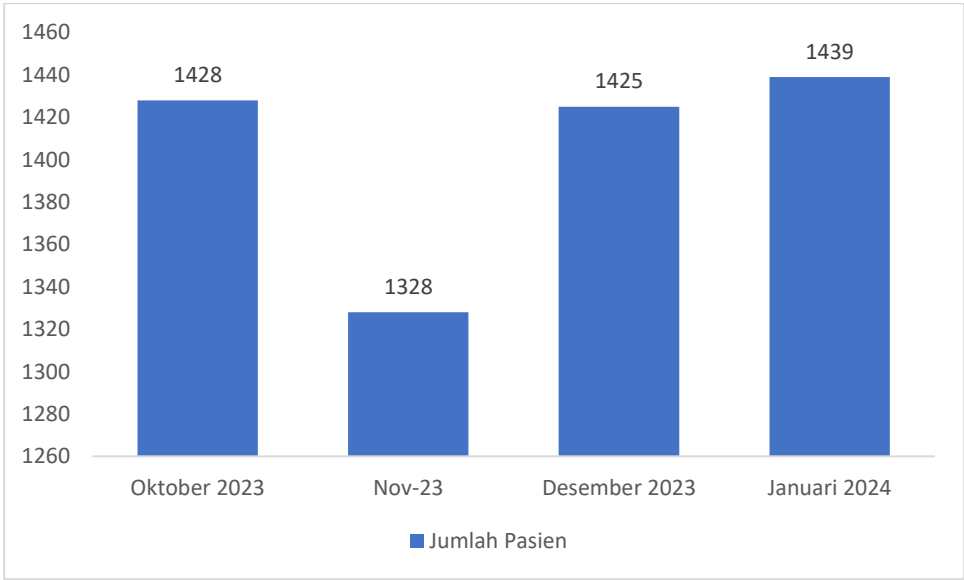
A. Profil Pelayanan

a. Kunjungan Pasien Rawat Inap



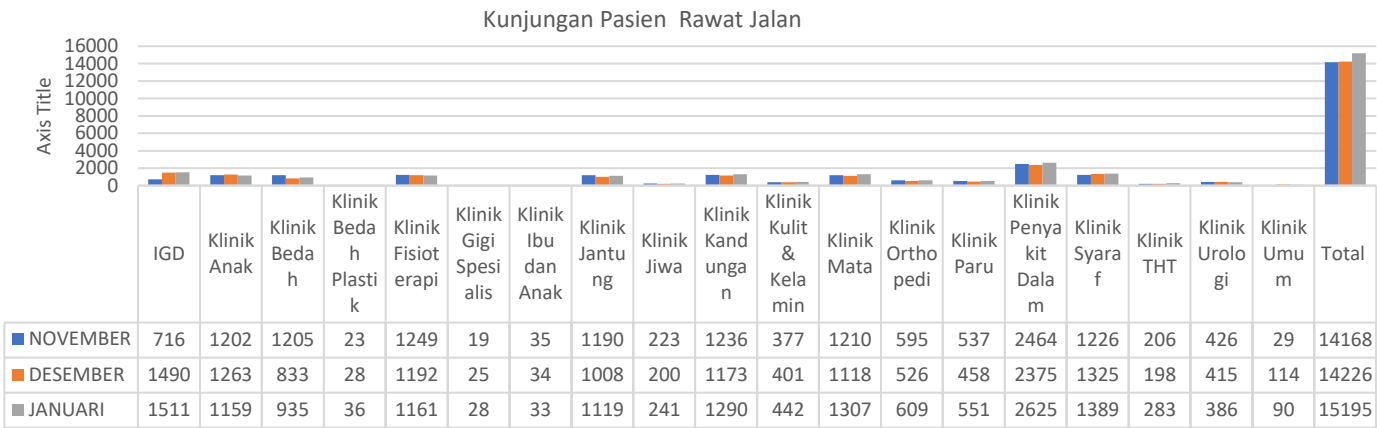
Berdasarkan pada grafik diatas, kunjungan pasien rawat inap di RS Prima Husada Malang mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Dimana pasien rawat inap pada bulan Desember di angka 1072 dan naik di bulan januari di angka 1147, dengan persentase kenaikan sebesar 6,9%, meliputi 945 pasien BPJS, 101 pasien BPJS ikut ibu, 59 pasien umum, 17 pasien BPJS TK, 14 pasien asuransi swasta, 7 pasien Jasa Raharja, 3 pasien jaminan Perusahaan, dan 1 jaminan pemerintah lainnya (TASPEN).

b. Kunjungan Pasien IGD



Terdapat peningkatan jumlah kunjungan pasien IGD pada bulan Januari 2024 dibandingkan bulan Oktober hingga Desember 2024.

c. Kunjungan Pasien Rawat Jalan



Berdasarkan grafik kunjungan diatas pasien rawat jalan yang berkunjung ke RS Prima Husada Malang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terdapat kenaikan kunjungan rawat jalan pada Januari 2024 dibanding bulan sebelumnya, dimana pada Desember 2023 terdapat 14.226 kunjungan, bulan Januari sebesar 15.195 kunjungan dengan persentase kenaikan sebesar 6,8 %. Kunjungan pasien di poli Penyakit Dalam masih menduduki kunjungan paling banyak dari seluruh poli yang ada di RS Prima Husada Malang. Dari 15.195 kunjungan rawat jalan, 86% diantaranya adalah pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan.

d. Jumlah Tindakan di IKO



Terdapat peningkatan Tindakan operasi pada bulan Januari 2024 dibanding 3 bulan sebelumnya. Dengan 68% dari total Tindakan adalah operasi besar.

e. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA

Plan	1. Open rekrutmen untuk DPJP yang mengajukan permohonan mengundurkan diri 2. Menambah jadwal dokter praktek di RS Prima Husada Malang 3. Melakukan penertiban dan evaluasi jadwal praktek dokter di poli 4. Menjaring lebih banyak pasien lewat promosi dan marketing melalui media online 5. Mengaplikasikan daftar kehadiran dokter praktek di poli dalam SIMRS yang terintegrasi dengan ERM
------	---

	6. Memperbaiki system proporsional bagi DPJP 7. Mempercepat alur penerimaan rujukan luar
Do	1. Publikasi info rekrutmen DPJP via WA dan IG 2. Koordinasi dengan DPJP untuk penambahan jadwal dokter praktek 3. Membuat fitur Absensi bagi DPJP pada aplikasi SIMRS yang telah bridging dengan ERM 4. Monitor, evaluasi dan supervise bagi DPJP yang ijin tidak praktek 5. Melakukan rapat koordinasi antar unit untuk mengkondisikan pelayanan bagi DPJP yang tidak praktek 6. Mengawal DPJP terkait control mutu control biaya
Study	1. Keterlambatan dan ketidakhadiran dokter di RS akan mempengaruhi kinerja pelayanan di RS 2. Pelayanan yang kurang baik akan memunculkan complain dari pasien 3. Kurangnya pengetahuan DPJP terkait proporsi menyebabkan komplain dan banyaknya pasien yang di rujuk dari IGD 4. Respon tim IGD yang lambat menyebabkan banyaknya perujuk yang mengalihkan rujukan ke RS lain
Action	1. Sosialisasi alur dan SPO kepada DPJP yang ijin tidak praktek 2. Monitor dan evaluasi SPO dan alur yang ada 3. Berkoordinasi dengan kepala instalasi dan kepala ruang rawat inap dan rawat jalan RS Prima Husada Malang 4. Koordinasi dengan asuransi centre dan dokter ruangan terkait KMKB 5. Koordinasi dengan IGD dan perujuk luar terkait sistem penerimaan rujukan yang baru

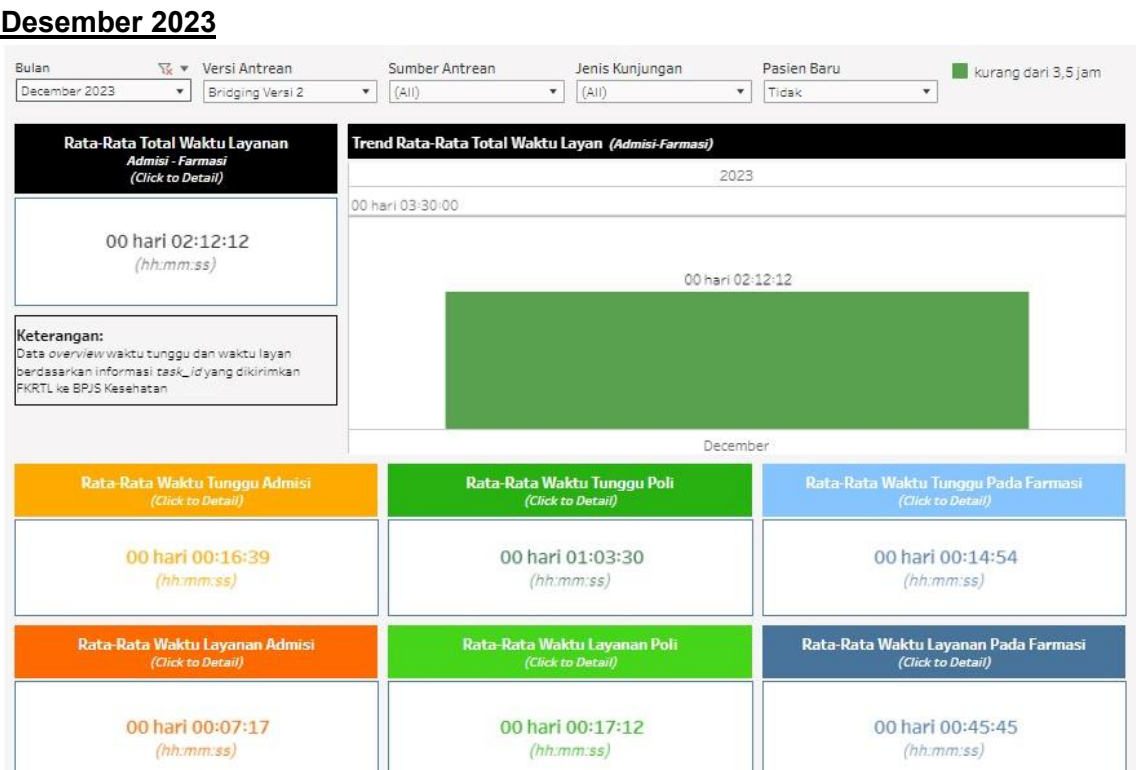
f. Profil Tempat Tidur

NO	JENIS KELAS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kelas VVIP	3	2%
2	Kelas VIP	3	2%
3	Kelas 1	17	12%
4	Kelas 2	38	28%
5	Kelas 3	49	35%
6	Perawatan Intensive ICU Dengan Ventilator	8	6%
7	HCU	2	1%
8	NICU	6	4%
9	Isolasi Isolasi Tekanan Negatif Isolasi <i>Immunocompromise</i>	9 5	10%
TOTAL		140	100%

Nb : SK No 701/KEP/DIR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Tempat Tidur untuk Pelayanan Asuhan Pasien

B. Profil Pelayanan Antrian Online

1) Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online



NO	KETERANGAN	BULAN				
		Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	Waktu Rata-Rata					
2	Total Waktu Layanan	02.48.16	02.13.10	02.01.51	02.12.12	02.04.53
3	Waktu Tunggu Admisi	00.17.49	00.21.24	00.22.03	00.16.39	00.18.13
4	Waktu Layanan Admisi	00.05.33	00.05.45	00.06.06	00.07.17	00.08.01
5	Waktu Tunggu Poli	01.14.37	01.03.31	01.04.45	01.03.30	00.57.33
6	Waktu Layanan Poli	00.16.24	00.20.58	00.17.56	00.17.12	00.19.11
7	Waktu Tunggu Farmasi	00.22.02	00.16.42	00.10.33	00.14.54	00.11.55
8	Waktu Layanan Farmasi	01.16.10	00.43.30	00.36.46	00.45.45	00.43.35

Analisa :

Terjadi peningkatan pada waktu tunggu admisi, waktu layanan admisi dan waktu layanan poli dibanding bulan Desember 2023. Namun secara tren, waktu tunggu admisi masih terbilang masih rendah dibanding 4 bulan sebelumnya. Waktu layanan admisi meningkat dari bulan ke bulan menjadi salah satu masalah yang disebabkan oleh petugas masih melakukan input ulang terkait SEP pada kasus-kasus seperti control kedua post MRS namun rujukan belum habis 3 bulan, penjamin yang berbeda saat kontrol.

2) Analisa :

Plan	Meningkatan waktu kecepatan penyimpanan data pendaftaran.
Do	- Koordinasi dengan tim programmer terkait lama waktu penyimpanan pendaftaran SIMRS akibat prosedur input - Koordinasi dengan Unit Pendaftaran untuk meningkatkan kinerja staf
Study	Waktu tunggu layanan admisi yang semakin naik dari bulan September menjadi dasar untuk evaluasi.
Action	- Monitoring evaluasi - Supervisi kabit

Feedback dari BPJS untuk bulan Desember 2023

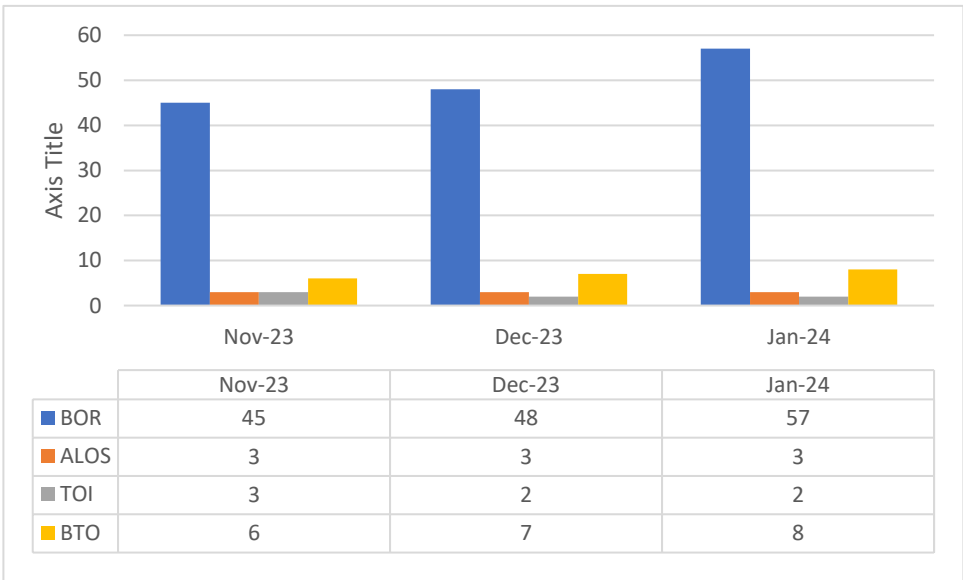
No	Kode Faskes	Nama FKRTL	Jumlah SEP RJTL Terbit	Pemanfaatan Antrean Online			
				Bridging	Mobile JKN	All Sumber	% (>=80)
				<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d (b+c)</i> <i>e (d/a)</i>
1	0212R014	RS BHIRAWA BHAKTI	1.722	1.669	22	1.691	98%
2	1324R037	RS MARSUDI WALUYO	2.697	2.169	451	2.620	97%
3	0212R028	RSUD Kota Malang	1.571	1.258	267	1.525	97%
4	0187R013	RS PRIMA HUSADA	8.525	5.280	2.985	8.265	97%
5	0212R012	RSU PERMATA BUNDA	944	803	112	915	97%
6	0212R009	RS ISLAM MALANG UNISMA	3.816	3.636	42	3.678	96%
7	0212R022	RSIA MUHAMMADIYAH MALANG	369	334	14	348	94%
8	0187R019	RS SUMBER SENTOSA	679	604	36	640	94%

NO	JENIS	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Jumlah SEP RJTL Terbit	9.006	8.425	8.525
2	Bridging	4.884	5.269	5.280
3	Mobile JKN A	342	2.691	2.985
4	All Sumber	5.226	7.960	8.265
5	%	58%	94%	97%

Analisa :
Peningkatan kualitas rata-rata data yang terkirim ke system BPJS dari Oktober ke Desember mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh system dari programmer yang telah dibenahi sehingga RS Prima Husada sudah melebihi standar > 80%.

Plan	Menganalisa perbaikan data quality rate
Do	Kordinasi dengan programmer terkait hasil bulan Desember sebagai pelaporan hasil perbaikan
Study	Data bulan Oktober sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki mulai diperbaiki.
Action	• Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring • Monitoring evaluasi <i>feedback</i> bulan Desember • Supervisi kabit

C. Indikator Kinerja
a. BOR, LOS, BTO dan TOI



- b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI
- Untuk tingkat hunian di RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan dibanding dengan 2 bulan sebelumnya. ALOS di RS Prima Husada Malang tetap dalam 3 (tiga) bulan terakhir yaitu di angka 3, BTO meningkat menjadi 8 kali dan TOI menurun menjadi 3 hari.
- Analisa :
- Nilai BOR RS Prima Husada Malang meningkatkan dibanding 2 bulan sebelumnya, menunjukkan kunjungan yang perlahan meningkat setelah sempat mengalami penurunan. Namun nilai ini masih di bawah BOR ideal RS yaitu 60-85% dari total TT RS.
- Masalah :
- Nilai BOR masih belum optimal walaupun kunjungan perlahan meningkat.

c. Klaim Pending

a) Analisis

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Permintaan lampiran SHK Dikarenakannya tidak samanya persepsi lampiran SHK dengan verifikator utama	Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan dihari yang sama	Konfirmasi ke Verifikator

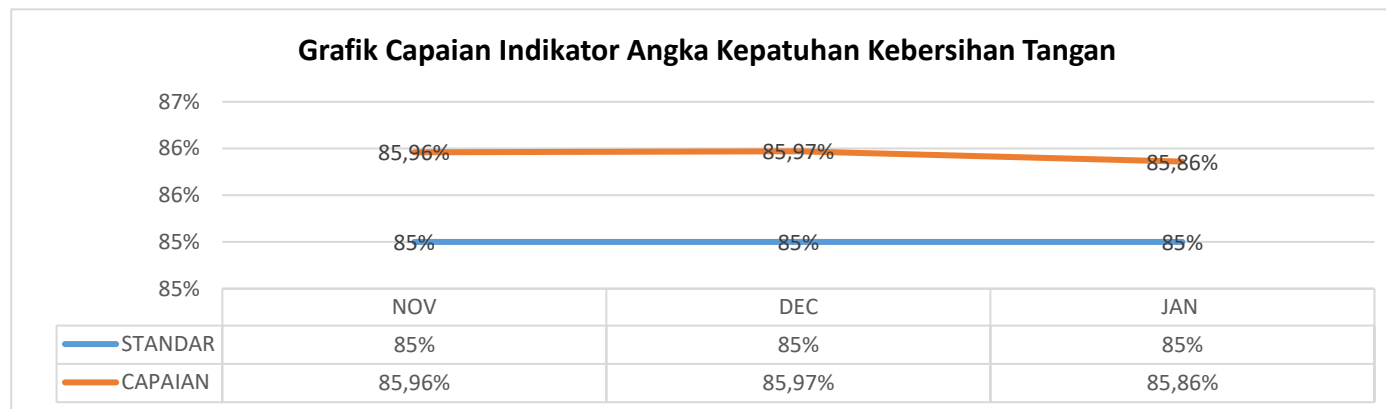
D. Data Mutu / Keselamatan Pasien

a. Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Nov '23	Des '23	Jan '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL					
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,96%	85,97%	85,86%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92,57%	92,77%	93,04%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,88%	99,84%	99,9%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	91,73%	91,73%	95,2%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	1,01%	1,8%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	58,3%	73,47%	76,19%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,58%	98,88%	98,69%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	77,65%	90,56%	63,8%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	97,73%	95,44%	98,47%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,53%	99,19%	100%

11. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

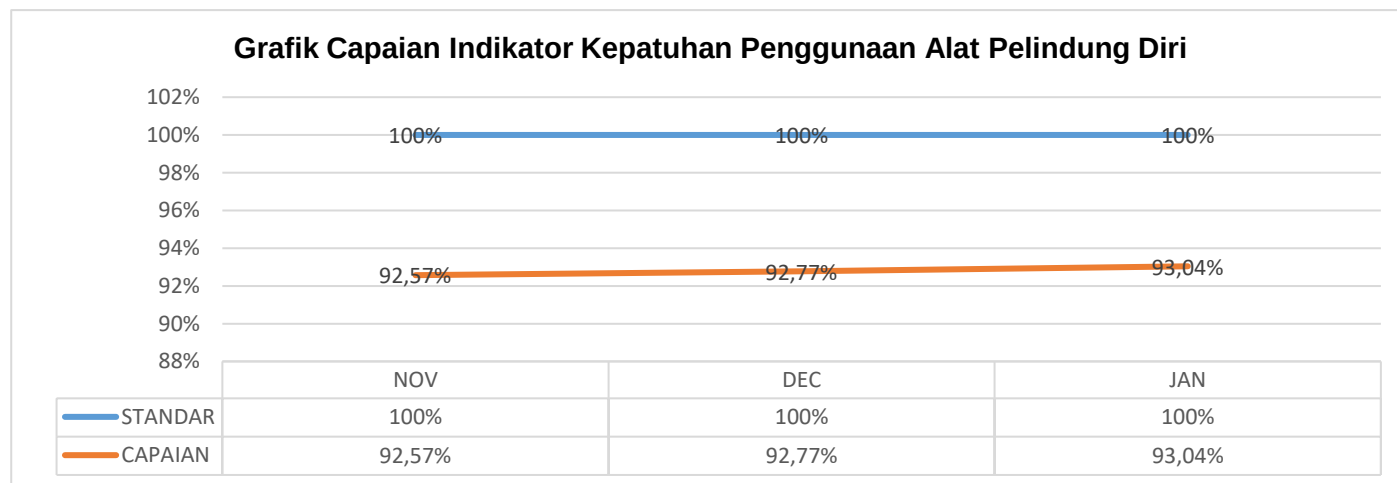


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,86%, namun prosentasenya sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan lalu. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (81,36%) dan nakes lain (83,96%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (72,32%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

12. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

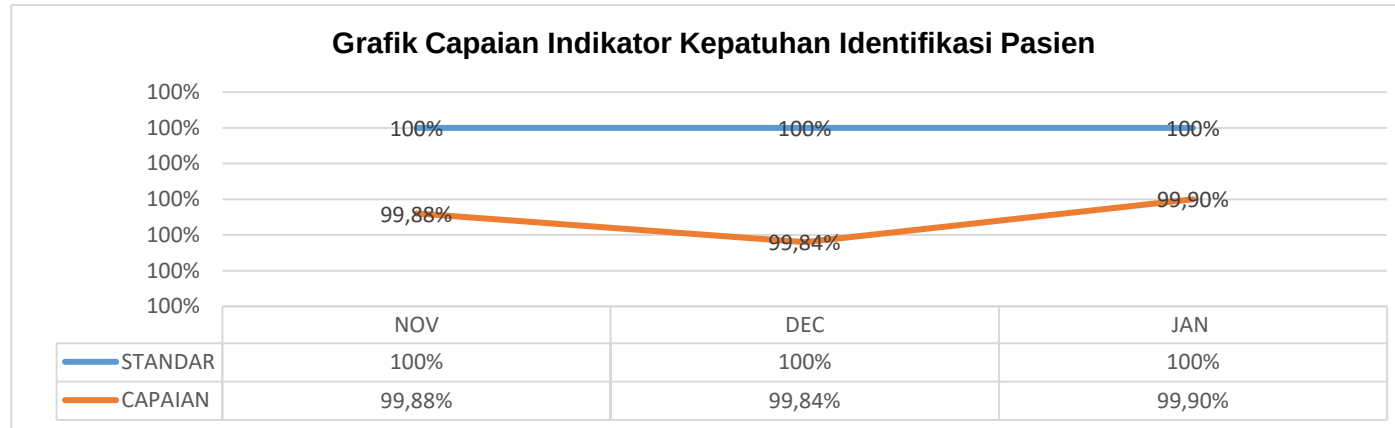


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm 5\%$ setiap bulannya.
DO	- Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

	- Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,04% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. - Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. - Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. - Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

13. Kepatuhan Identifikasi Pasien

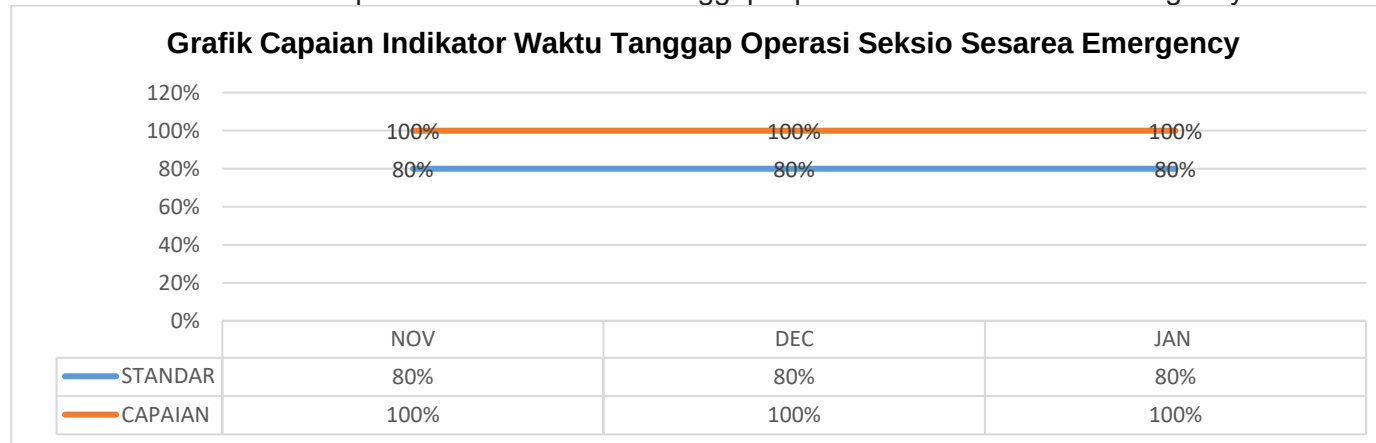
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

14. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

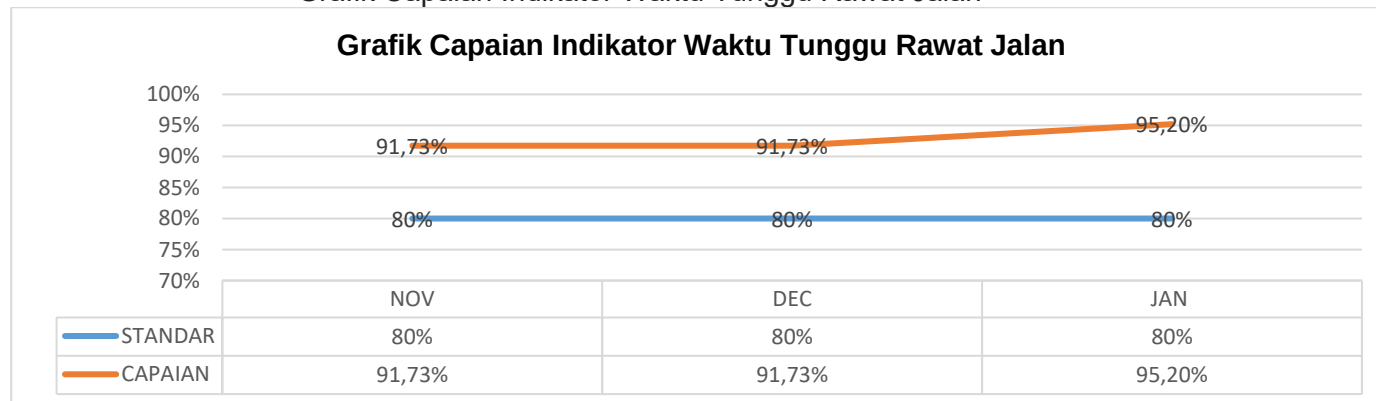


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan November dan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

15. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

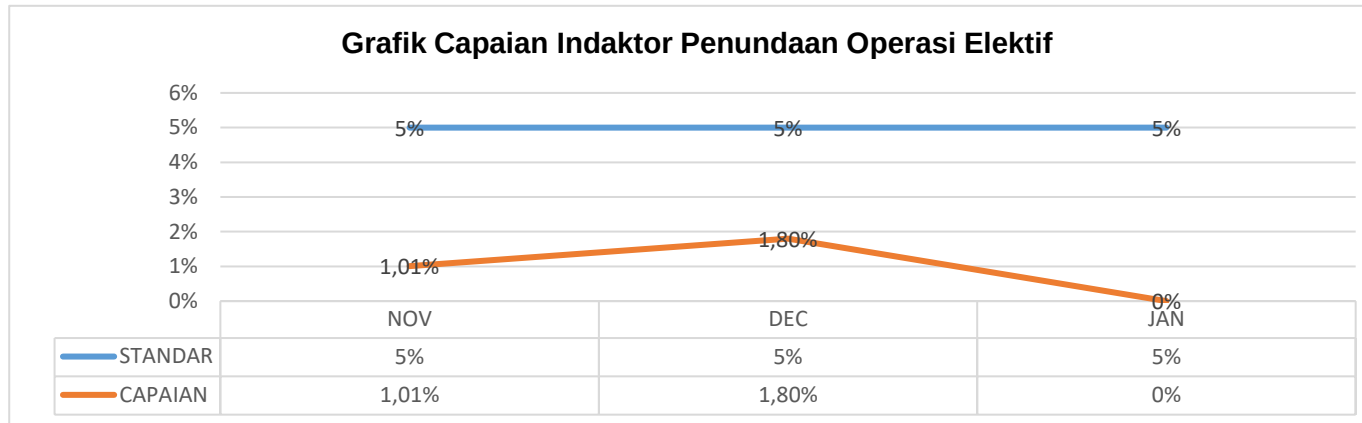


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa waktu tunggu rawat jalan pada bulan November dan Desember tahun 2023 telah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 capaian indikator waktu tunggu rawat jalan semakin meningkat dan telah mencapai standart.

16. Penundaan Operasi Elektif

Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

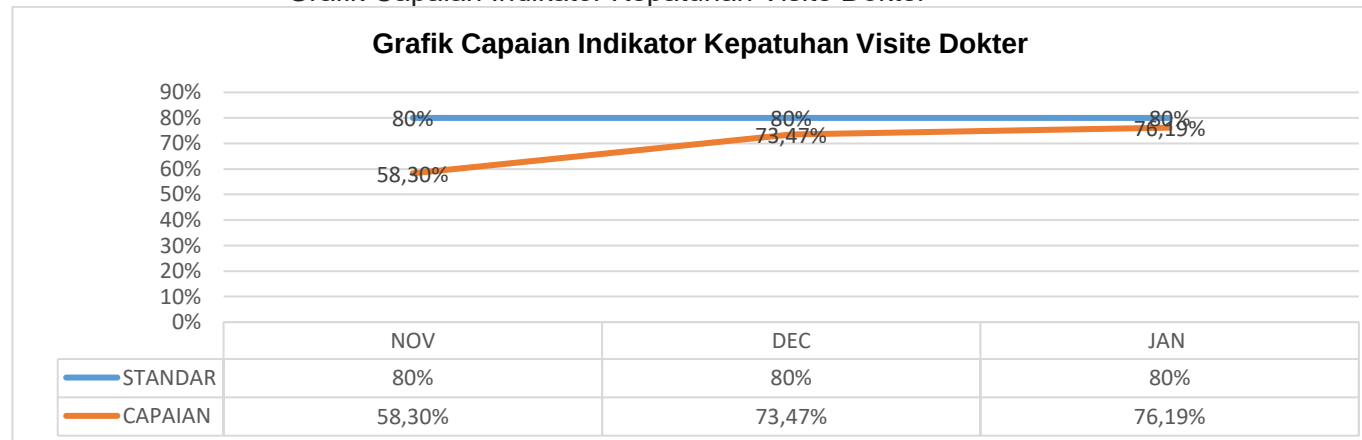


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih ada penundaan operasi elektif pada bulan November dan Desember tahun 2023 tetapi capaian masih mencapai standart. Penundaan operasi elektif dapat disebabkan karena kondisi pasien dan juga belum tersedianya alat yang akan dipasang pada pasien (orthopedi). Pada bulan Januari tahun 2024 tidak ditemukan penundaan operasi elektif.

17. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

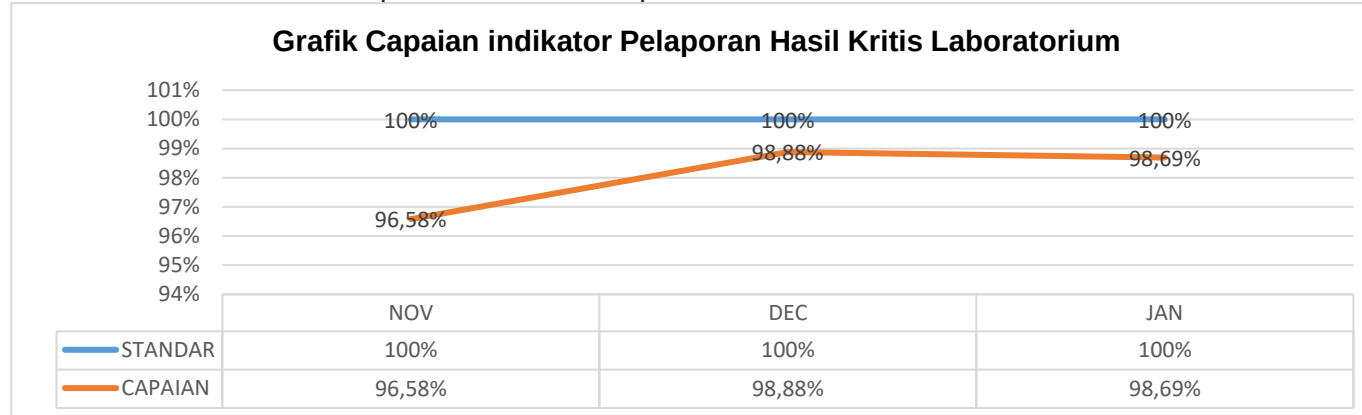
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan November dan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart. Begitu pula dibulan Januari tahun 2024, terjadi peningkatan dari bulan Desember tetapi capaian masih belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai target karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. Catur, SpS, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	- Satu bulan

18. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

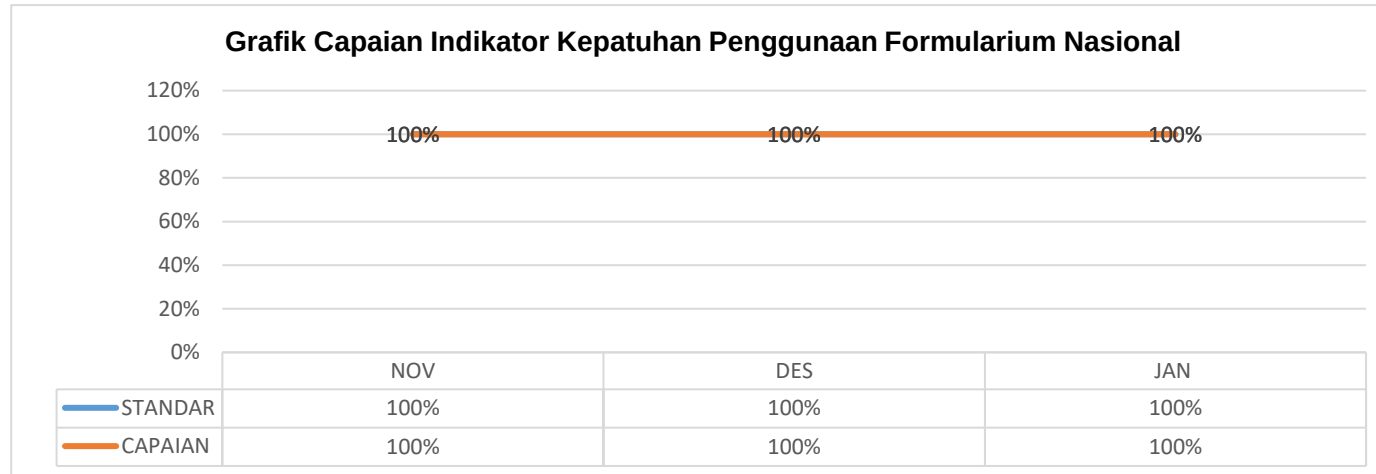
Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan November dan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart. Begitu pula dibulan Januari tahun 2024, berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	- Satu bulan

19. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

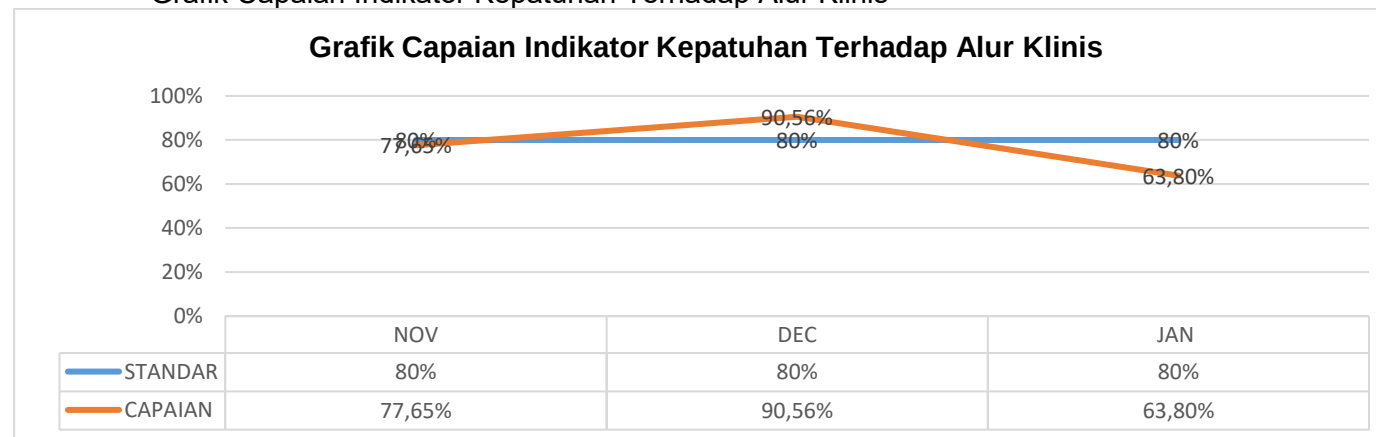


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan November dan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Begitu pula dengan bulan Januari tahun 2024, capaian indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional telah mencapai standart 100%.

20. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

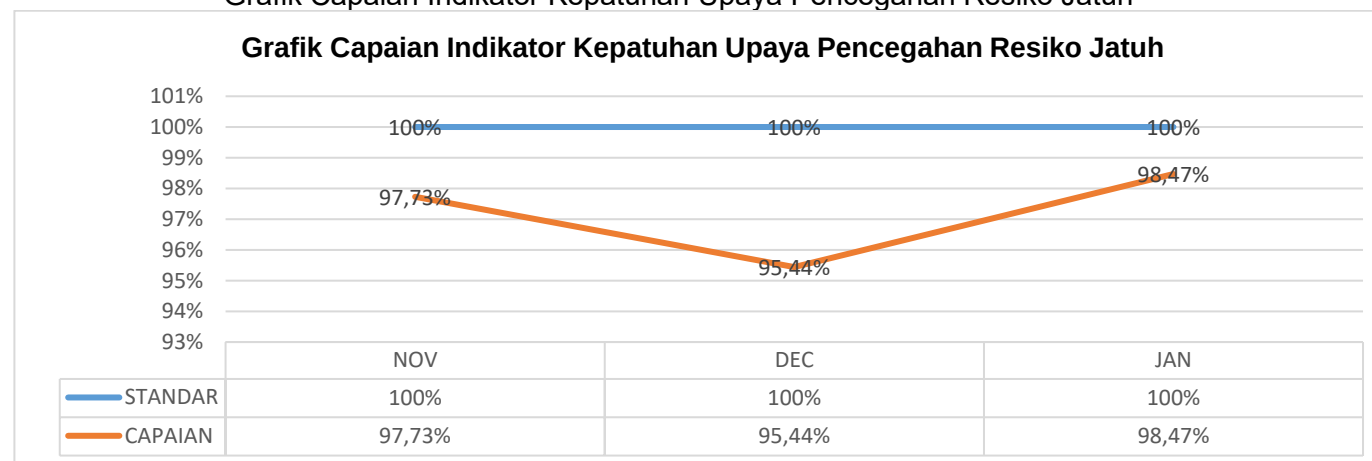
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	- Komite mutu	- Satu bulan

21. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

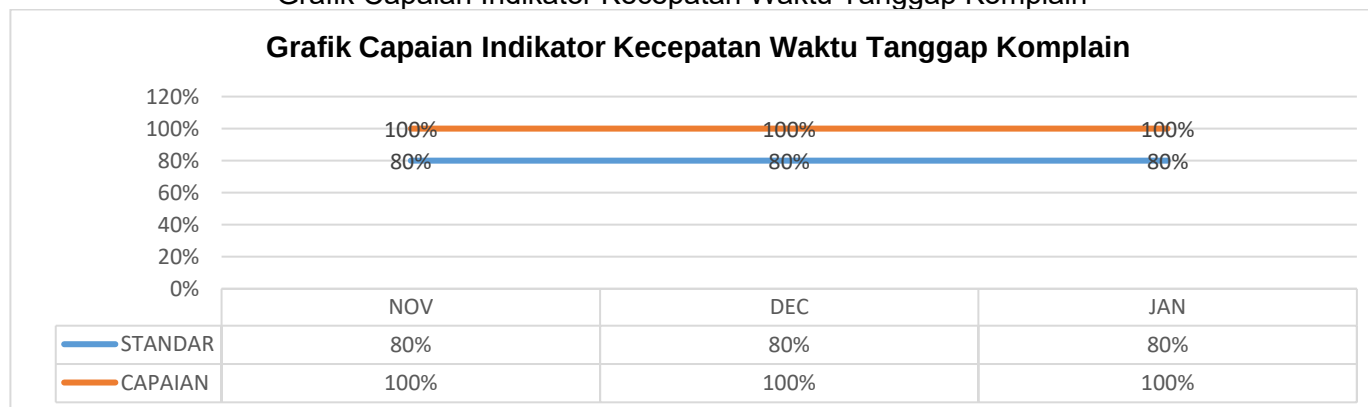
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada tahun 2023 masih belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

22. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

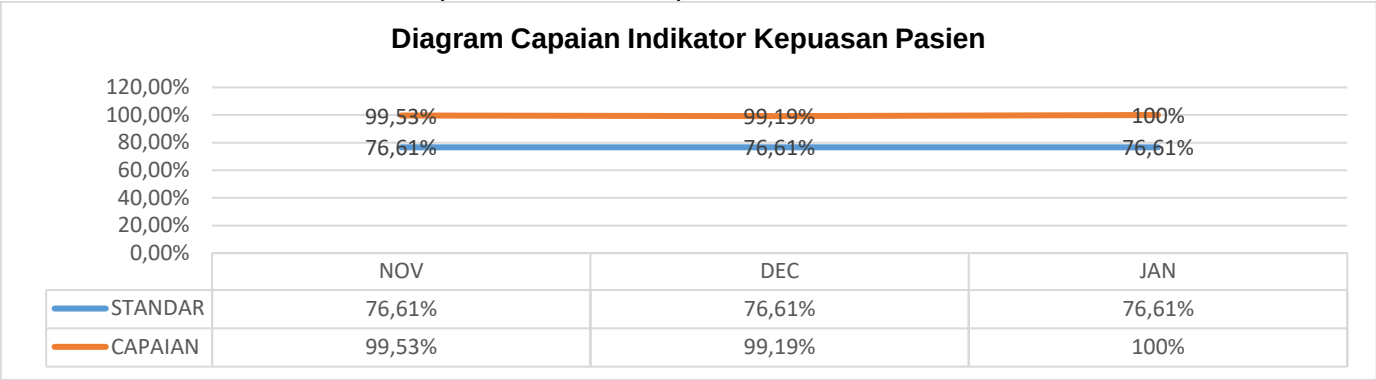
Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis: Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan November dan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 capaian tetap stabil, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam.

23. Kepuasan Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



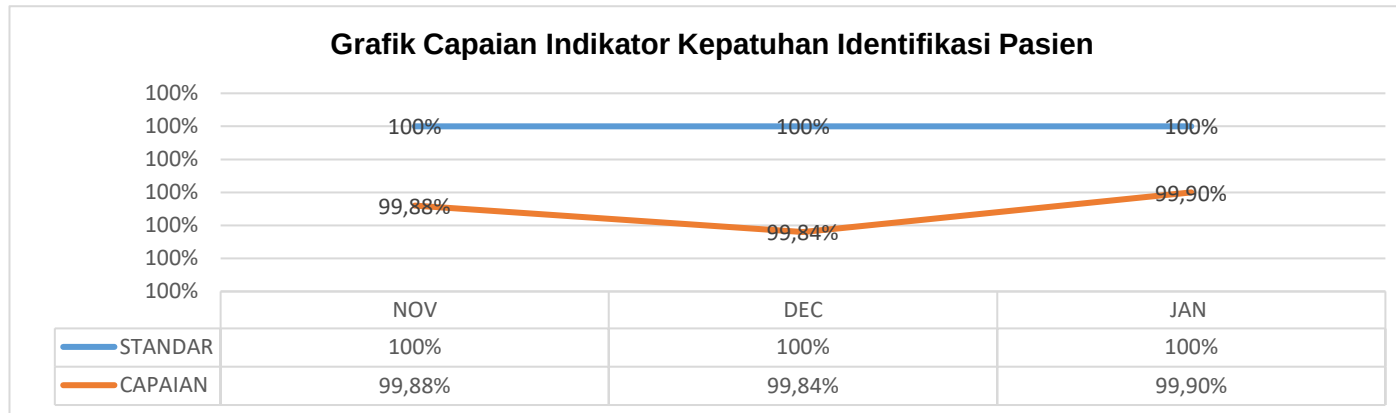
Analisis:
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan November, Desember tahun 2023 serta bulan Januari tahun 2024 sudah mencapai standart

b. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	85,93%	99,84%	99,9%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,96%	85,97%	85,86%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,73%	95,44%	98,47%

1) Kepatuhan Identifikasi Pasien

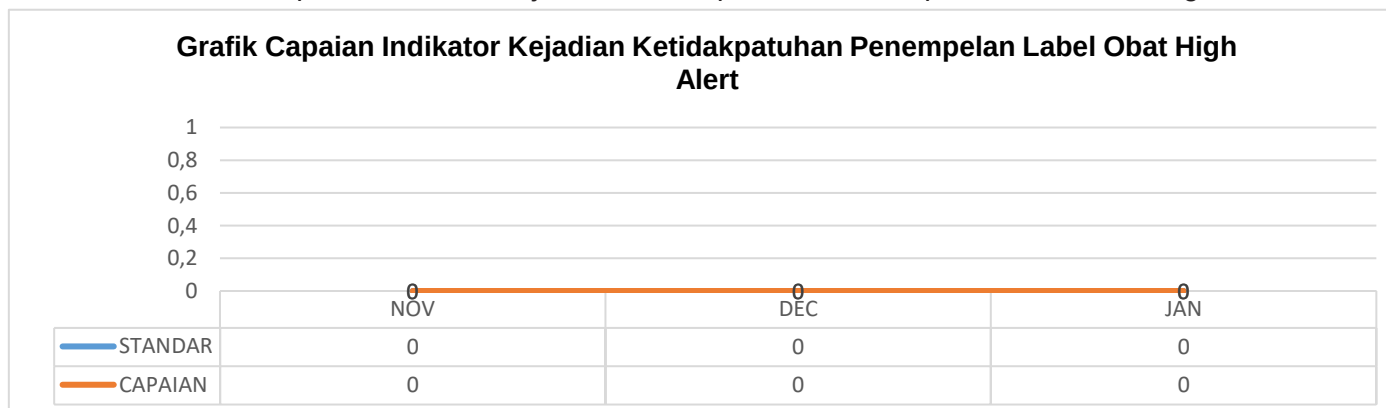
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

2) Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

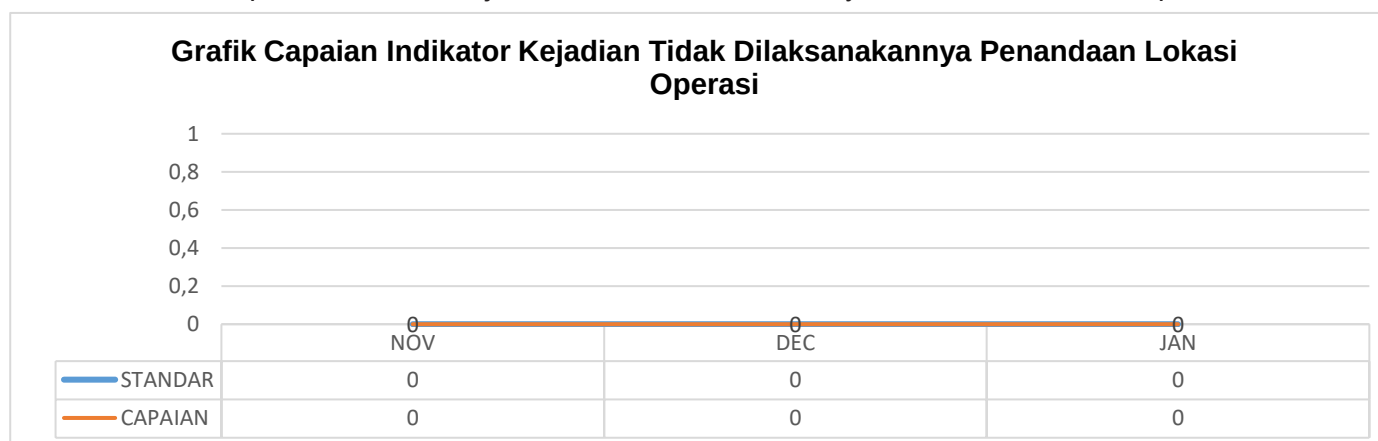


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan November-Desember tahun 2023 serta bulan Januari tahun 2024 sudah mencapai standart.

3) Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

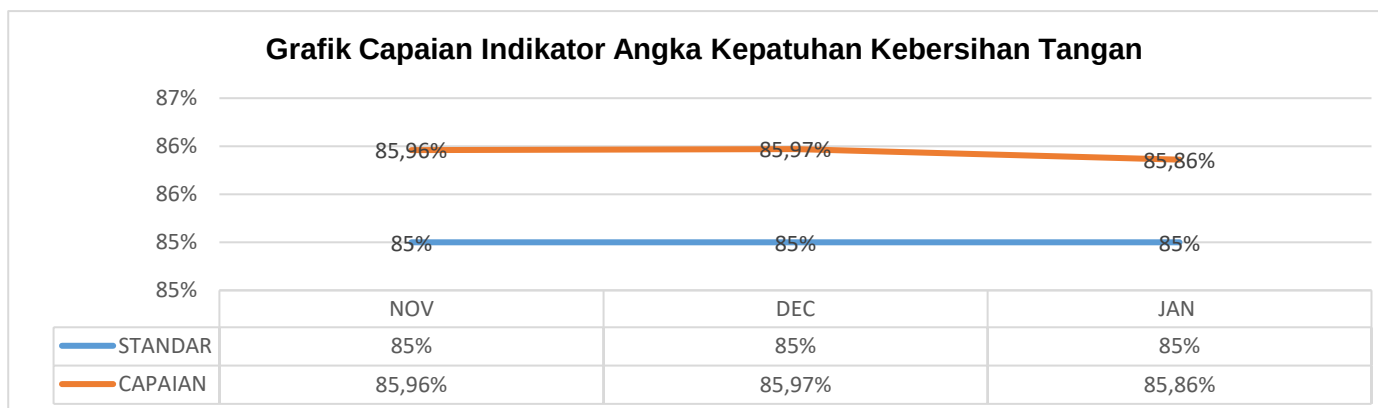


Analisis:

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan November – Desember tahun 2023 serta bulan Januari tahun 2024 sudah mencapai standart

4) Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

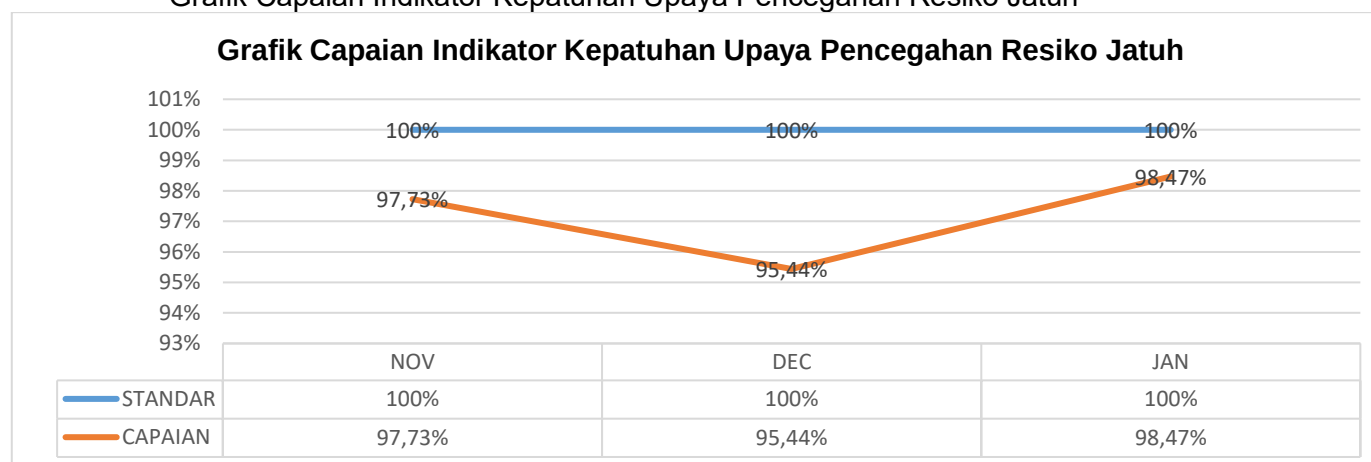


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,86%, namun prosentasenya sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan lalu. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (81,36%) dan nakes lain (83,96%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (72,32%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

5) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



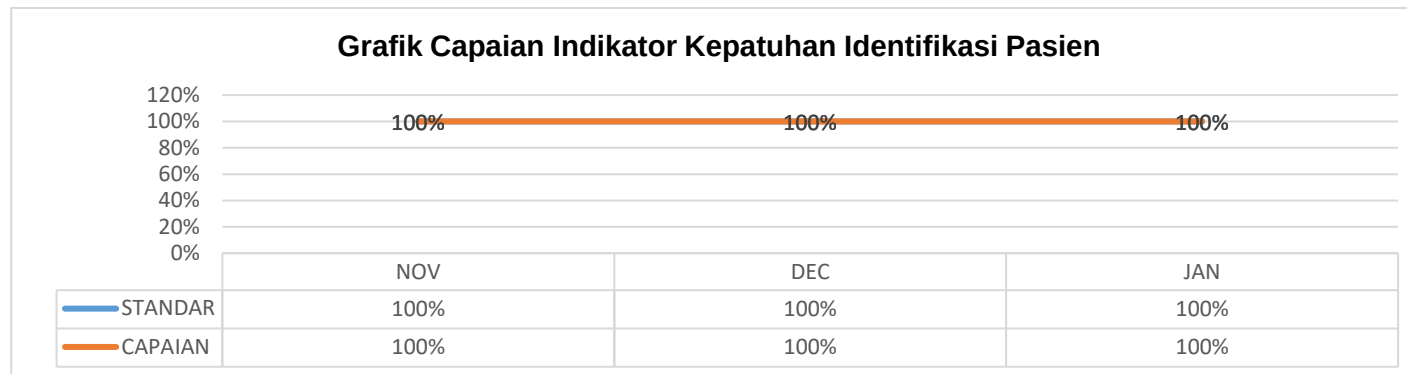
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada tahun 2023 masih belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

c. Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	NOV '23	DES '23	JAN '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	1	1
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	57,33%	65,43%	68,81%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	28,78%	44,7%	41,48%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,51%	0,27%	0,27%

1) Kepatuhan Identifikasi Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

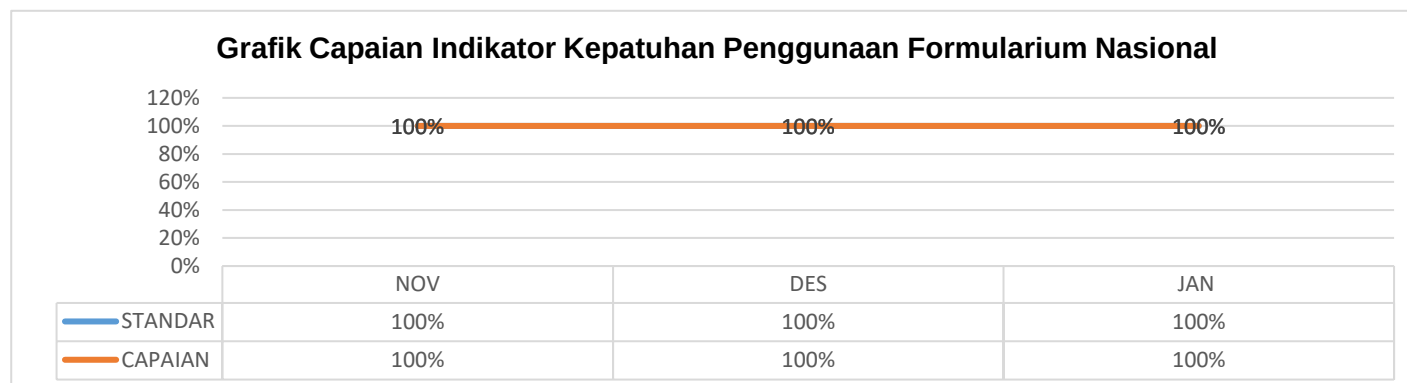


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan identifikasi pasien pada bulan November – Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Pada bulan Januari 2024 juga diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien telah mencapai standart. Petugas farmasi telah melakukan identifikasi pasien dengan tepat.

2) Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

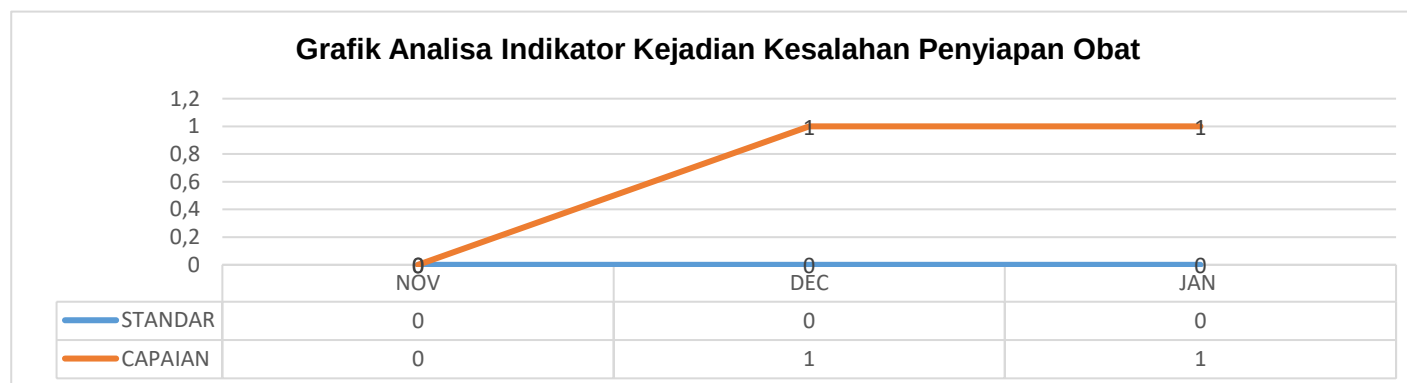


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan November – Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Begitu pula pada bulan Januari tahun 2024, rumah sakit telah menggunakan formularium nasional sebagai acuan.

3) Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

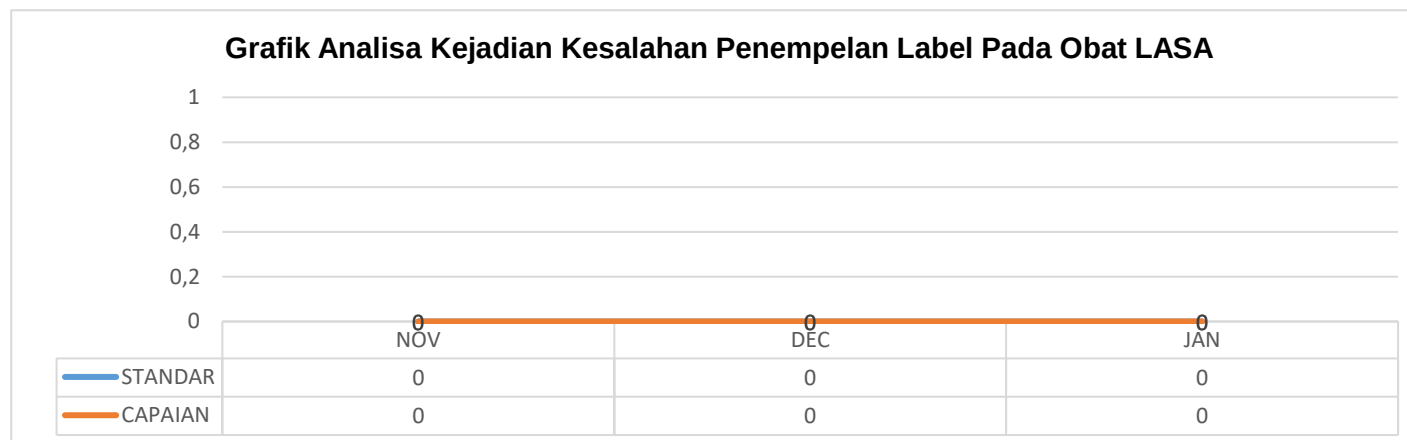
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mengurangi kejadian kesalahan penyiapan obat pada bulan berikutnya.				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan terjadi kembali pada bulan Januari 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi kejadian kesalahan pemberian obat	- Mengurangi kejadian kesalahan pemberian obat	- Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	- Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	-Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

4) Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

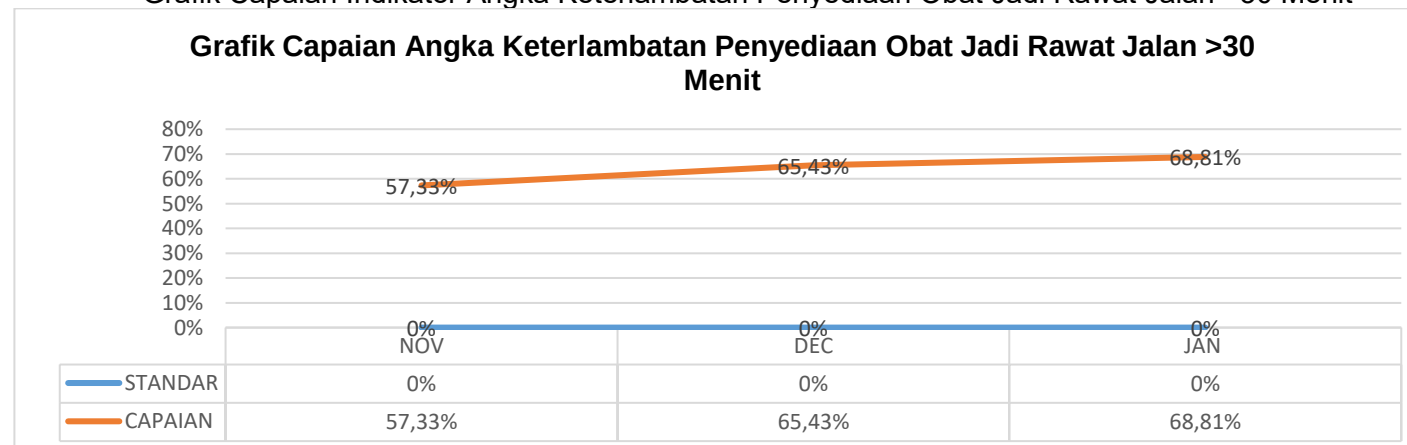


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan November – Desember tahun 2024 hingga bulan Januari tahun 2024.

5) Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

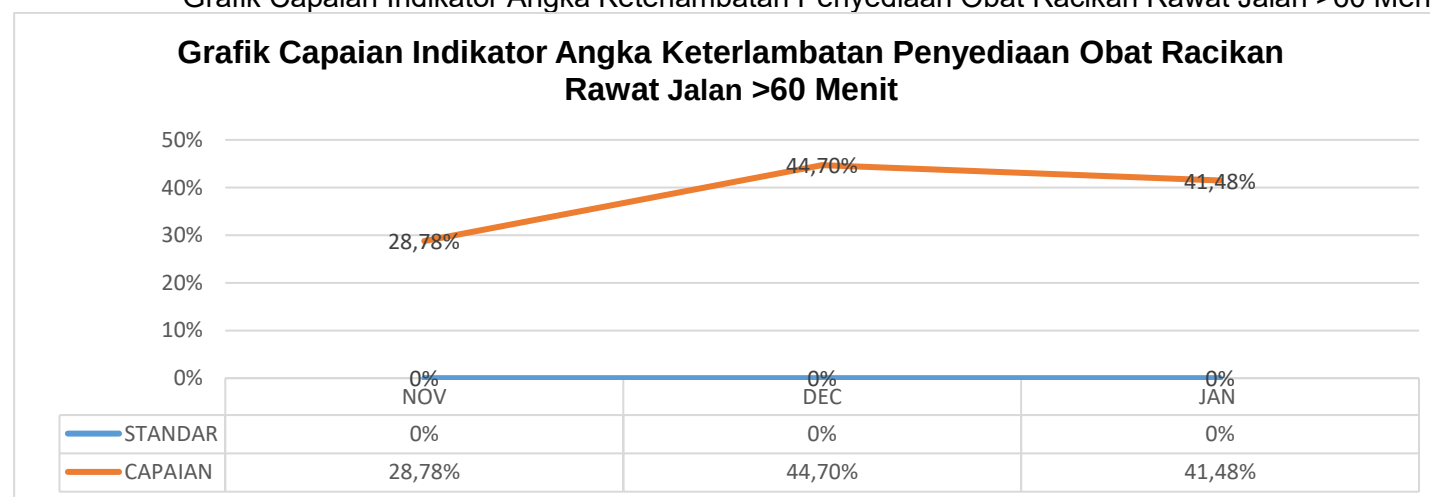
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	- Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	-Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

6) Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

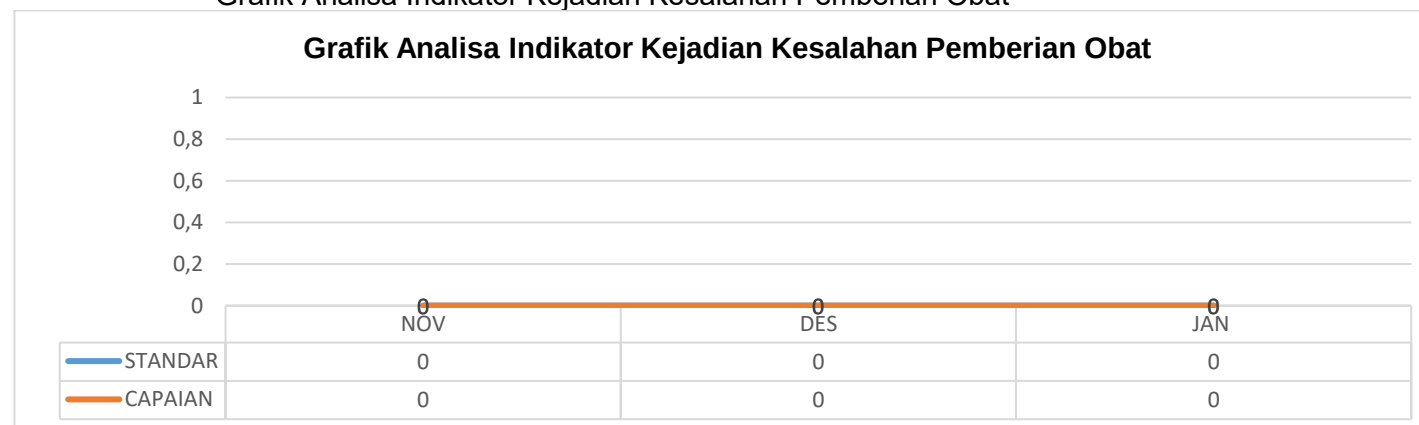


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				

STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cenderung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	-Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

7) Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



Analisa Capaian :

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat.

8) Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

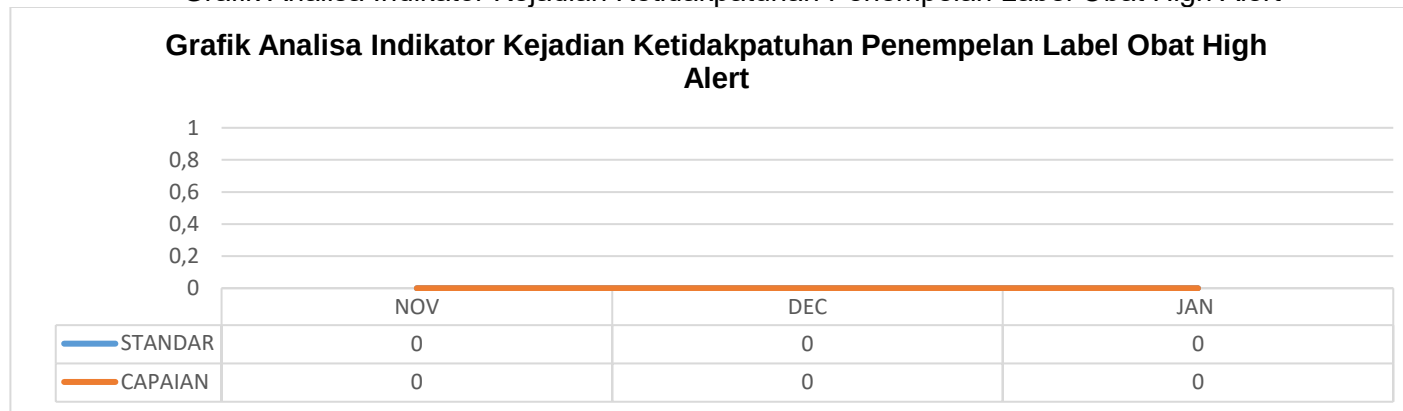
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis: Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

9) Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

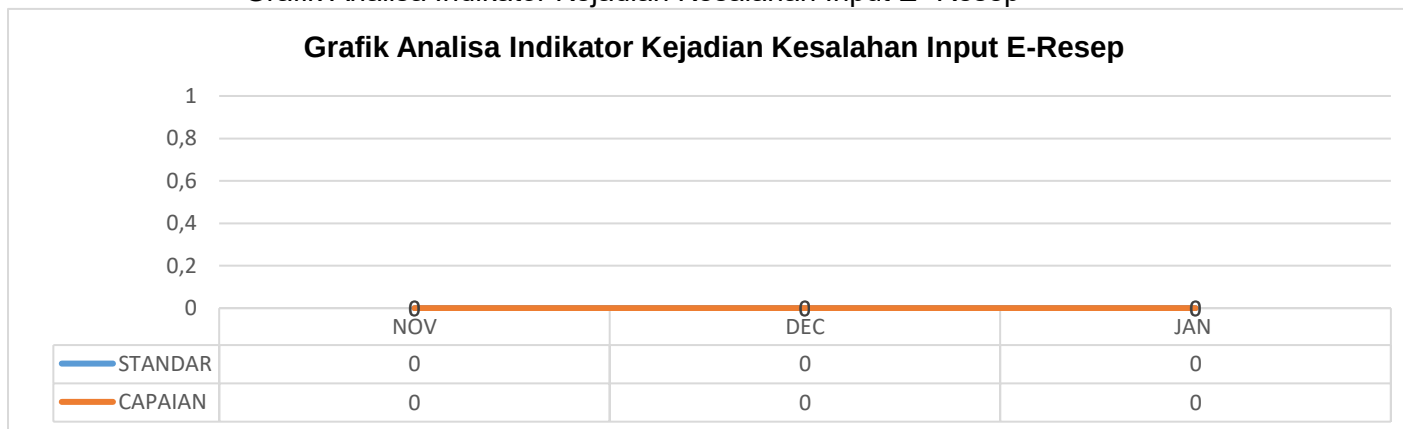


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert.

10) Kejadian Kesalahan input e-resep

Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep

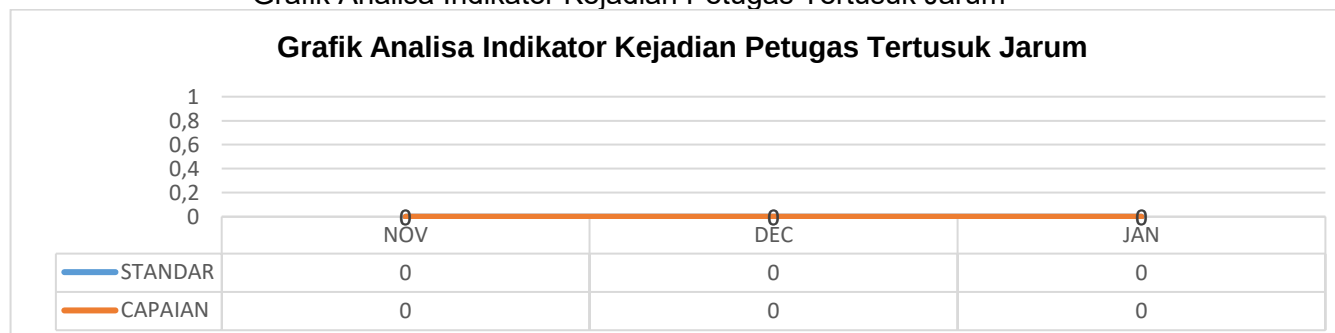


Analisis :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep

11) Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis: Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum.

12) Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

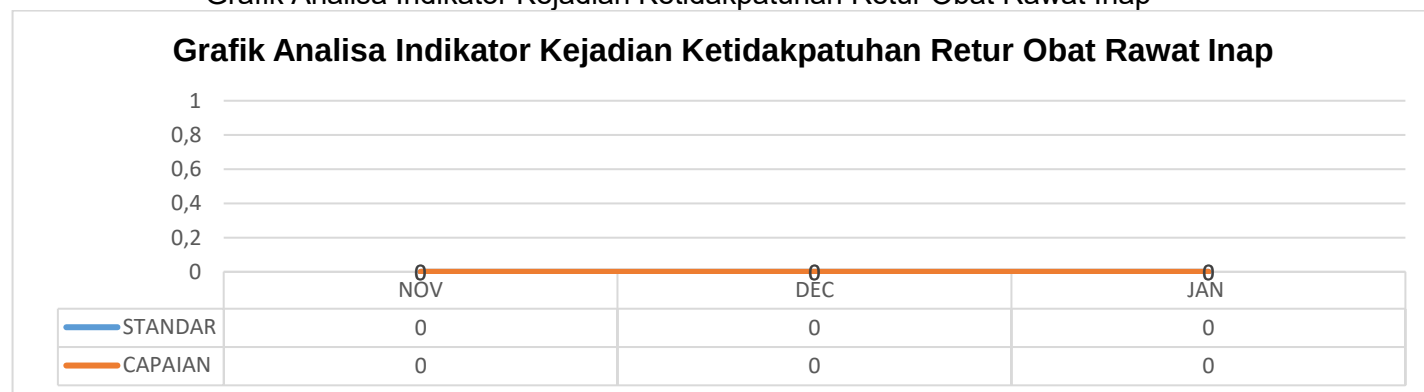
Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis: Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer.

13) Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

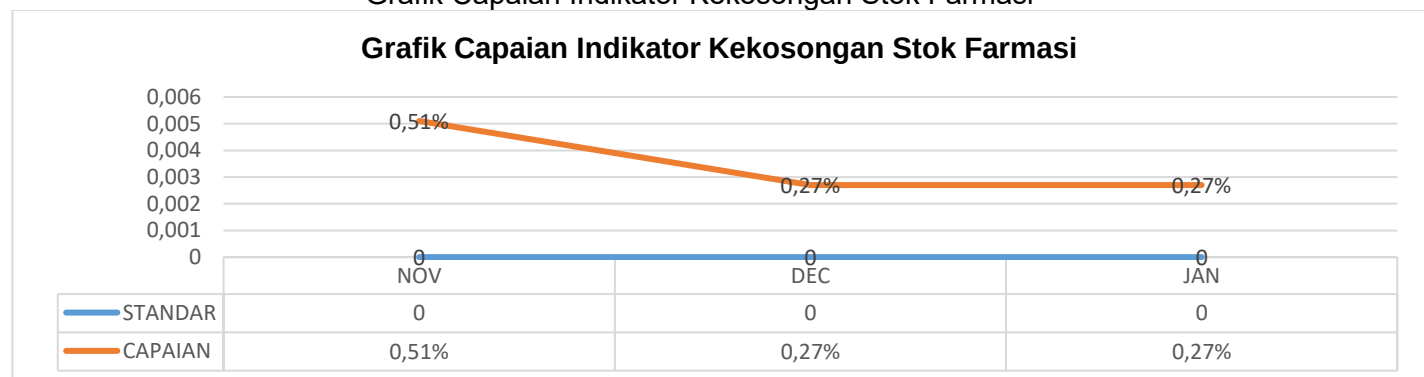


Analisa Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap.

14) Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



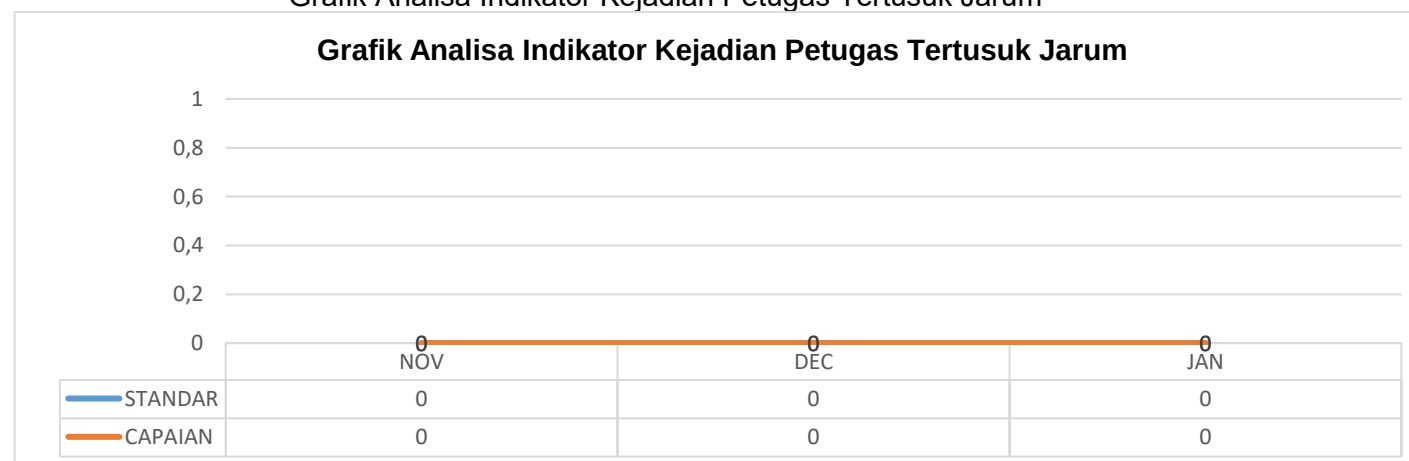
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi yang disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	- Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	- Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbarui surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	-Kepala Instalasi farmasi -Pengadaan Farmasi PT	- Satu bulan

d. Manajemen Resiko

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	2	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0

1) Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

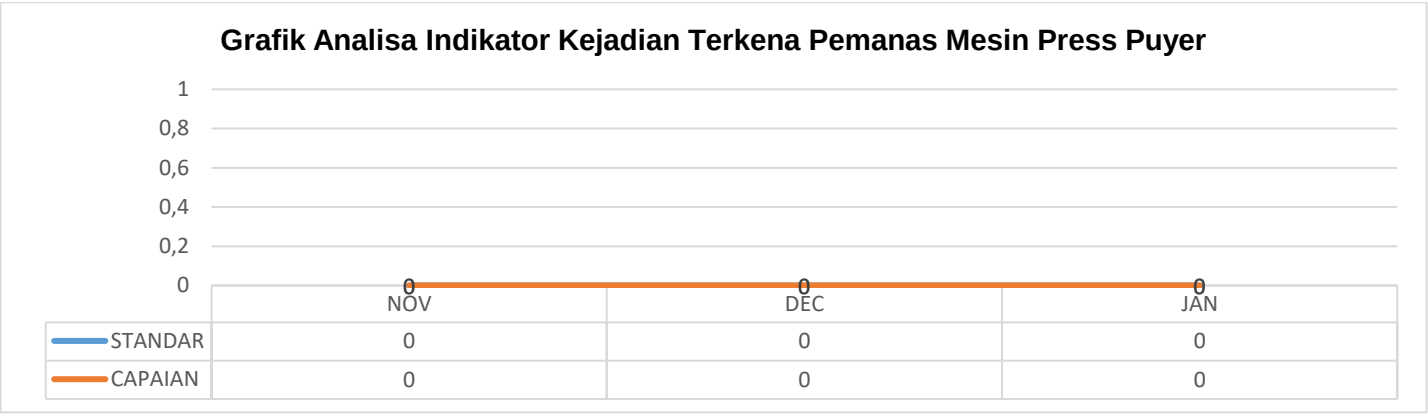


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum.

24. Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer.

1. Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	96,32%	96,41%	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0%	0%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	87,16%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	3,03%	1,15%	0,7%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	100%	100%	100%

2. IRNA 2C

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	97,06%	89,15%	93,41%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	66,67%	69,23%	80%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	96,8%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	3,45%	4,26%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%			94,7%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%			86,49%

3. IRNA 3A

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,37%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	95,13%	95,12%	93,18%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-

4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,75%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%			84,96%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%			-

4. IRNA 4A

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	96,58%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	71,31%	66,7%	94,84%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	78,43%	93%	71,83%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	1,4%	0,75%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%			100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%			-

5. IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	95,92%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	14,74%	43,48%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%			100%

7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%			-
----	---	------	--	--	---

6. IRNA 5C

No	Judul	Stand	Nov '24	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	63,06%	65,59%	62,07%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	1,41%	0,54%	0,54%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%			99,13%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%			-

7. IRNA 6A

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	14,8%	55,06%	61,11%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	97,82%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0,14%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%			100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%			100%

8. IRNA 7A

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	10,2%	65%	58,22%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	76%	100%	96,67%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%			100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%			-

9. IRNA 8A

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	14,28%	73,3%	54,39%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	97,2%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%			100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%			-

10. ICU

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	92,18%	98,07%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,2%	96%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	86,44%	87,75%	81,8%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	-	100%

6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	1,56%	1,92%	-

11. HCU

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	52,9%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	41,17%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%

12. IRJA

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,75%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	91,73%	91,73%	95,2%
3	Angka Keterlambatan Dokter Di poli Rawat Jalan	0%	15,82%	14,73%	15,58%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%

13. Maternitas

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%

3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	100%	100%	99,44%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	0	1
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	1	6	3
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	6,87%	7,63%	3,82%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	0%	7,56%	3,82%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%

14. NICU

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	89,25%	82,98%	85,92%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%

6	Angka Kematian Bayi	0	0,81%	0%	0%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	15	13	0

15. IKO

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	96,65%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi > 30 menit	0	3	0	0
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)				0

16. Laboratorium

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,58%	98,88%	98,69%

3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	11	6	3
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%			0%

17. Radiologi

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	5,27%	3,15%	3,72%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0			1

18. Gizi

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,76%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	1
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	3	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan				0

19. Farmasi

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	1	1

4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	57,33%	65,43%	68,81%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	28,78%	44,7%	41,48%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0

20. Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,51%	0,27%	0,27%

21. PPI

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,77%	0,31%	0,24%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,41%	0,18%	0,28%

6.	Decubitus	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,96%	85,97%	85,86%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	92,57%	92,77%	93,04%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,64%	91,35%	91,91%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	2	0

22. PIPP

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	99,53%	99,19%	100%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)				86,94%

23. SDM

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	2	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	99,41%	98,42%	98,99%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,17%	2,97%	3,32%

24. Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0,02%	0%	0%
2.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0			0
3.	Kelengkapan Inform Consent Setelah Mendapatkan Informasi (Indikator baru	100%			100%

	2024)				
4.	Kejadian pasien tidak di SEP (Indikator baru 2024)	0			0
5.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%			100%

25. Keuangan

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	2,28%	12,96%	7,7%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0

26. K3RS

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0

27. Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	0,42%	0,45%	1,07%
2	Angka kelengkapan dokumen rekam medik pasien BPJS rawat inap	100%	25,79%	24%	26,59%
3	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	2,53%	1,82%	1,69%
4	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%			9,73%
5	Keterlambatan pengumpulan DRM pasien rawat inap lebih dari 24 jam (Indikator baru 2024)	0%			3,92%

28. IPSRS

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	100%	100%

29. UMUM

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	3	3
2	Ketidapatuhan pengambilan barang oleh unit	0	1	5	4

30. Cleaning Service

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka ketidapatuhan penggunaan spillkit	0%	0,22%	1,39%	0,25%

31. KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 3 setiap bulannya	0%	46,97%	12,5%	2,28%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	45,95%	0%	25%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	11,11%	0%	65%

32. Laundry

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0,25%	1,14%	0%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0

33. CSSD

No	Judul	Stan	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	1
2	Kejadian instrument kurang	0	2	0	1

34. Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Nov '23	Des '23	Jan '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	100%	100%	99,17%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%			93,71

35. IT

No	Judul	Standart	Jan '24
1	Kejadian downtime	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan komputer < 15 menit	100%	96,97%

36. Kamar Jenazah

No	Judul	Standart	Jan '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%

E. Permasalahan Rumah Sakit Rumah Sakit

1. Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Ada perawat asisten yang cuti dan meningkatnya pasien operasi pada bulan januari sehingga menyebabkan perawat kelelahan	P	Mencari pengganti sementara dari rawat inap untuk menghendel operasi dari iko
		D	Memploting perawat dari irna ke iko sehingga pelayanan di IKO berjalan sesuai dengan spo
		S	Monitoring secara rutin perawat yang pindah di IKO
		A	Mengevaluasi hasil perawat yang sudah perbantuan di IKO
2	Adanya selisih Floor Stok di IKO yang meningkat dibanding bulan sebelumnya	P	Memperbaiki system Floor Stok di IKO
		D	Membuat alur dan SPO yang tepat untuk penggunaan obat dan BMHP di farmasi
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka Inst Farmasi untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Langsung melakukan pencatatan dan melakukan pelaporan untuk stok obat dan BMHP yang terdapat selisih

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Angka APS masih tinggi	P	Melaporkan ke bagian manajemen untuk tindaklanjutnya
		D	Berkoordinasi dengan PIPP untuk mengatasi APS yang ada di unit IGD
		S	Mengawal proses ini sehingga tidak terjadi kenaikan lagi untuk pasien APS
		A	Menindaklanjuti /Mengevaluasi setelah berkoordinasi dengan pipp untuk angka APS

3. Permasalahan Rawat Inap

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Meningkatnya jumlah pasien di rawat inap dan kurangnya jumlah jaga perawat	P	Memberi usulan ke bagian SDM untuk perekrutan perawat
		D	Melakukan penempatan perawat baru yang kekurangan perawat di rawat inap

2	Pasien tidak mengenali perawatnya	S	Melakukan supervisi atau monitoring perawat baru yang di tempatkan di rawat inap
		A	Mengevaluasi perawat baru dan memberikan tugas perbaikan pelayanan di rawat inap
		P	Membuat pelatihan komunikasi efektif evaluasi bagaimana diklat
		D	1. Menjalankan lagi operan yang tidak terlaksana 2. Mendisiplinkan lagi perawat yang tidak pakai nametag
3	Rekam medis tidak lengkap	S	Beberapa perawat tidak memperkenalkan saat akan melakukan tindakan yang akan dilakukan
		A	1. Mengadakan rapat internal antara para karu 2. Monitoring dan evaluasi setelah di jalankan oleh perawat 3. Harus selalu memakai nametag saat bekerja
		P	Kepala ruang harus selalu supervisi kelengkapan rekam medis
		D	Supervisi setiap saat oleh kepala ruang kepada rekam medis yang di kerjakan oleh stafnya
		S	Perawat tidak tertib dalam pengisian rekam medis
		A	Melakukan supervisi secara berkala sehingga rekam medis lengkap

4. Permasalahan Rawat Jalan

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Ruangan audiometri tidak kedap suara sehingga pemeriksaan audiometri tidak maksimal	P	Merencanakan / pengecekan ruangan audiometri yang kurang kedap
		D	Tim iprs segera menindaklanjuti ruangan audiometri
		S	Mengevaluasi ruangan yang ada di poli kekurangannya
		A	Kepala ruangan harus segera koordinasi dengan tim iprs untuk segera memperbaiki ruangan audiometri
2	Masih ada nama dokter yang sudah resign atau jadwal dokter yang tidak ada HFIS hari itu muncul	P	Menghilangkan nama dokter dari HFIS agar tidak terjadi salah informasi
		D	Konfirmasi ke bagian asuransi untuk menghilangkan nama dokter
		S	Memfollowup terus menerus ke bagian asuransi untuk penutupan HFIS
		A	Memastikan kembali sehingga tidak terjadi lagi
3	CT Scan rusak sehingga ada pendingan pasien	P	Mengajukan perbaikan ke manajemen PT sehingga segera di kerjakan

	rawat jalan		dengan cepat
		D	Konfirmasi ke DPJP jika CT scan di rumah sakit rusak
		S	Memfollow up perbaikan CT scan yang sudah di kerjakan vendor
		A	Mengevaluasi Ct scan yang sudah dikerjakan

5. Permasalahan Instalasi Farmasi

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Selisih stok di Depo Farmasi, Gudang Farmasi dan Floorstock IKO	P	Memperbaiki system floorstock di IKO
		D	Koordinasi dengan programmer terkait sistem IKO untuk meminimalisir terjadinya selisih dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka IFRS untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Melakukan pencatatan dan melakukan pelaporan untuk stok obat dan selisih
2	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual	P	Mengajukan penambahan fitur KPO digital
		D	Koordinasi dengan programmer perihal pengadaan KPO billing untuk target realisasi dan membantu DPJP dalam penulisan obat agar mudah terbaca.
		S	- Mempermudah PPA melihat riwayat pemberian obat. - Mengurangi complain pasien akibat pasien lupa membawa KPO.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan system KPO digital.
3	Penulisan kartu stok di Depo, IKO dan Gudang farmasi yang masih belum berjalan baik	P	Menegakkan punishment kedisiplinan penulisan kartu stok Memenuhi petugas farmasi di IKO
		D	Monitoring dan evaluasi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok Koordinasi dengan SDM terkait evaluasi kinerja
		S	Petugas lebih teliti dan disiplin ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran
		A	Kains melakukan supervise setiap hari
4	Terjadi kekosongan obat sehingga pelayanan tidak maksimal	P	Memperbaiki system ROP
		D	Melakukan evaluasi beberapa rumus ROP kemudian menetapkan rumus yang akan digunakan. Koordinasi dengan programmer untuk mengaplikasikan rumus ROP yang

			disepakati kedalam system.
		S	Mempersingkat proses order. Meminimalisir petugas kelewat order.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan rumus ROP yang sudah disepakati.

6. Permasalahan Laboratorium

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan PA	P	Memperbaiki alur penerimaan hasil PA rujukan.
		D	Koordinasi dengan Sp.PA dan analis untuk kesepakatan pengiriman hasil pemeriksaan.
		S	Mempercepat proses klaim.
		A	1. Menghubungi dr Berlian, Sp.PA untuk kesepakatan hasil pemeriksaan maksimal 4x24 jam sesuai SPO. 2. Analis melakukan pencatatan dan follow up hasil sebelum batas waktu maksimal.

7. Permasalahan Rekam Medis

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Tidak bisa menarik data asuhan gizi rawat jalan karena belum terdapat fitur di RM-e	P	Memiliki fitur asuhan gizi di rawat jalan untuk kebutuhan pelaporan internal dan Dinkes.
		D	Permintaan fitur ke programmer sudah dilakukan, menunggu antrian.
		S	Ahli Gizi bisa menyampaikan hasil asuhan gizi pasien rawat jalan di RM-e untuk kebutuhan penarikan data oleh Instalasi RM dan pelaporan.
		A	Follow up ke Programmer.
2	Kelengkapan ERM rawat jalan belum mencapai standar	P	Membuat list kekurangan form rawat jalan dan permasalahan ERM rawat jalan, kemudian diserahkan ke Programmer.
		D	1. Mengisi permasalahan yang ditemukan di link google spreadsheet. 2. Koordinasi dengan Programmer untuk ditindaklanjuti.
		S	Memudahkan DPJP dan PPA dalam melakukan pengisian.

		A	Koordinasi dengan Programmer.
3	Keterbacaan tulisan dokter belum mencapai standar	P	Menjalankan ERM rawat inap di Tahun 2024, bridging dengan satu sehat.
		D	Mengikuti progress. Koordinasi dengan Programmer target realisasi ERM rawat inap.
		S	1. Memudahkan PPA membaca tulisan/advice DPJP. 2. Memudahkan petugas rekam medis melakukan analisa.
		A	Koordinasi dengan Programmer.

F. Profil SDM
a. Komposisi dan Distribusi SDM

NO	UNIT	PENDIDIKAN	JANUARI				
			TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	Bidan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMA	34	7	0	7	0
		D3 farmasi		12	3	9	0
		S1 Farmasi		4	1	3	0
		D3 Analisis Kimia		1	0	1	0
11	Asuransi Center	S1 Apoteker	11	10	0	10	0
		SMA		2	2	0	0
		D3 Kes		3	0	3	0
		D3 RMIK		5	2	3	0
		D3 Asuransi Kes		1	0	1	0
12	CSSD	D4 RMIK	4	0	0	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
13	Fisioterapi	SMA	4	3	1	2	0
		D3 Fisioterapi		1	0	1	0
14	Gizi	D4 Terapi Wicara	6	2	0	2	0
		SMA		2	1	1	0
		D3 Gizi		2	2	1	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
15	Humas & Marketing	S1 Gizi	2	2	0	2	0
16	ICU dan HCU	SKM	15	2	0	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		5	0	5	0
17	IGD	Profesi Ners	22	9	4	5	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Keperawatan		9	1	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
18	IKO	Profesi Ners	11	8	1	7	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
19	IPCN	Profesi Ners	1	6	3	3	0
20	IPSRs	Profesi Ners	1	1	1	0	0
		D3 TEM	1	1	0	1	0
		SKM	1	1	0	1	0
		S1 Teknik	4	1	0	1	0
27	IRJA	SMA	25	3	1	2	0
		D3 Kebidanan		5	3	2	0

		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		Profesi Ners		6	3	3	0
28	IRNA 2C	D3 Keperawatan	8	2	0	2	0
		Profesi Ners		6	1	5	0
29	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	21	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		3	0	3	0
30	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	3	5	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
31	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	18	9	0	9	0
		Profesi Ners		9	2	7	0
32	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	6	0	6	0
		Profesi Ners		4	0	4	0
33	Maternitas	D3 Kebidanan	11	9	9	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
35	Keuangan dan Akuntansi	SMA	9	4	1	3	0
		S1		4	3	1	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
36	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
37	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
38	Rekam Medik	D3 Kesehatan	10	1	0	1	0
		D3 RMIK		8	4	4	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
39	Pendaftaran	SMA	15	8	1	7	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D4 Manajemen		1	0	1	0
40	PIPP	Ners	4	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
41	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
42	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
43	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
44	Sekretaris	S1 Administrasi Perkantoran	1	1	0	1	0
45	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	4	4	0	4	0
46	Umum	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
47	Cleaning Service	SMP	41	3	1	2	0
		SMA		38	5	33	0
48	Security	SMA	11	11	4	7	0
49	Driver	SMA	5	5	1	4	0

50	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
51	Orientasi Bidan dan Perawat	D4 Kebidanan	13	2	0	2	0
		Profesi Bidan		1	0	1	0
		D3 Perawat		9	0	9	0
		Profesi Ners		1	0	1	0
52	Dokter Spesialis Anak		2	2	0	2	0
53	Dokter Spesialis Syaraf		3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Jantung		2	2	0	2	0
55	Dokter Spesialis Paru		1	1	0	1	0
56	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		4	4	0	4	0
57	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Bedah		2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Orthopedi		1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Mata		2	2	0	2	0
65	Dokter Spesialis Urologi		1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
67	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	4	0	4	0
68	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
69	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
70	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
71	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
72	Dokter Spesialis Radiologi		3	3	0	3	0
TOTAL STAF			434	434	95	339	0

b. Update STR/SIP

No	Nama	Profesi	Tanggal Kejadian	Keterangan
1	drg. Bhakti Prasetyo Danaryudho, Sp.Ort	Dokter Gigi	24 September 2023	Menunggu SIP terbit

G. Kemajuan Piutang

a. Data Piutang yang Belum Terbayar

Tabel G.1 Rekapitulasi Klaim asuransi per Kelompok Asuransi

NO	KELOMPOK ASURANSI	TOTAL TAGIHAN	TOTAL REALISASI	SALDO AKHIR
1	ASURANSI ADMEDIKA	140.310.986	37.778.556	102.532.430
2	ASURANSI NON ADMEDIKA	411.509.273	166.041.514	245.467.758
3	PERUSAHAAN	95.091.671	36.878.415	58.213.256
4	BPJS KETENAGAKERJAAN	1.663.346.024	25.840.763	1.637.505.261
		2.310.257.953	266.539.247	2.043.718.706
		100%	12%	88%

Tabel G.2 Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Desember 2023)

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
							-
PELAYANAN 2024							
1	REGULER JANUARI 2024	7.487.434.100					7.487.434.100
	BELUM FPK						-
							-
							-
							-
		14.112.326.436			6.624.892.336	-	7.487.434.100

Tabel G.3 Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN								
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND	NILAI PENDING
1	OKTOBER 2023	RJ	12.115	12.110		5	0,0%	2.708.800
		RI	960	910		50	5%	221.153.800
2	NOV 23	RJ	11.372	11.365		7	0,1%	3.607.600
		RI	829	781		48	6%	276.469.600
3	DES 23	RJ	11.353	11.338	5	15	0,1%	12.793.800
		RI	880	769	-	111	13%	601.217.500
								1.117.951.100

b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang

NO	KELOMPOK ASURANSI	SISA PIUTANG	BELUM JATUH TEMPO	JATUH TEMPO
1	BPJS KETENAGAKERJAAN	1.637.505.261	948.268.866	689.236.394
2	MANDIRI INHEALTH	53.103.975	20.838.428	32.265.547
3	PT. JASA RAHARJA	49.202.843	49.202.843	-

Saldo Piutang terbesar dari asuransi non BPJS Kesehatan :

- 1. BPJS KETENAGAKERJAAN Pembayaran bulan januari mutasi bank 06 Februari 2024 Rp 344.893.300
- 2. Jasa Raharja Pembayaran dimutasi bank tanggal 06 Februari 2024 januari 2024 Rp 48.372.934
- 3. Mandiri Inhealth Proses Telaah dan pembayaran di Februari 2024.

c. Update IKS

No	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU		Keterangan
1	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30/01/2023	31/01/2023	BERLAKU
2	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
3	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 AGUST 2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
4	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
5	PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13/04/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
6	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21/08/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
7	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
8	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOPOP/AVR-1494/VII/2023		24/08/2023	24/08/2025	BERLAKU
9	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10/1/2022	1/10/2025	BERLAKU
10	KLINIK TIRTO HUSADA	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			3/3/2018	3/2/2024	BERLAKU
11	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			16/3/2020	3/16/2024	BERLAKU

12	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15/04/2023	15/04/2026	BERLAKU
13	Klinik Rawat Inap Wijaya Husafa	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15/04/2023	15/04/2026	BERLAKU
14	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21/07/2023	21/07/2026	BERLAKU
15	PT. JAYA OBAYASHI	Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1/7/2020	1/7/2025	BERLAKU
16	PT. PANCAMAS ELITE	Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020		1/7/2020	7/1/2025	BERLAKU
17	PT. TIRTA INVESTAMA	Pelayanan Kesehatan Karyawan & Keluarga			31/08/2020	31/08/2025	BERLAKU
18	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	perpanjang otomatis	BERLAKU
19	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Mediacak Chek Up		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26/08/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
20	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			30/03/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
21	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1/4/2013	perpanjang otomatis	BERLAKU
22	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22/04/2022	22/04/2026	BERLAKU
23	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1/11/2022	1/11/2024	BERLAKU
24	RS SITI MIRIAM LAWANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan	151.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4/10/2022	3/7/2024	BERLAKU

		Pemulasaraan Jenazah					
25	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21/02/2022	2/21/2025	BERLAKU
26	RS PANTI NIRMALA	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7/10/2022	6/10/2025	BERLAKU
27	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022	116//102.7/2022	1/11/2022	1/11/2024	BERLAKU
28	RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30/10/2021	30/10/2026	BERLAKU
29	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1/1/2023	31/12/2024	BERLAKU
30	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28/01/2020	27/01/2024	BERLAKU
31	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18/09/2019	18/09/2024	BERLAKU
32	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4/7/2022	4/7/2027	BERLAKU
33	PT AIA	Perjanjian	069/DPM/E-	639/AIA-DPM/XI/2020	4/11/2020	Perpanjang	BERLAKU

	FINANCIAL	Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS/DIR/X/2020			Otomatis	
34	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28/11/2016	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
35	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28/08/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
36	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19/09/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
37	PT. SUPRIMA MITRA ADIHUSADA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26/08/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
38	PT. EQUITY LIFE IND-CORPORATE	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
39	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
40	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	10/9/2012	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
41	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	4/9/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
42	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
43	PT. EQUITY LIFE IND-CASSLES	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14/10/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
44	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7/9/2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
45	PT. Asuransi Adira	Perjanjian	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	perpanjang	BERLAKU

	Dinamika	Pelayanan Kesehatan				otomatis	
46	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	perpanjang otomatis	BERLAKU
47	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	25/07/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
48	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28-Apr-15	perpanjang otomatis	BERLAKU
49	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10/10/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
50	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25/02/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
51	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	perpanjang otomatis	BERLAKU
52	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 MARET 2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
53	PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29/11/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
54	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31/08/2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
55	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	1/4/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
56	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	3/10/2022	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
57	PT. Kartika Bina Medikatama	Perjanjian Pelayanan	103.1/DPM/E-PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26/06/2023	25/06/2026	BERLAKU

	(Medika Plaza)	Kesehatan					
58	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan			7/2/2023	04/07/2027	BERLAKU
59	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E- PKS/DIR/III/2022		3/10/2021	3/10/2024	BERLAKU
60	BPM Suma'iyah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	686.1/E-PKS/DIR/V/2023		2/5/2023	2/5/2026	BERLAKU
61	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KB IUD, Umplant, MOW dan MOP	630/E-PKS/DOR/IV/2023	440/146/35.07.120/2023	17/01/2023	17/01/2024	BERLAKU
62	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	630/E-PKS/DOR/IV/2023	440/146/35.07.120/2023	17/01/2023	17/01/2024	BERLAKU
63	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I- PKS/DIR/I/2022		5/1/2022	5/1/2025	BERLAKU
64	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24/04/2023	27/04/2026	BERLAKU
65	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11-Sep-12	Tanpa Batas Waktu	BERLAKU
66	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3/7/2023	3/7/2026	BERLAKU
67	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31/05/2023	31/05/2023	BERLAKU
68	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16/06/2021	16/06/2024	BERLAKU

		Pasien & Penunjang					
69	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2/8/2022	2/8/2025	BERLAKU
70	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5/6/2023	5/6/2026	BERLAKU
71	PT. MALANG INTERMEDIA PERS	Pelayanan Publikasi dan penerbitan artikel	166/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	423/MOU/PMSRN/JPRM/VIII/2023	1/9/2023	1/2/2024	BERLAKU
72	PT. Bangun Sarana Wreksa	Pelayanan Kesehatan					BERLAKU
73	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1/3/2022	1/3/2024	BERLAKU
74	PT. MALANG INTERMEDIA PERS	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1/7/2020	1/7/2025	BERLAKU
75	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1/1/2023	31/12/2025	BERLAKU
76	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Karyawan Dan Keluarga	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/2020	1/6/2020	1/6/2025	BERLAKU
77	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	060.1/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	176/TSA-MOU/MD/II/2023	21/02/2023	21/02/2024	BERLAKU
78	PT. KSI	Pelayanan					BERLAKU

		Kesehatan					
79	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1/9/2022	1/9/2027	BERLAKU
80	Harris Hotel & Conventions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
81	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	1/5/2012	perpanjang otomatis	BERLAKU
82	PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	Pelayanan Kesehatan	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	1/9/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
83	PT. DUHA MULYA ABADI	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			1/11/2019		BERLAKU
84	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			10/1/2014	perpanjang otomatis	BERLAKU
85	PT. KTG (KENCANA TIARA GEMILANG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12/12/2021	12/12/2024	BERLAKU
86	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22/06/2023	22/06/2026	BERLAKU
87	PT. ETERCON PHARMA	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1/6/2023	1/6/2024	BERLAKU
88	PT. RENTOKIL	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E-PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11/9/2023	11/9/2024	BERLAKU
89	PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8/6/2021	8/6/2024	BERLAKU

		Penunjang					
90	PT. TSSA (Teman Sejati Sejahtera Abadi)	Pengelolaan Limbah B3	0175/LGL-PK/DPM-TSSA-AMP/II/2023		6/2/2023	6/2/2024	BERLAKU
91	PT. NAYAKA ERA HUSADA	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30/05/2023	30/05/2025	BERLAKU
92	PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)	Layanan Antar Obat Pasien	138.2/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/MLG/23-24	15/06/2023	15/06/2024	BERLAKU
93	PT. Global Trans Jaya Mulia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	060.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023	1/4/2023	31/03/2024	BERLAKU
94	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/VI/2023	0	1/6/2023	1/6/2024	BERLAKU
95	RS LAVALETTE	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10/8/2023	10/8/2025	BERLAKU
96	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16/09/2022	15/09/2024	BERLAKU
97	RS SAHABAT	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	perpanjang otomatis	BERLAKU
98	RSU MUHAMMADIYAH (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21/08/2023	21/08/2024	BERLAKU
99	RS Persada	Pelayanan Kesehatan,	152.42/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10/10/2022	10/10/2027	BERLAKU

		Rujukan, Laboratorium dan Radiolog					
100	PT. ASURANSI DAYIN MITRA TBK		003/MKT/HLT/PKS/I/2015	PH/IKS/269/XII/2014	5/1/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
101	PT. PILLAR UTAMA CORTINDO	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1/7/2023	30/06/2024	BERLAKU
102	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3/10/2023	3/10/2026	BERLAKU
103	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1/11/2023	1/11/2026	BERLAKU
104	PT. ASURANSI JIWA BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10/10/2023	10/10/2028	BERLAKU
105	PT. ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15/06/2023	15/06/2026	BERLAKU
106	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN	1769/E-PKS/DIR/XII/2022	454/KTR/VII-05/1222	1/1/2022	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI BPJS
107	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1164/02.06.28/UDD/PKS/X/ 2021		01 Januari 2022	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI PMI
108	RS ISLAM UNISMA MALANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraa n Jenazah	1097.1/E- PKS/DIR/VIII/2021	57/PKS/RSI-4/X1/2021	2/8/2021	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI UNISMA

109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		31/12/2023	PROSES PERMOHONAN
110	Meditap (PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA)	Asuransi Pelayanan Keshatan					PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHA RUAN PKS
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan					PROSES TTD DILUAR
112	BPM Yuniarti	Rujukan Asuhan Pasien					PROSES TTD DILUAR
113	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan					PROSES DISPOSISI SIM
114	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATA N DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAA N KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF					PROSES DISPOSISI SIM
115	Klinik Simpang Sulfat	Rujukan Asuhan Pasien					PROSES DISPOSISI SIM
116	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protesa Ortesa					PROSES DISPOSISI SIM

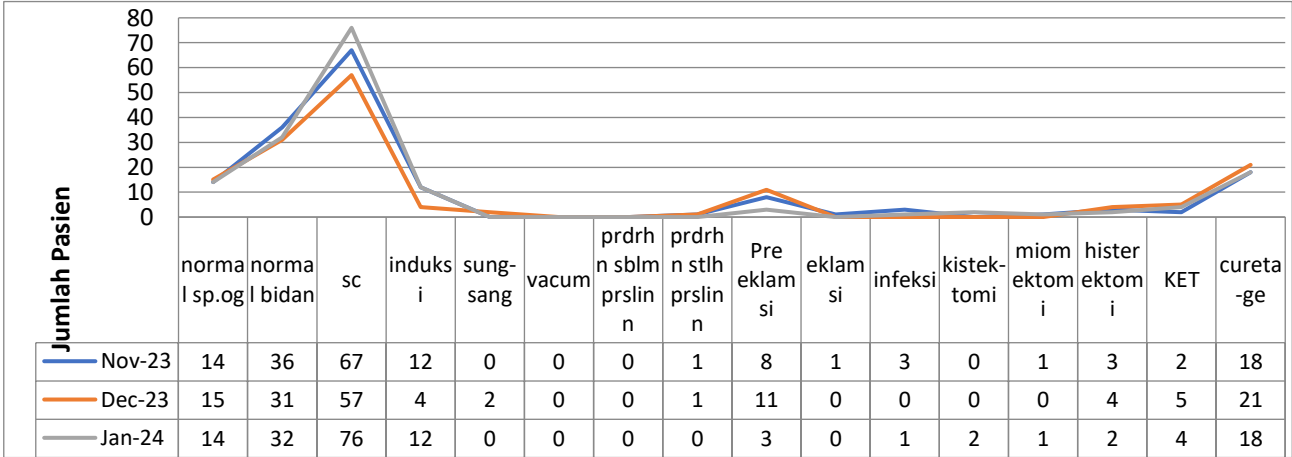
H. Program Nasional

- a. Ponек
Kinerja Dan Produktivitas
a) Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel. Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponек Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	14	15	14
	b. Persalinan Normal Bidan	36	31	32
	c. SectioCaesaria	67	57	76
2				
	a. Induksi / Drip	12	4	12
	b. Sungsang	0	2	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	1	0
	c. Pre Eklamsi	8	11	3
	d. Eklamsi	1	0	0
	e. Infeksi	3	0	1
4				
	a. Curretage	18	21	18
	b. Kistektomi	0	0	2
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	3	4	2
	e. KET	2	5	4

Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 76 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan Januari 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada bulan Desember 2023 yaitu 14 pasien. sedangkan yang ditolong oleh bidan pada bulan Januari meningkat jika dibandingkan bulan Desember 2024 yaitu 32 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
- 2) Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- 3) Induksi Persalinan pada bulan Januari mengalami peningkatan dibandingkan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 12 pasien.
- 4) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Januari mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 3 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Desember maupun Januari, sedangkan pada bulan November sebanyak 1 pasien.
- 5) Jenis pelayanan curretage di bulan Januari 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu 18 pasien. Curetage dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometoragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

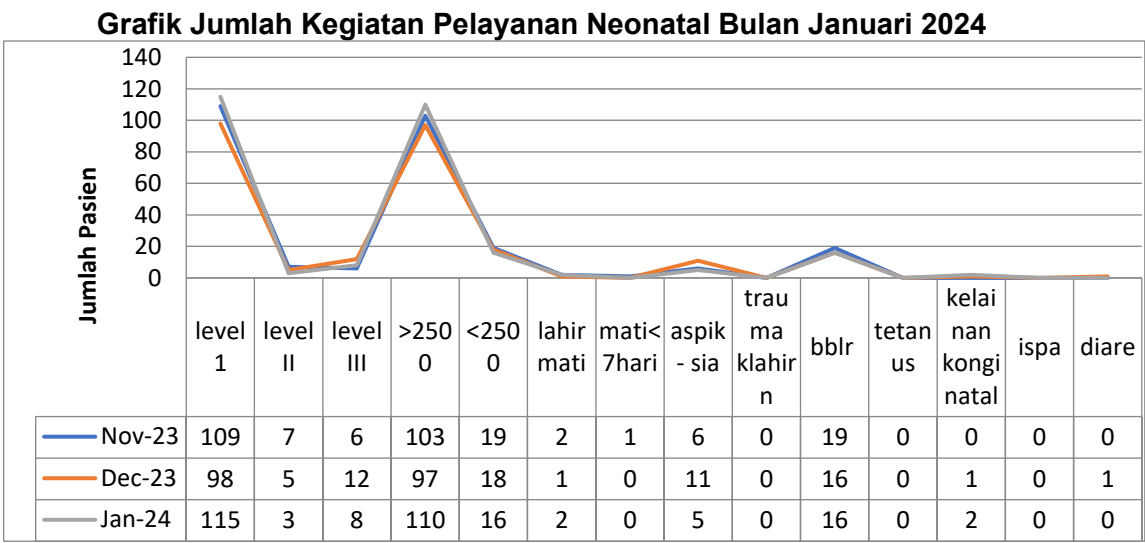
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

b) Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1				
	a. Level I	109	98	115
	b. Level II	6	5	3
	c. Level III	1	12	8
2				
	a. ≥ 2500 gram	103	97	110
	b. ≤ 2500 gram	19	18	16
3				
	a. Kelahiran Mati	2	1	2

	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	0	0
4	a. Asphyxia	6	11	5
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	19	18	16
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	1	2
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	1	0
5	Lain-lain	0	0	0



Evaluasi

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Januari 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 115. Sedangkan level 2 pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Sedangkan pada level 3 pada bulan Januari 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.
- 2) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 110 bayi.
- 3) Dan masih terdapat jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4) Kasus BBLR pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 16 bayi.
- 5) Terdapat kasus kelahiran mati pada bulan November 2023 dan Januari 2024 sebanyak 2 kasus, sedangkan pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 kasus.
- 6) Tidak Ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Desember 2023 maupun Januari 2024, sedangkan pada bulan November terdapat 1 kasus.

Rencana dan Tindak Lanjut :

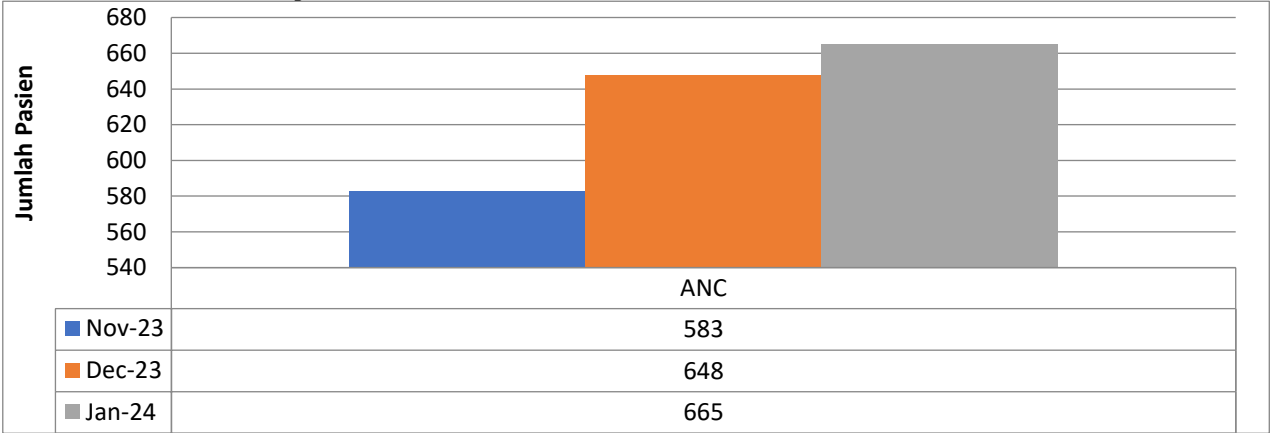
- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

c) Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	ANC	583	648	665

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

Pelayanan ANC pada bulan Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 665 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

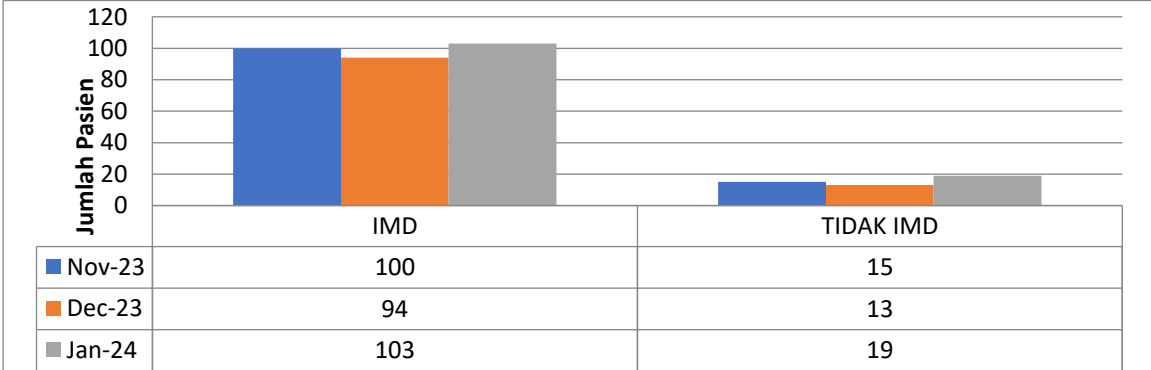
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

d) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	IMD	100	94	103
2	Tidak IMD	15	13	19

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 103 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2) Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Januari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 19 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3) Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :

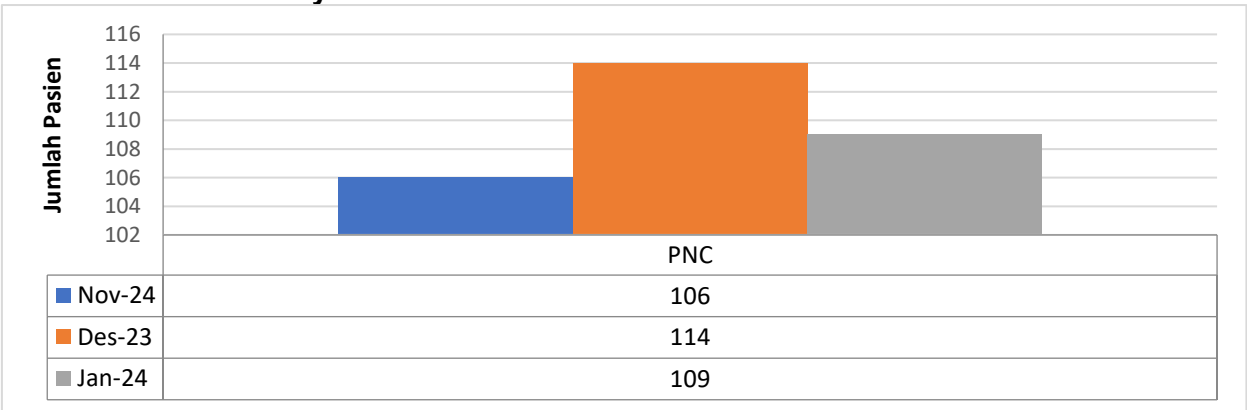
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

e) Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	PNC	106	114	109

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

Pelayanan PNC pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 109 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

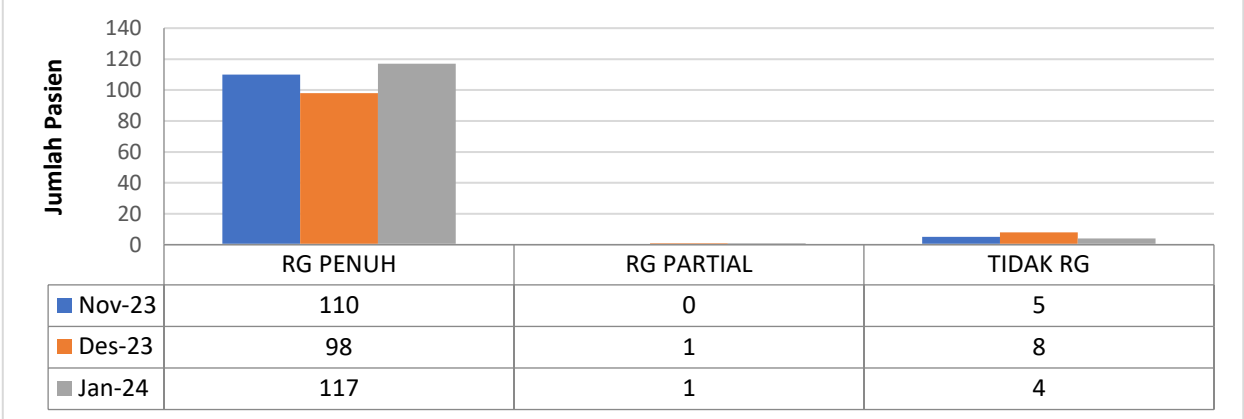
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

f) Pelayanan Rawat Gabung

Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM Januari 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	Rawat gabung penuh	110	98	117
2	Rawat gabung partial	0	1	1
3	Tidak Rawat gabung	5	8	4

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Januari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 117 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 4 bayi.
- 3) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

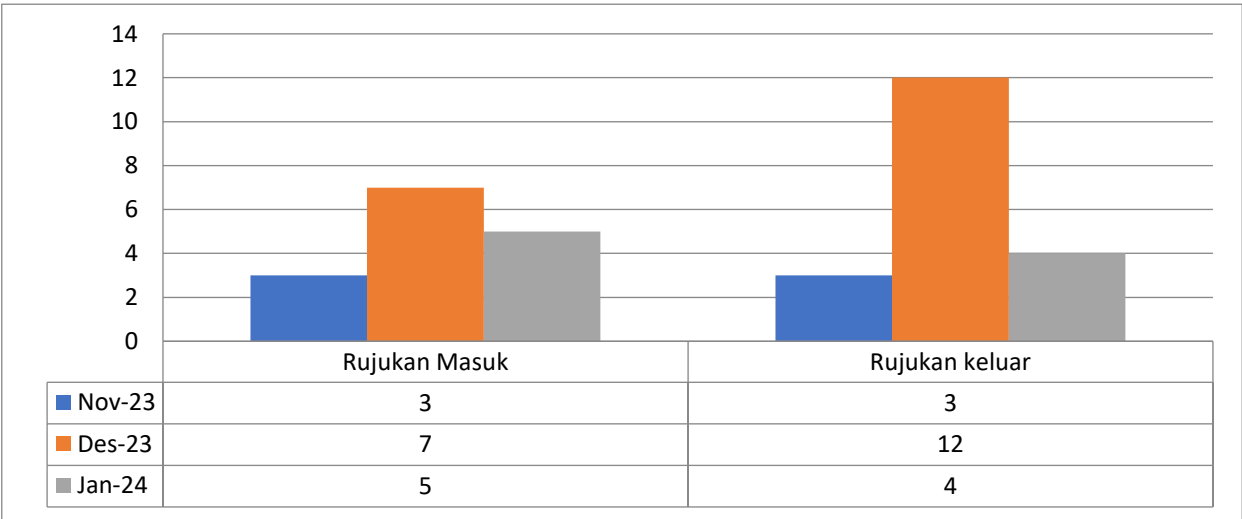
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

g) Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek Januari 2024

NO	RUJUKAN	BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	Rujukan Masuk	3	7	5
2	Rujukan keluar	3	12	4

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Januari 2024

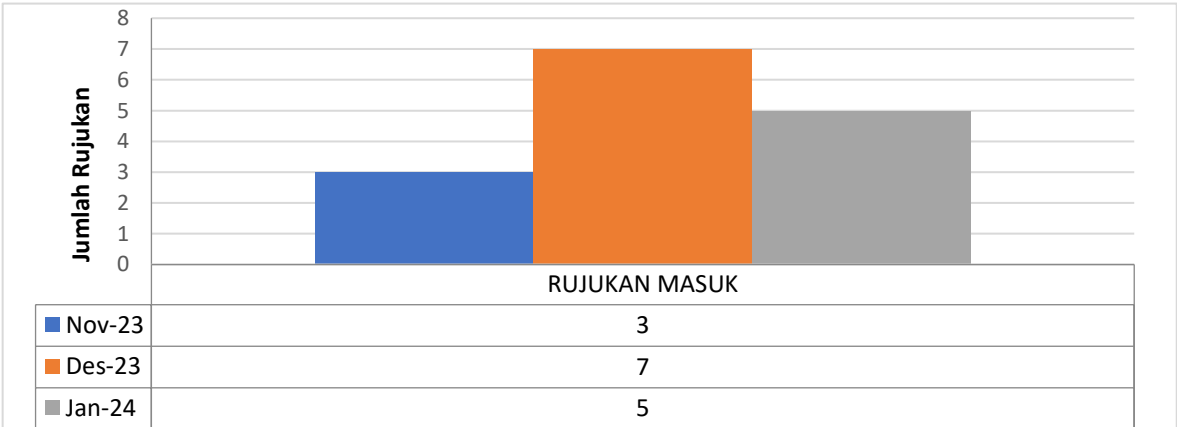


h) Rujukan Masuk

Tabel Rujukan Masuk Ponек Januari 2024

Bulan November 2023		
1	G2 P0101 Ab000 uk 30-32 mgg dg KIFA + PPR0M	RS Sumber Sentosa
2	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD	Klinik Mutiara Sehat
3	G1 P0000 ab000 UK 30-32 mgg dg PPI	PMB Indi,S.Tr.Keb
Bulan Desember 2023		
1	G1 P0000 Ab000 uk 40-41 mgg dg fetal distres	PMB Titik
2	G1 P0000 Ab000 Uk 30-32 mgg dg PPI + HT Gestasional	PMB Yena
3	G2 P1001 Ab000 uk 28-30 mgg dg PPI	Pustu Bida Yeni
4	Asfiksia, TTN	RS Siti Miriam
5	Asfiksia	RS UMM
6	Asfiksia, BBLR	RS UMM
7	Asfiksia, Hepatomegali	RS UMM
Bulan Januari 2024		
1	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
2	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
3	G1 P0000 Ab000 UK : 40 mgg dengan DJJ Irregular	BPM Titik
4	G1 P0000 Ab000 UK : 32 mgg dg Susp. Inpending Eklamsia	BPM Yena
5	G2 P1001 Ab000 UK 28-30 mgg dg Susp Plasenta Letak Rendah	PKM Pembantu desa Dengkol

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Januari mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

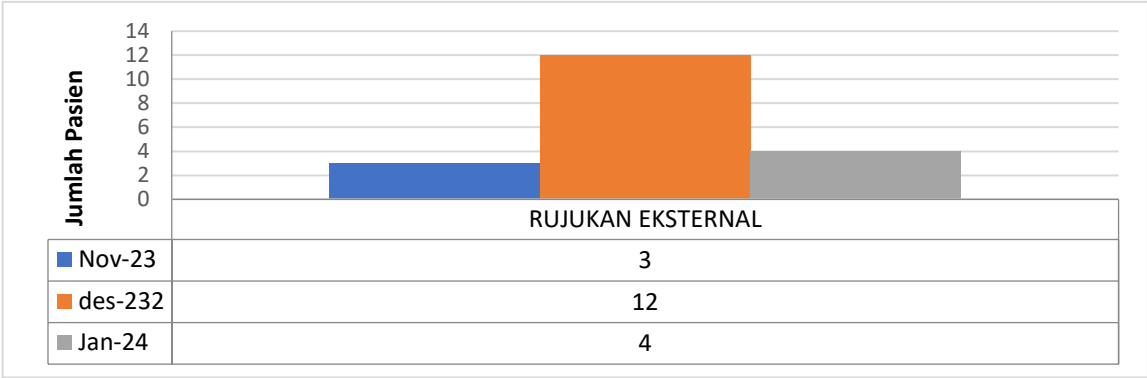
i) Rujukan Keluar

Tabel Rujukan Keluar Ponек RSPHM Januari 2024

Bulan November 2023		
1	G1 P0000 Ab000 32-34 mgg dg Eklamsi	RSSA
2	Bronchopneumonia + BBLR + NKB + NEC	RSSA
3	Bronchopneumonia + BBLR + NKB + Susp NEC	RS. Lavalette
Bulan Desember 2023		
1	G1 P0000 Ab000 uk 30-32 mgg dg PE + ASD + PH	RSSA
2	G1 P0000 Ab000 Uk 30-32 mgg dg PEB + Kelainan Kongenital	RSSA
3	P0202 Ab000 dg Retensio Plasenta	RSSA

4	Mola Hidatidosa dd PTG + HT + PVC	RSSA
5	G5 P1001 Ab300 Uk 10-12 mgg dg HEG + DM + HT + KAD	RSSA
6	Neonatus Hipoglikemi	RSSA
7	BBLR + Asfiksia	RST Soepraoen
8	Asfiksia	RS LAvalette
9	NKB + BBLSR + Asfiksia + Atelektasis lobus superior paru kanan	RSSA
10	NKB + Asfiksia	RS Lavalette
11	NKB + BBLSR	RS LAvalette
12	NKB + BBLSR + Atresia Ani	RSSA
Bulan Januari 2024		
1	NKB + Atresia Ani + susp PJB	RSSA
2	G3 P1001 Ab100 Uk : 24-26 mgg dg PPROM + Plasenta Previa+ BSC + Letak lintang + Fetal Distres	RSSA
3	G5 P1001 Ab300 Uk : 10 – 12 mgg dg HEG + DM + HT + KAD	RSSA
4	APB + PEB curiga Inpending Eklamsi	RSSA

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

Pada bulan Januari 2024 pasien yang dirujuk keluar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Sebelumnya, yaitu 4 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut

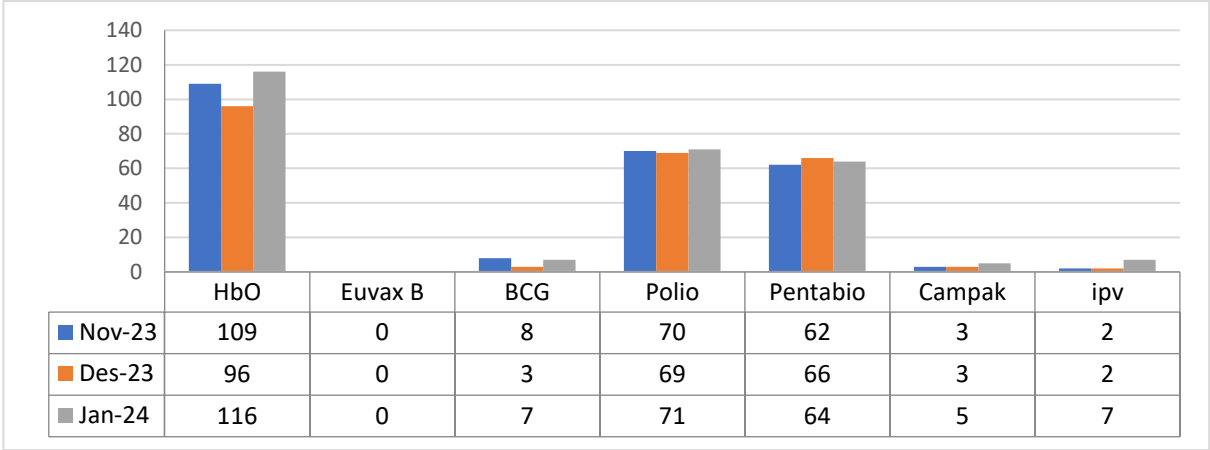
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

j) Pelayanan Imunisasi

Tabel Pelayanan Imunisasi Ponak Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	HbO	109	96	116
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	8	3	7
3	Polio	70	69	71
4	Pentabio	62	66	64
5	Campak	3	3	5
6	IPV	2	2	7

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Januari 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2) Imunisasi Hbo pada bulan Januari mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 116 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3) Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Januari meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 7 bayi
- 4) Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 7 pasien.
- 5) Bayi yang melakukan Imunisasi Campak Pada bulan Januari 2024 mengalami meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi
- 6) Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Januari 2024 mengalami meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 71 bayi
- 7) Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 64 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

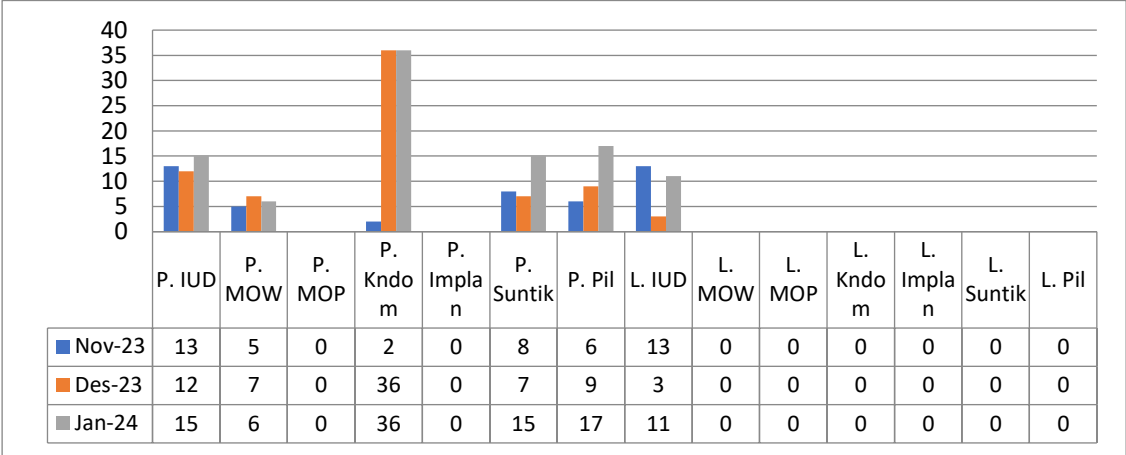
- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

k) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Januari 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024	BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	IUD	13	12	15	13	3	11
2	MOW	5	7	6	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	2	36	36	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	8	7	15	0	0	0
7	Pil	6	9	17	0	0	0

Grafik Pelayanan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Januari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 15 akseptor, yang terdiri dari IUD Nova T sebanyak 13 akseptor dan IUD Copper T sebanyak 2 akseptor
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Januari sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Desember 2023 maupun Januari 2024 tetap sebanyak 36 pasien.
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 17 pengguna
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Januari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 15 pengguna

Rencana dan Tindak Lanjut

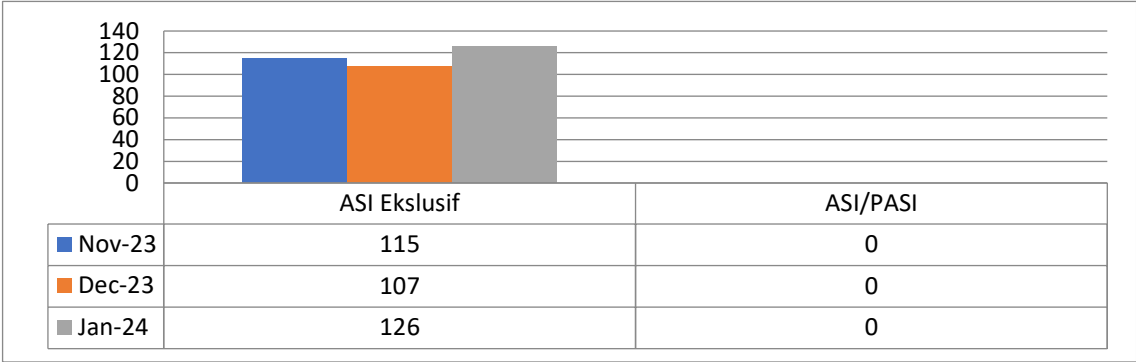
- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

I) Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Ekshlusif Ponak RSPHM Januari 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN DESEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	Asi eksklusif	115	107	126
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 126 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2) Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

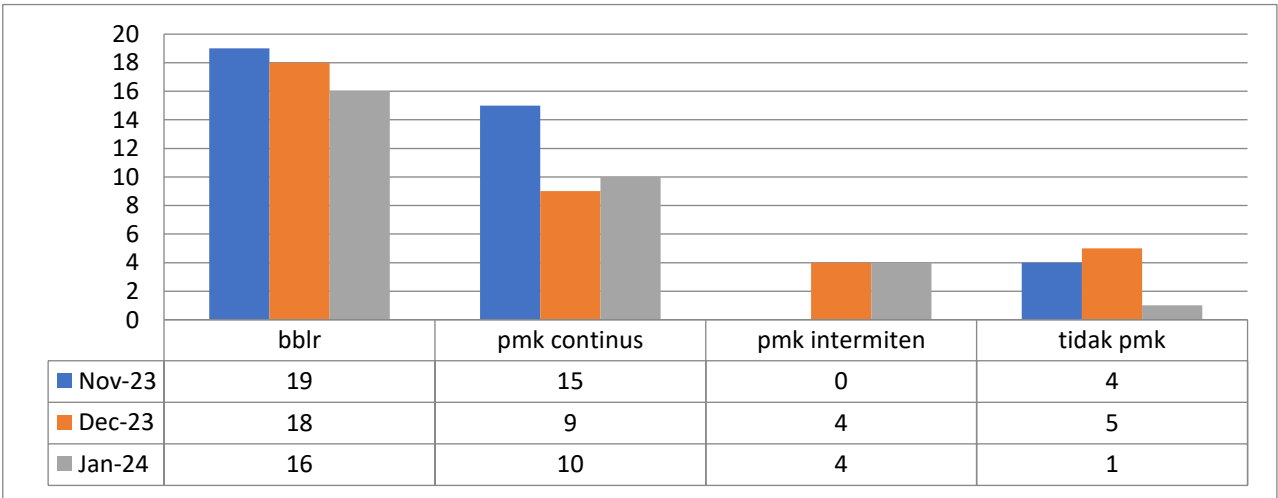
- 1) Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

m) Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponok Januari 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2023	BULAN NOVEMBER 2023	BULAN JANUARI 2024
1	Bayi BBLR	19	18	16
2	PMK continuos	15	9	10
3	PMK Intermiten	0	4	4
4	Tidak PMK	4	5	1

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Januari 2024



Evaluasi :

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2) Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Desember 2023 maupun Januari 2024 tetap sebanyak 4 bayi.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Januari 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4) Dan terdapat 1bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Januari 2024, dan menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

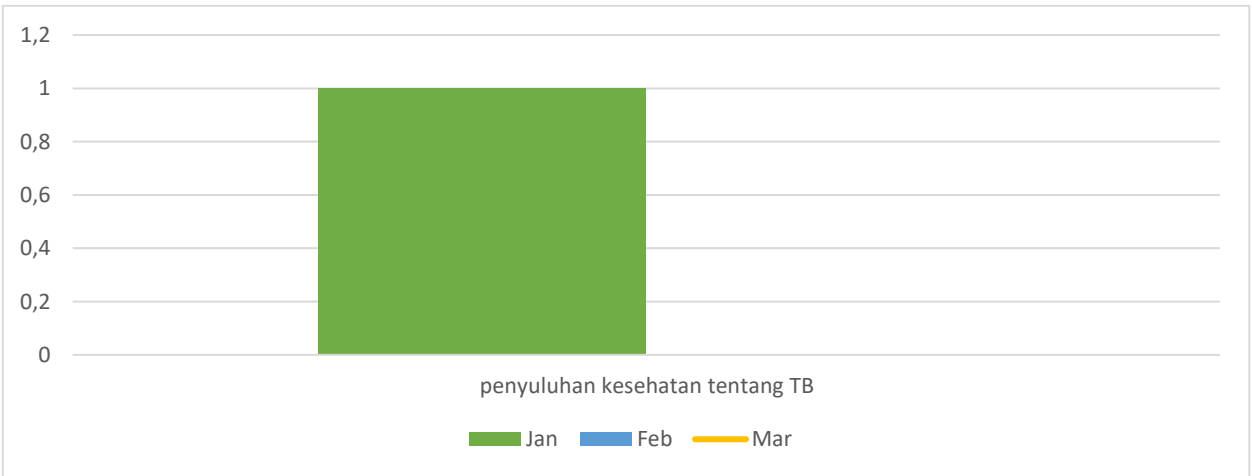
b. TB Dots

Kinerja Produktivitas

a) Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



Evaluasi :

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga paien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

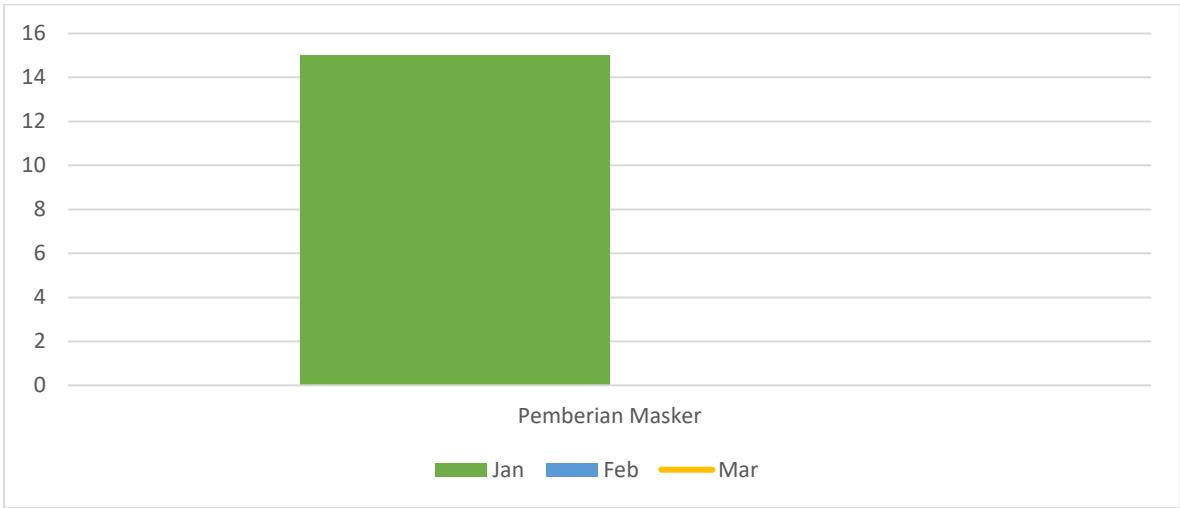
Rencana dan Tindak Lanjut

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

b) Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



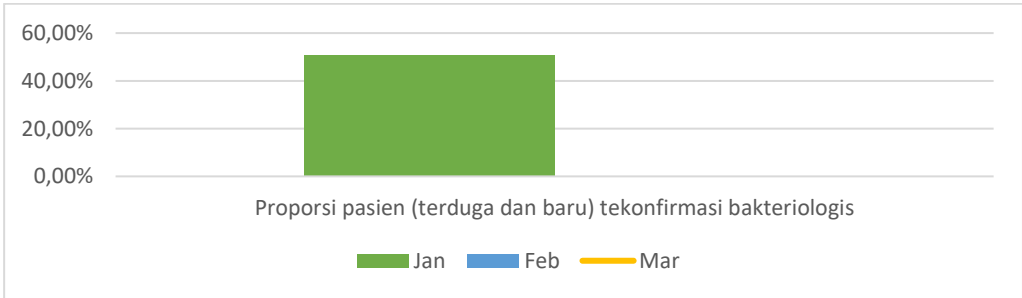
Evaluasi :
Pada bulan Januari 2024 terdapat 15 pasien yang diberika masker karena masker yangdipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1) Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

c) Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	51		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



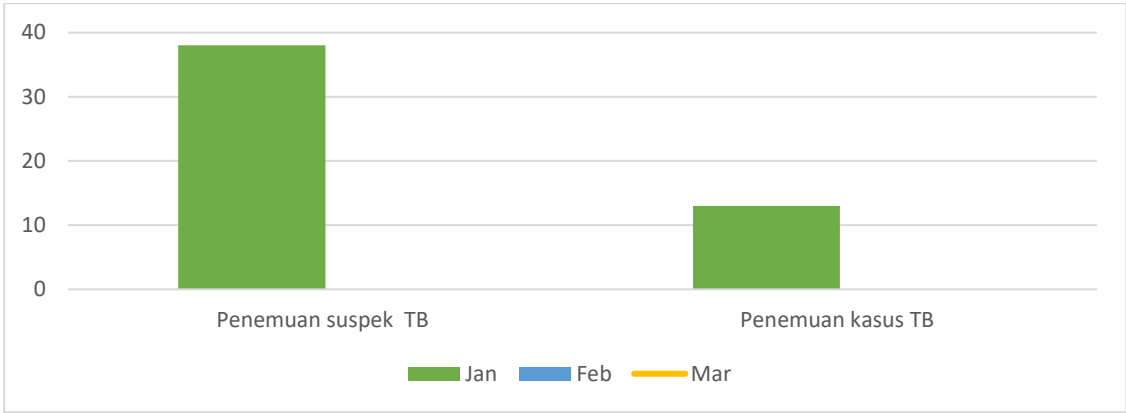
Evaluasi :
Pada bulan januari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 51 dengan Pasien baru TB terkonfirmasi bakteriologis 13 pasien, hal ini ditandai dengan banyak pasien terduga yang diperiksa tes cepat monukuler.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

d) Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	38		
2	Penemuan kasus TB	13		

**Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari – Maret 2024**



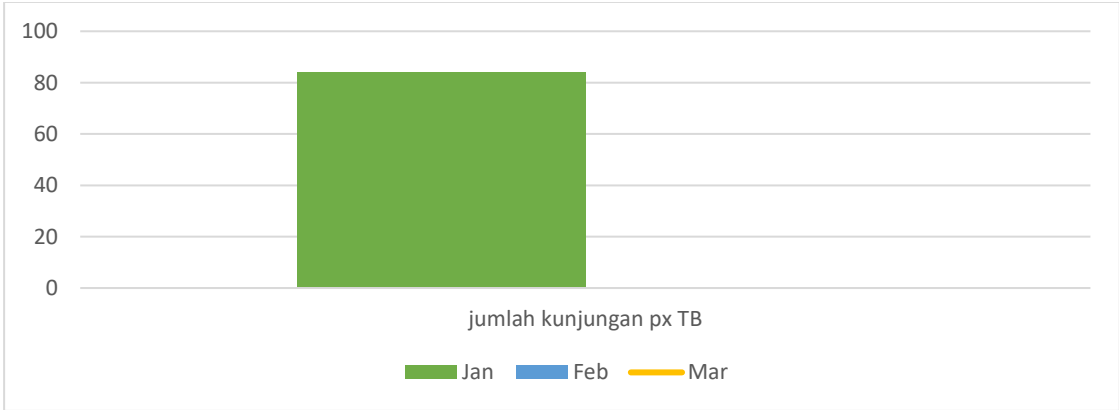
Evaluasi :
Pada bulan januari 2024 terdapat 38 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 13 pasien .

Rencana Dan Tindak Lanjut
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

e) Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	84		

**Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari – Maret 2024**



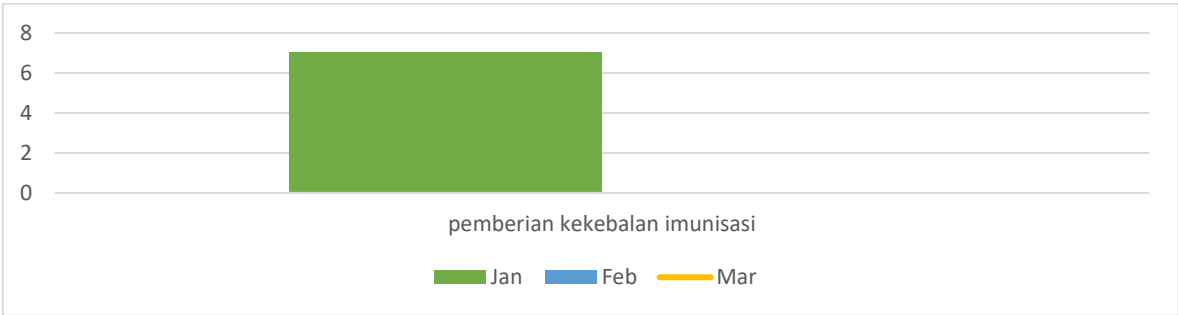
Evaluasi :
Jumlah keseluruhan kunjungan bulan januari 2024 di poli pasien TBC menjapai 84 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

f) Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	7		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



Evaluasi :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 7 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari

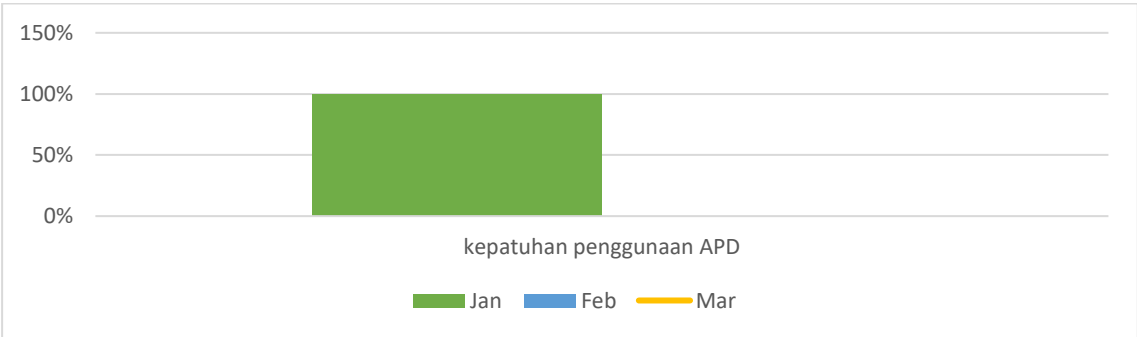
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulannya.

g) Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100 %		

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



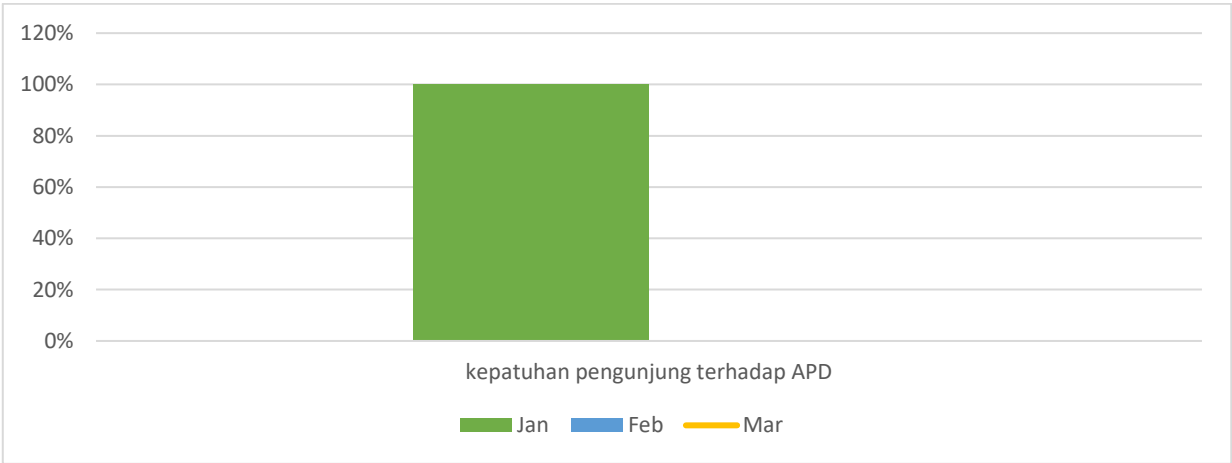
Evaluasi :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

h) Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%		

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



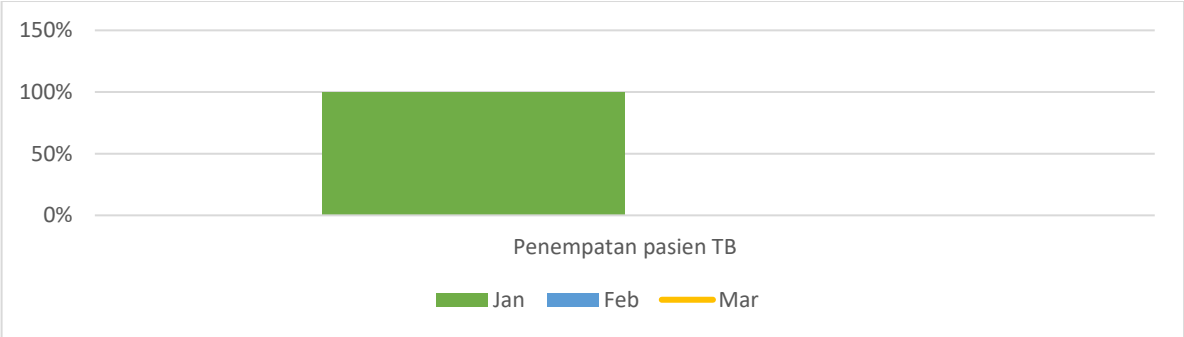
Evaluasi :
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi.

i) Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%		

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



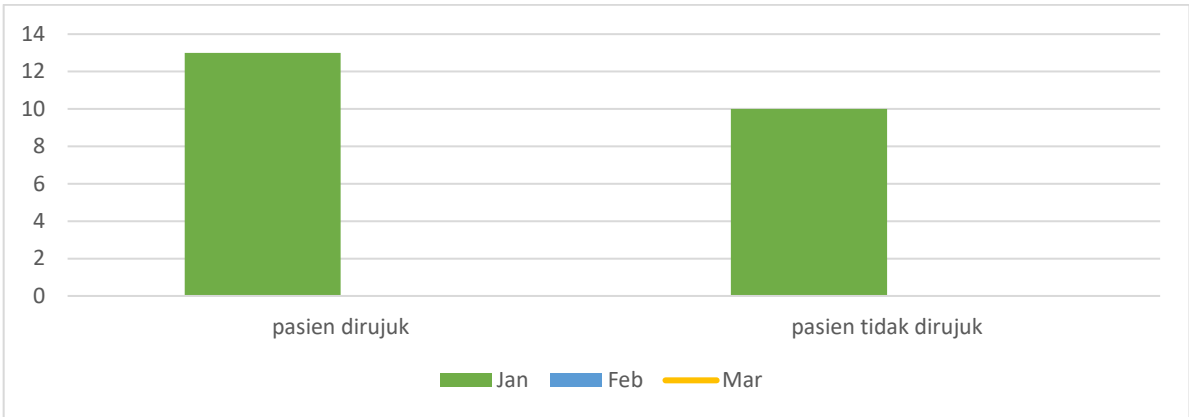
Evaluasi :
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

j) Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	13		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	10		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



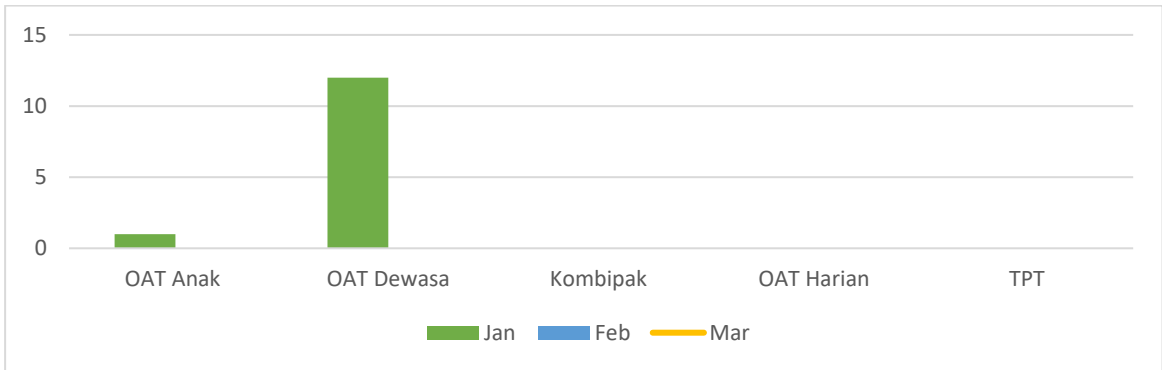
Evaluasi :
Pada bulan Januari 2024 terdapat 10 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

k) Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1		
2.	OAT Dewasa	12		
3.	Kombipak	0		
4.	OAT Harian	0		
5.	TPT	0		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



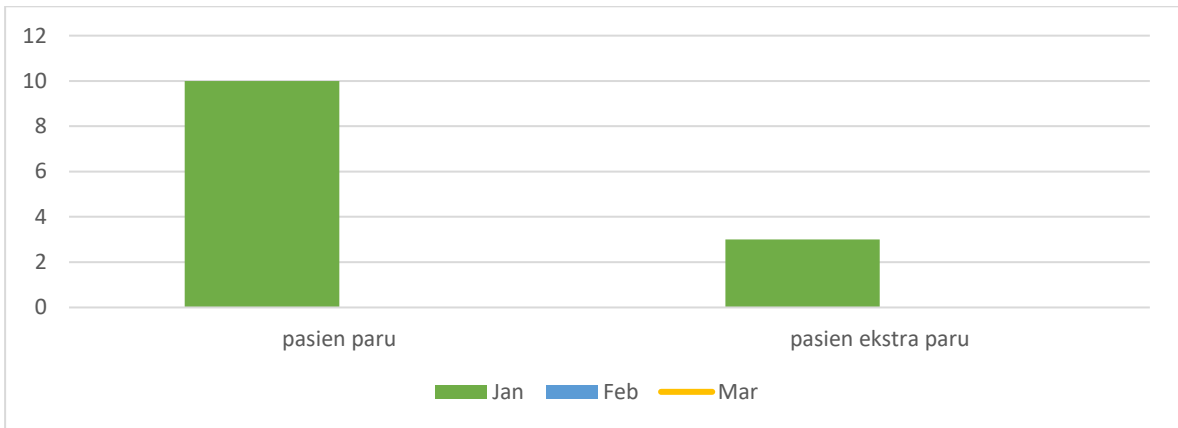
Evaluasi :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal

I) Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	10		
2.	Pasien Ekstra paru	3		

Grafik Pasien paru dan Ekstra paru Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



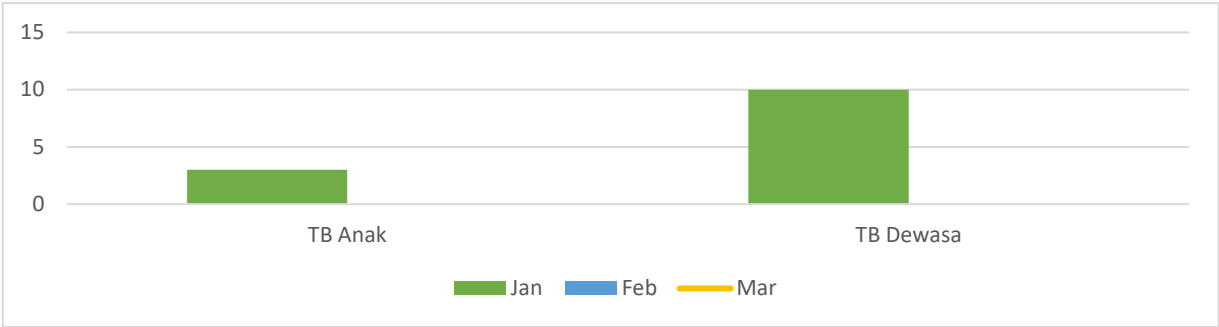
Evaluasi :
Pada bulan januari 2024 terdapat 3 pasien ekstra paru.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

m) Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	3		
2.	Pasien Dewasa	10		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari – Maret 2024



Evaluasi :
Pada bulan Januari terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 10 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

n) Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. A	V		
		Ny. S	V		
		Ny. A	V		
		Tn. S	V		
		Tn. S	V		
		Tn. H	V		
		Ny. W	V		
		Tn. A	V		
		Ny. K	V		
		Tn. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn.. E	V		

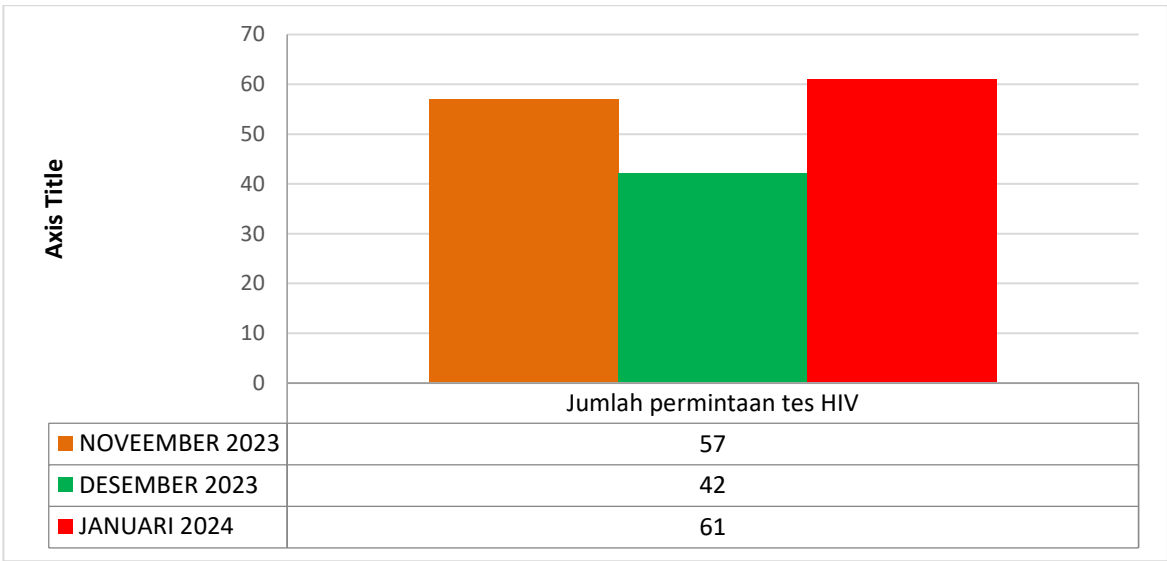
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang.

c. HIV
Kinerja dan Produktivitas
a) Jumlah permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Permintaan Test HIV	57	42	61

Grafik Jumlah Permintaan Test HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



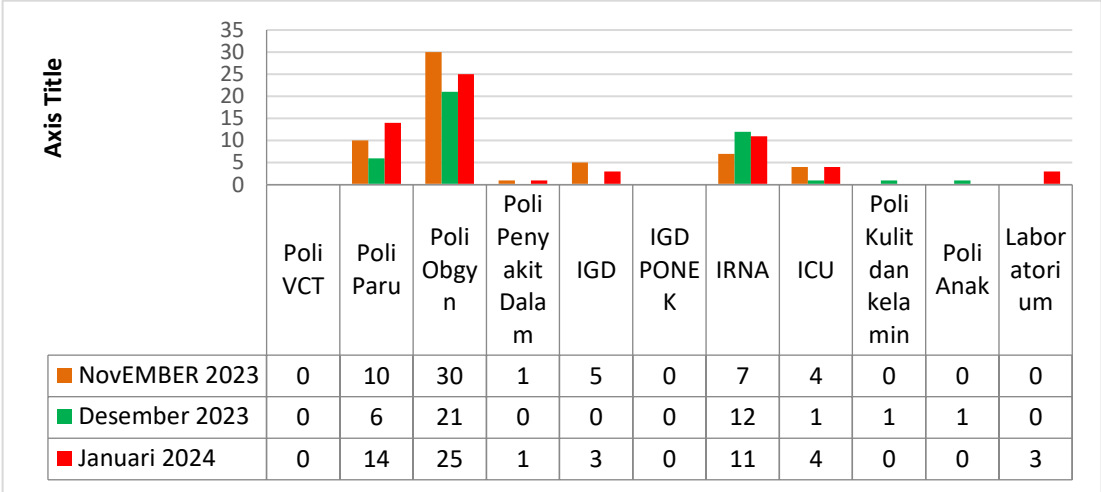
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Januari 2024 meningkat menjadi 61 pemeriksaan dibandingkan pada bulan Desember 2023 42 pemeriksaan dan bulan November sebanyak 57 pemeriksaan. hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

b) Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	10	6	14
3	Poli Obgyn	30	21	25
4	Poli Penyakit Dalam	1	0	1
5	IGD	5	0	3
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	7	12	11
8	ICU	4	1	4
9	Poli Kulit dan kelamin	0	1	0
10	Poli Anak	0	1	0
11	Laboratorium	0	0	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



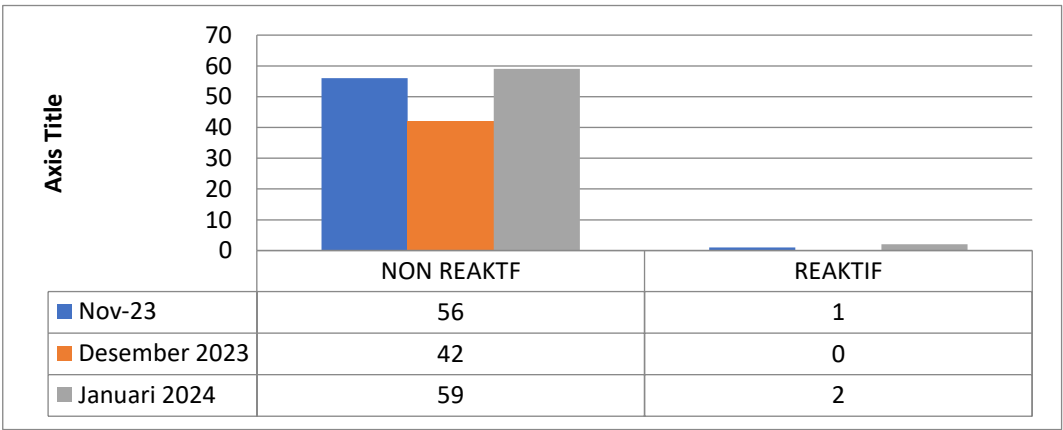
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan bulan November 2023 30 pasien, pada bulan desember 2023 sebanyak 42 pasien dan pada bulan Januari 2024 meningkat menjadi 25 pasien Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

c) Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Non Reaktif	56	42	59
2	Reaktif	1	0	2

Grafik Status HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data status HIV dengan status reaktif pada pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 pasien. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya meningkat dari 0 ke 2

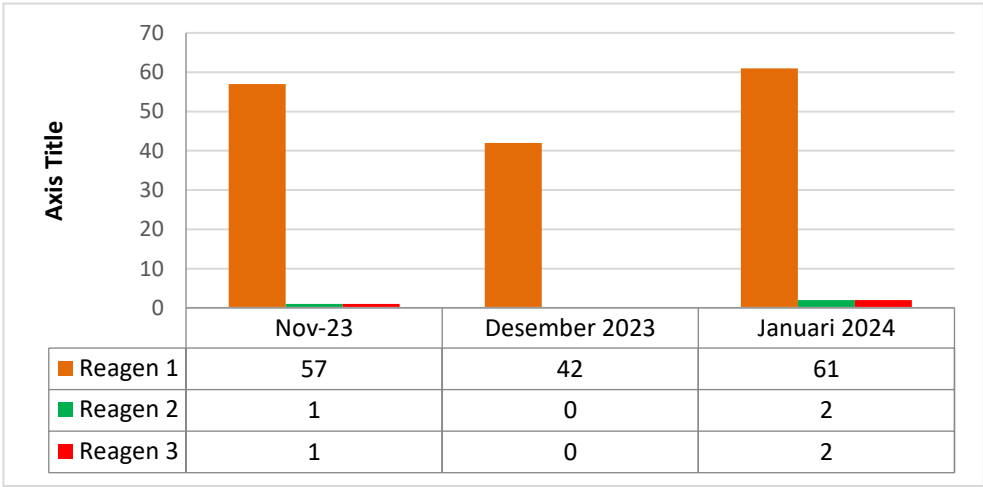
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

d) Jumlah Pemakaian Reagen

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Reagen 1	57	42	61
2	Reagen 2	1	0	2
3	Reagen 3	1	0	2

**Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan desember 2023 pemakaian regen sampai reagen 1 saja, sedangkan pada bulan Januari 2024 sampai dengan reagen 3, Hal ini dikarenakan ada 3 pasien dengan hasil HIV Reaktif.

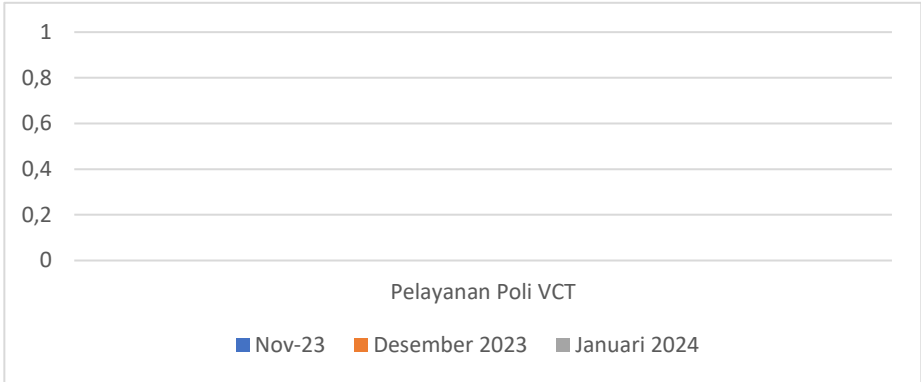
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

e) Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



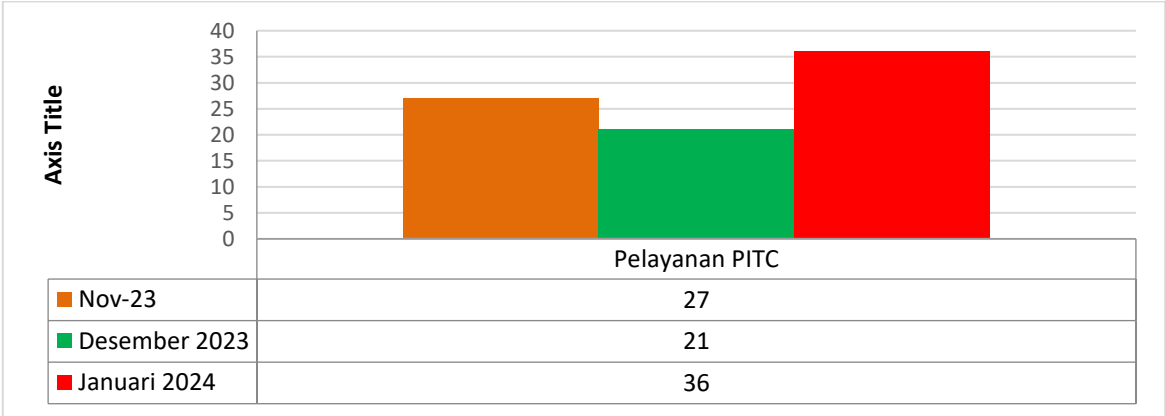
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut :
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarena asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

f) **Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)**

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Pelayanan PITC	27	21	36

Grafik Pelayanan PITC di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



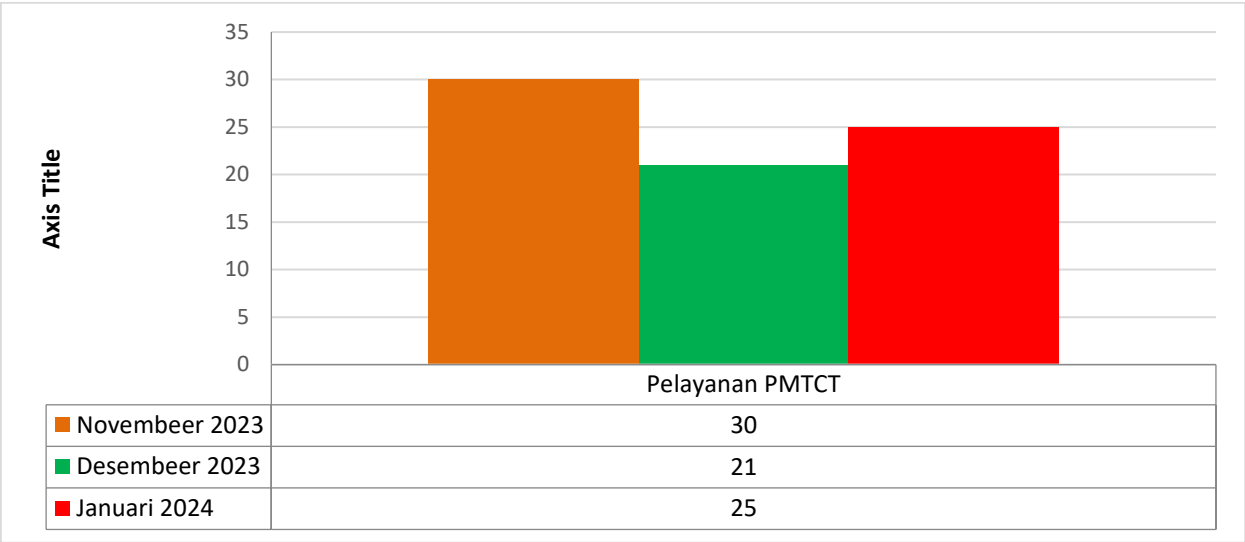
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan November 2023 terdapat 27 pasien, pada bulan desember sebanyak 21 pasien. Sedangkan pada bulan Januari 2024 sebanyak 36 pasien Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana :
Dilakukan peningkatan terkait penjangran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

g) Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Pelayanan PMTCT	30	21	25

Grafik Pelayanan PMTCT di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada buan November sebanyak 30 pasien. pada bulan desember 2023 21 pasien. Sedangkan pada bulan januari 2024 sebanyak 25 pasien

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

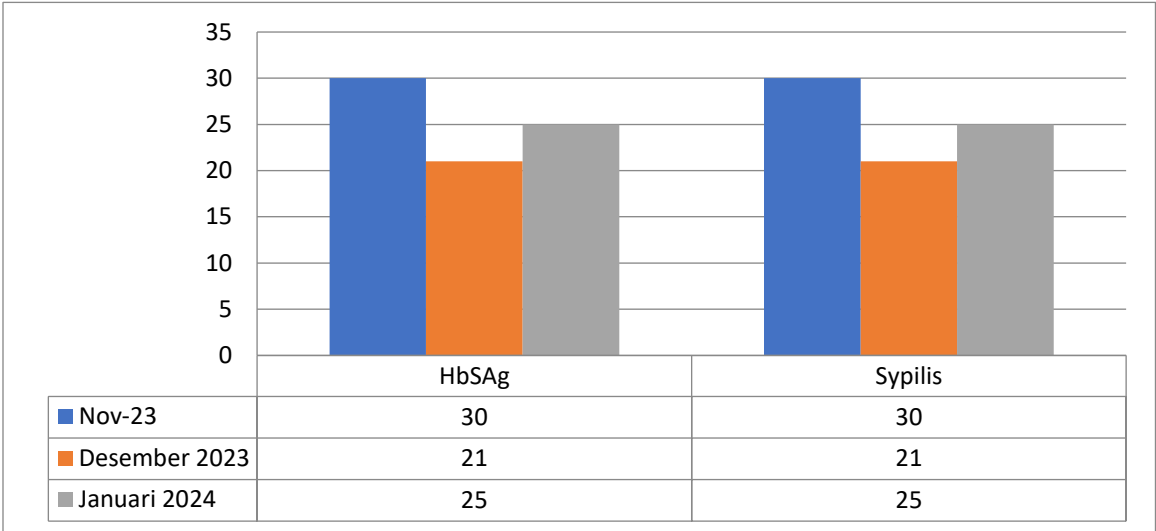
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

h) Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	HbSAg	30	21	25
2	Sypilis	30	21	25

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



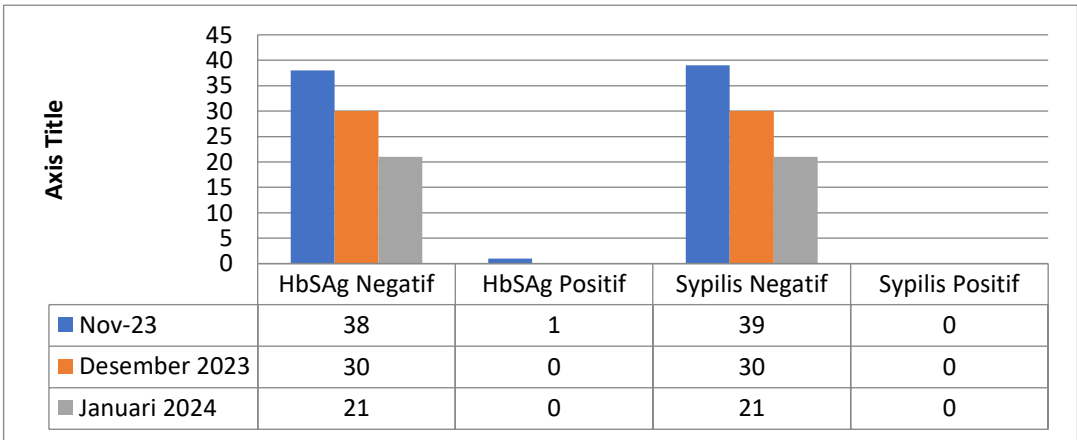
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan November 2023 ada 30 pasien. pada bulan desember 21 pasien sedangkan pada bulan januari 2024 sebanyak 25 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

i) **Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil**

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	HbSAg			
	Negatif	30	21	25
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	30	21	25
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



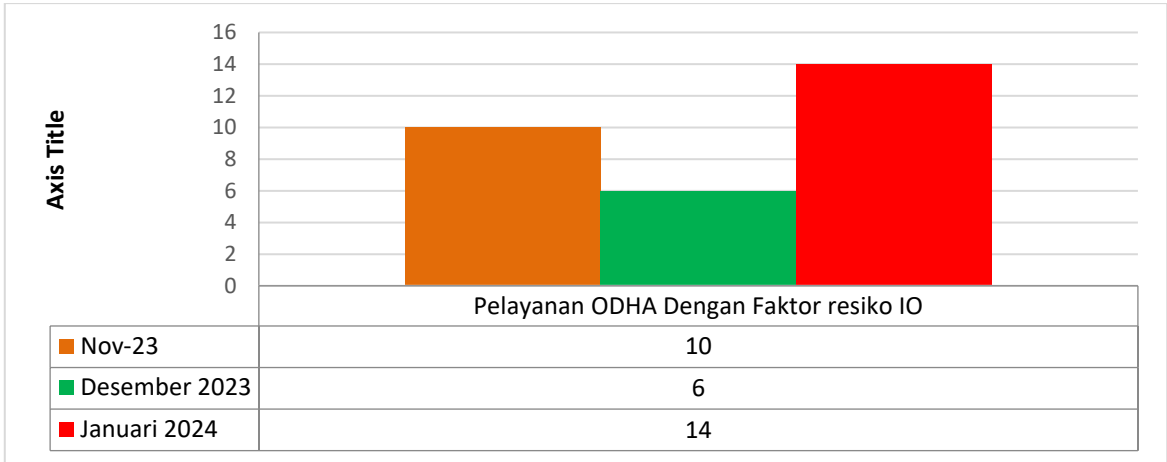
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ditemukan kasus pasien dengan HbSAg maupun sypiis yang positif. Hal ini dikarenakan pasien menerapkan pola hidup sehat saat kehamilan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1) Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
 - 2) Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

j) **Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik**

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	10	6	14

Grafik Pelayanan Odha Dg Faktor Resiko IO Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



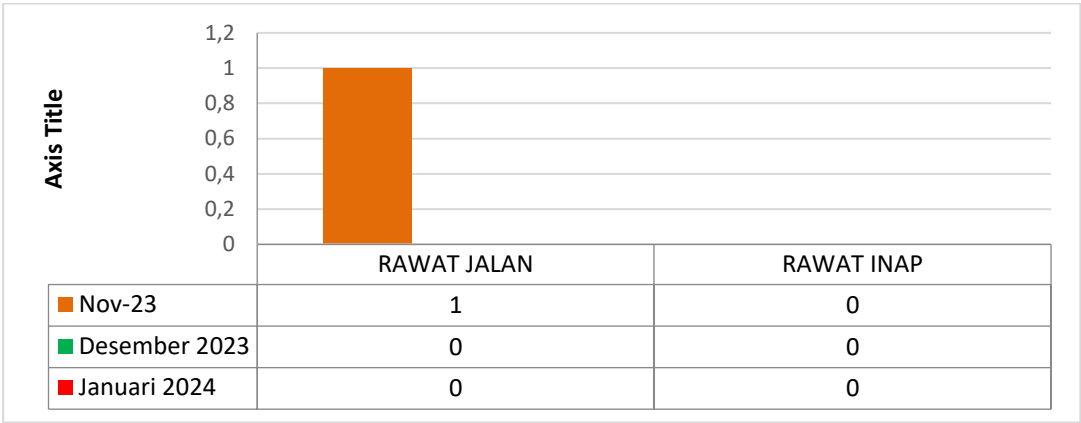
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Oktober 2023 terdapat 10 pasien, pada bulan desember 2023 terjadi penurunan yaitu 6 pasien. sedangkan pada bulan Januari 2024 terjadi penigkatan yaitu 14 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

k) Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Rawat Jalan	2	0	0
2	Rawat Inap	0	0	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan desember 2023 dan Januari 2024 tidak terdapat pasien yang dilakukan rujuk eksternal. Hal ini dikarenakan tidak ada pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

d. Stunting dan Wasting

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	NOV 2023	DES 2023	JAN 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan , irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1

Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	2	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :

Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi pada intervensi spesifik berupa pemberian taburia dan vitamin A pada balita, pemberian obat cacing pada ibu hamil masih belum dilakukan karena ketersediaan taburia, obat cacing, dan vitamin A terdapat pada faskes 1. Pasien stunting yang ditemukan pada bulan oktober merupakan pasien stunting yang ditemukan pada bulan sebelumnya. Berat badan pasien sudah meningkat dibandingkan bulan lalu.

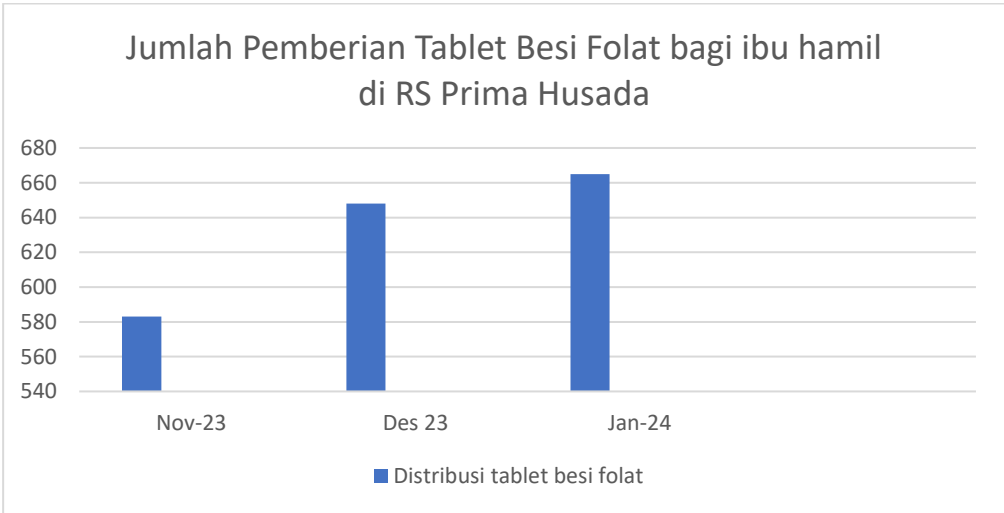
Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

a) Pemberian Tablet Besi Folat bagi ibu hamil

BULAN	NOV 2023	DES 2023	JAN 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	583	648	665

Grafik Jumlah Pemberian tablet besi folat pada ibu hamil Di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Analisis :

Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan November dikarenakan jumlah kunjungan ibu hamil pada bulan November dan meningkat pada bulan Desember karena jumlah kunjungan yang meningkat pada bulan Januari 2024.

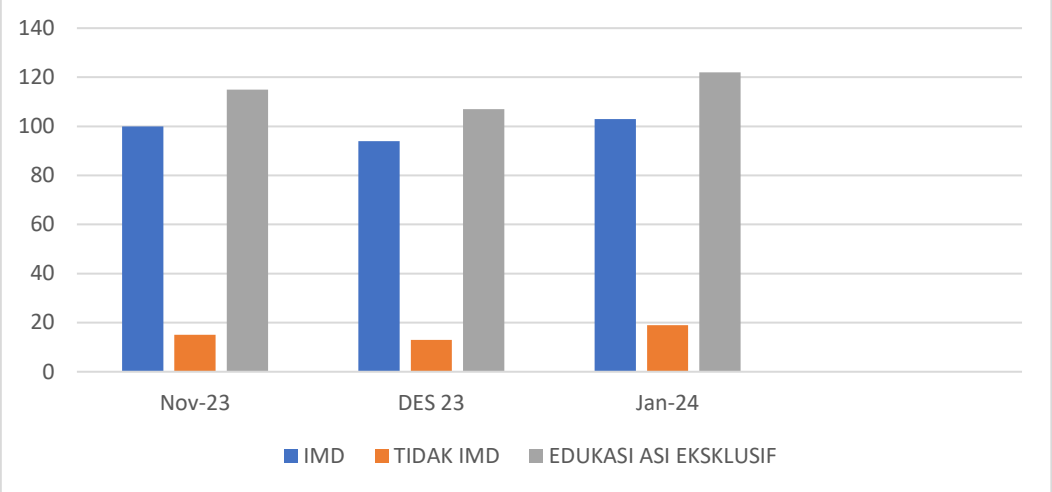
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

b) Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	IMD	100	94	103
2	Tidak IMD	15	13	19
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	115	107	122

Grafik IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 103 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2) Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Januari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 19 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3) Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4) 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Januari 2024 dikarenakan terdapat dokter spesialis kandungan baru sehingga juga meningkatkan kunjungan jumlah pasien ibu hamil.

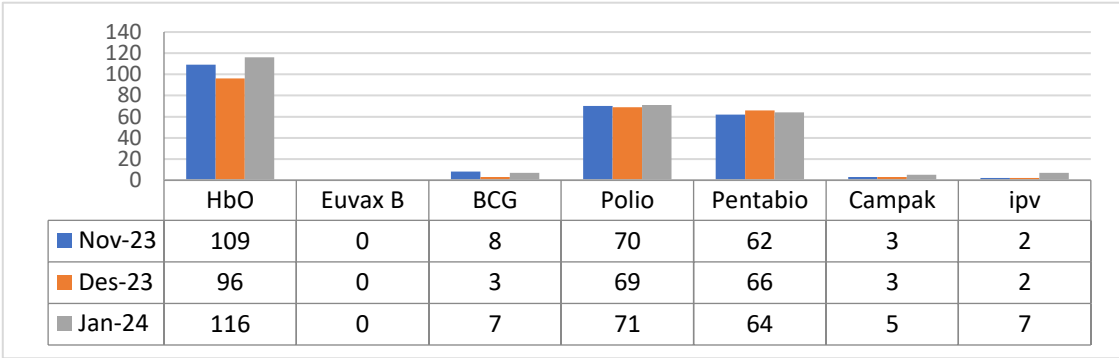
Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

c) Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	HbO	109	96	116
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	8	3	7
3	Polio	70	69	71
4	Pentabio	62	66	64
5	Campak	3	3	5
6	IPV	2	2	7

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



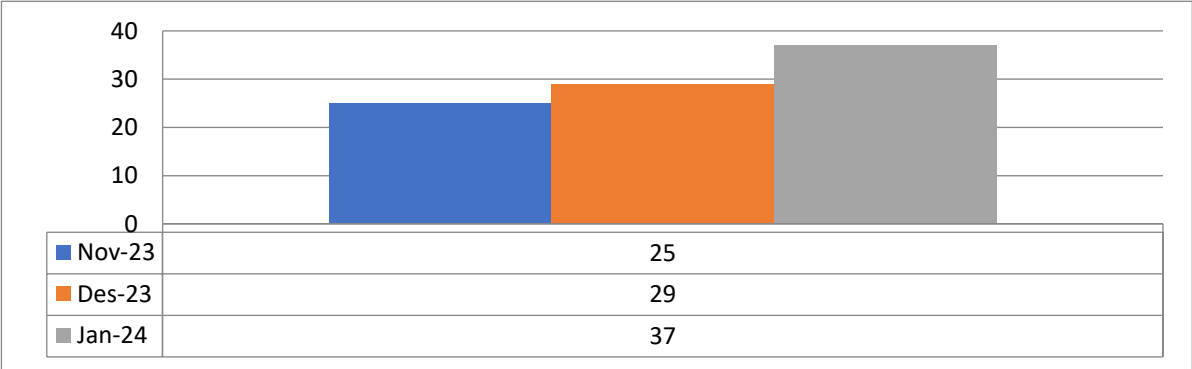
Analisis:
Jumlah pemberian imunisasi pada balita bulan Desember menurun dibandingkan bulan sebelumnya dikarenakan balita lebih banyak melakukan imunisasi di puskesmas karena terdapat imunisasi rotavirus yang didapatkan secara gratis, sedangkan di RS Prima Husada Malang masih belum terdapat vaksin rotavirus tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Penanggungjawab Imunisasi sudah melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas Singosari untuk penyediaan vaksin rotavirus di RS Prima Husada Malang. Akan tetapi dari pihak puskesmas masih belum bisa menyediakan di rumah sakit swasta karena jumlah vaksin rotavirus yang terbatas

d) Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	32	25	37
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2024



- Analisis :**
- Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
 - Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.

Rencana Tindak Lanjut :
Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan

e) Rumah Sakit Sebagai Pusat Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

NO	RUJUKAN	NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	Rujukan Masuk	0	0	0
2	Rujukan keluar	0	0	0

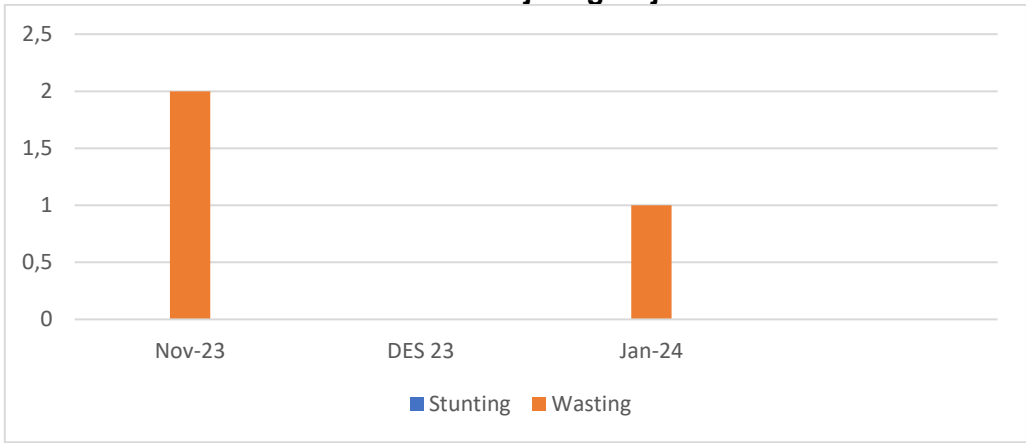
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting dan wasting yang dirujuk keluar maupun masuk pada bulan Januari 2024.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

f) Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	0	0
Jumlah Pasien Wasting	2	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisa :
Terdapat 2 balita wasting di RS Prima Husada Malang pada bulan November. Hal tersebut dikarenakan pola makan balita terbilang kurang karena hanya 1-2 kali sehari, pasien juga jarang megkonsumsi makanan tinggi protein. Terdapat 1 pasien wasting pada bulan Januari. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

g) Program Pemantauan dan Evaluasi

Program pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting adalah dengan cara mengontrol pola makan, berat badan dan tinggi badan pasien pada saat pasien melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Analisis :

Program pemantauan dan evaluasi pasien stunting yang ditemukan saat rawat inap masih belum terlaksana dikarenakan pasien tersebut tidak melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Rencana Tindak Lanjut :

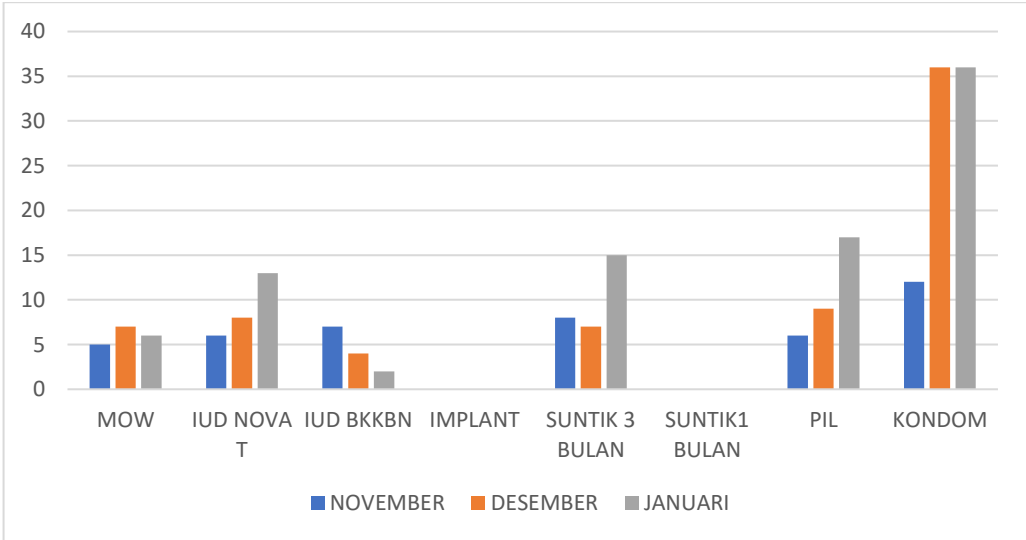
Menghubungi petugas gizi untuk melakukan pemantauan berat badan , tinggi badan, dan pola makan pada balita stunting yang ditemukan tim stunting dan wasting RS Prima Husada Malang.

e. KBRS

a) Angka Capaian Pelayanan KB Per-Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	MOW	5	7	6
2	IUD Nova T	6	8	13
3	IUD BKKBN	7	4	2
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	8	7	15
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL BKKBN	6	9	17
8	KONDOM BKKBN	12	36	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per-Metode Kontrasepsi



Analisis:

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2) Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.

- 3) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

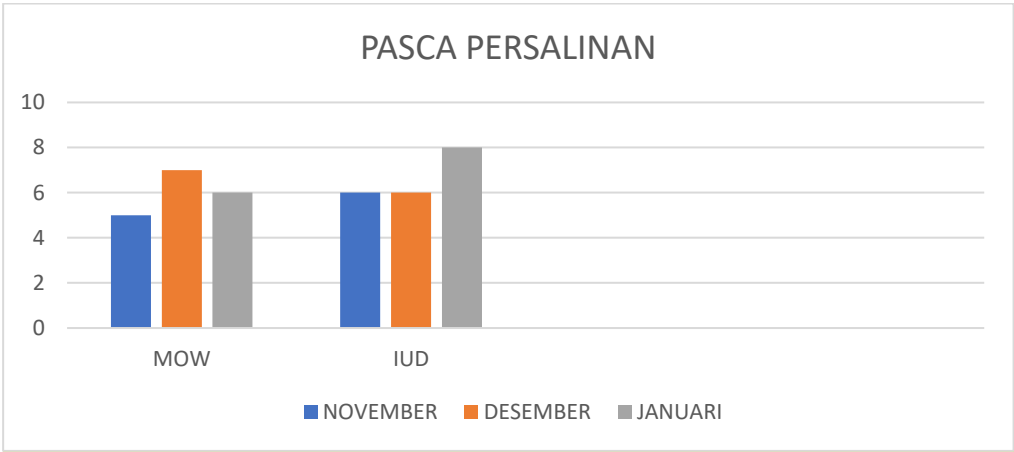
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta, dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

b) Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

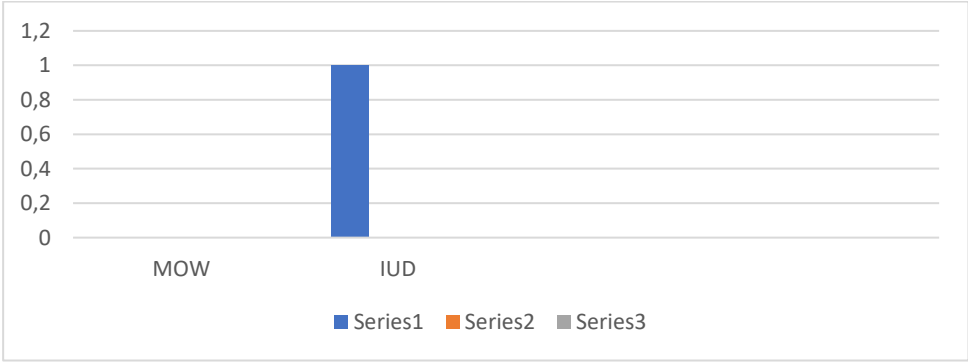
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	MOW	5	7	6
2	IUD	6	6	8

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2023	DESEMBER 2023	JANUARI 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	1	0	0

Grafik Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran



Analisis :

- 1) Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.

-
- 2) Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2) Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

BAB IV
DATA UTILITAS UNIT

A. Pelayanan Medis

a. Tabel Data Kamar Operasi

No .	Jenis Operasi	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Jumlah
1.	Kecil	0	66	0	0	0	66
2.	Sedang	0	5	0	0	0	5
3.	Besar	11	272	1	4	1	289
4.	Khusus	3	40	12	3	4	62
	Jumlah	14	383	13	7	5	422

1. 10 Tindakan Operatif

No	Deskripsi	Jumlah
1	SC	77
2	Phaco	57
3	Eksisi	57
4	Debridement	3
5	Remove Implant	23
6	Orif	18
7	URS	12
8	Herniotomy	12
9	Repair	17
10	Laparotomy	13

2. 10 Besar Diagnosa Operatif

No	Deskripsi	Jumlah
1.	Katarac	57
2.	BPH	26
3.	Union Fr	25
4.	Close fraktur	23
5.	STT	18
6.	Tumor	17
7.	Ganglion	13
8.	Batu Ureter	12
9.	Hernia	12
10.	Necrotizing	10

b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan

1. Kunjungan Rawat Jalan Bulan November 2023

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		KEMENKES		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	48	262	21	804	0	0	0	0	0	0	4	62	0	1	1202
2	IGD	182	278	47	145	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	716
3	Bedah	11	29	56	1099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1205
4	Bedah Plastik	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23
5	Fisioterapi	1	41	0	1189	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1249
6	Gigi spesialis	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
7	Gizi	4		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Klinik Ibu danBayi	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
9	Jantung	4	15	15	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190
10	Jiwa	1	3	7	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
11	Kandungan	85	290	48	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1236
12	Kulit dan kelamin	13	41	32	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
13	Mata	14	21	44	1114	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
14	Orthopedi	12	38	0	469	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	595
15	Paru	7	40	12	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537
16	Penyakit dalam	19	57	41	2337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2464
17	Saraf	16	18	39	1150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1226
18	THT	17	25	25	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
19	Urologi	9	10	38	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426
20	Klinik Umum	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
JUMLAH		451	1211	425	11760	12	113	0		0	5	24	134	13	24	
TOTAL		1662		12185		125		0		5		158		37		14172

2. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Desember 2023

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	56	216	22	842	0	0	0	0	2	61	0	5	1204
2	IGD	175	299	49	189	14	6	0	0	11	19	1	01	764
3	Bedah	4	28	37	1029	0	5	0	3	0	3	0	1	1110
4	Bedah Plastik	0	5	3	19	0	1	0	0	0	1	0	0	29
5	Fisioterapi	1	33	0	1045	0	18	0	0	0	0	0	0	1097
6	Gigi spesialis	0	3	0	0	0	0	0	0	3	19	0	0	25
7	Gizi	16												16
8	Klinik Ibu danBayi	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
9	Jantung	4	8	12	1207	0	0	0	0	0	6	0	0	1237
10	Jiwa	1	5	6	191	0	0	0	0	0	0	0	0	203
11	Kandungan	68	307	44	718	0	0	0	0	6	14	1	2	1160
12	Kulit dan kelamin	23	43	21	263	0	0	0	0	0	7	1	0	358
13	Mata	13	16	35	1064	0	0	0	0	1	6	0	0	1135
14	Orthopedi	1	14	17	438	1	49	0	0	1	2	0	4	527
15	Paru	0	19	8	447	0	0	0	0	0	5	0	0	479
16	Penyakit dalam	16	64	35	2649	0	0	0	0	2	25	0	0	2791
17	Saraf	11	28	29	1244	0	2	0	0	1	5	0	0	1320
18	THT	19	24	25	117	0	0	0	0	3	8	1	2	199
19	Urologi	11	17	27	367	0	0	0	0	0	2	0	7	431
20	Klinik Umum	52	16	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	107
JUMLAH		471	1179	370	11829	15	81	0	3	30	183	43	22	14226
TOTAL		1650		12199		96		3		213		65		

3. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Januari 2024

NO.	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		KEMENKES		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	57	260	35	749	0	0	0	0	0	0	7	51	0	0	1.159
2	Bedah	8	35	49	831	0	0	0	0	0	3	1	8	0	0	935
3	Bedah Plastik	0	2	2	28	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	36
4	Fisioterapi	0	27	0	1.115	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	1.161
5	Gigi Spesialis	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0	28
6	Ibu dan Anak	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
7	Jantung	3	17	18	1.074	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	1.119
8	Jiwa	0	8	7	225	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	241
9	Kandungan	81	322	52	789	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	1.270
10	Kulit dan Kelamin	13	27	29	361	0	0	0	0	0	0	1	9	0	2	442
11	Mata	14	11	59	1.218	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.306
12	Orthopedi	10	24	27	479	0	0	0	0	0	1	1	59	0	8	609
13	Paru	3	17	15	513	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	551
14	Penyakit Dalam	21	68	43	2.479	0	0	0	0	0	0	1	12	0	1	2.625
15	Syaraf	9	27	28	1.321	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1.389
16	THT	25	34	42	167	0	0	0	0	0	2	1	10	1	1	283
17	Umum	65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	7	90
18	Klinik Urologi	7	20	31	325	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	386
19	Instalasi Gawat Darurat	125	122	95	282	0	0	0	0	0	0	19	40	0	1	684
TOTAL		442	1.071	532	11.956	0	0	0	0	0	6	39	272	7	22	14.347

B. Tabel Data Instalasi Rawat Inap
1. Kunjungan Rawat Inap Bulan November Tahun 2023

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSA HAAN	BPJS IKUT IBU	TOTAL
1	VVIP	0	3	0	0	0	1	0	0	4
2	VIP	3	8	0	0	0	2	1	0	14
3	Kelas I	3	120	0	0	1	1	2	0	127
4	Kelas II	4	264	6	0	0	0	0	0	274
5	Kelas III	25	345	2	0	5	0	0	0	377
6	ICU	3	28	0	0	0	0	0	0	31
7	Maternitas	2	36	0	0	0	0	0	0	38
8	Neonatologi	2	11	0	0	0	0	0	107	120
9	NICU	1	5	0	0	0	0	0	0	6
10	Isolasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ICU Covid	1	6	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL		44	826	8	0	6	4	3	107	998

2. Kunjungan Rawat Inap Bulan Desember 2023

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	TOTAL
1	VVIP	1	3	0	0	0	3	0	0	7
2	VIP	6	13	0	0	0	4	1	0	24
3	Kelas I	4	154	0	0	0	3	3	0	164
4	Kelas II	12	277	17	0	0	1	0	0	307

5	Kelas III	30	343	2	0	2	0	1	0	378
6	ICU	1	22	0	0	0	0	0	0	23
7	Maternitas	1	34	0	0	0	0	0	0	35
8	Neonatologi	1	11	0	0	0	0	0	97	109
9	NICU	1	6	0	0	0	0	0	0	7
10	Isolasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ICU T -	1	17	0	0	0	0	0	0	18
TOTAL		58	880	19	0	2	11	5	97	1072

3. Kunjungan Rawat Inap Bulan Januari 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	PEMERINTAH LAINYA (TASPEN)	TOTAL
1	VVIP	0	10	0	0	0	1	0	0	0	11
2	VIP	6	12	1	0	0	2	0	0	0	21
3	Kelas I	3	151	0	0	1	7	2	0	0	164
4	Kelas II	15	302	15	0	2	2	0	0	0	336
5	Kelas III	26	390	1	0	4	0	1	0	1	423
6	ICU	3	19	0	0	0	0	0	0	0	22
7	Maternitas	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
8	Neonatologi	3	11	0	0	0	2	0	101	0	117
9	NICU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Isolasi	3	14	0	0	0	0	0	0	0	17
11	ICU T -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		59	945	17	0	7	14	3	101	1	1147

c. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1. Bulan November 2023

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	456	200	21	2	38	-	-
2	Rawat Inap	46	550	3	0	3	-	-
3	Rujuk	1	22	1	0	0	RSUD Lawang RSSA RS UMM RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi)
4	Meninggal	2	7		0	0	-	-

2. Bulan Desember 2023

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	463	254	17	0	37	-	-
2	Rawat Inap	59	567	14	1	13	-	-
3	Rujuk	0	24	0	1	0	RSUD Lawang RSSA RS UMM RST Soepraoen RS Karsa Husada Batu	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi)
4	Meninggal	10	5	0	0	0	-	-

3. Januari 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	232	414	17	1	35	-	-
2	Rawat Inap	45	682	7	0	6	-	-
3	Rujuk	4	19	1	1	0	RSUD Soetomo RSSA RSUD Lawang RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu RS Unisma RS PHS	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi, Pro Stroke unit)
4	Meninggal	5	4	0	0	0	-	-

C. Penunjang Medis

a. Tabel Data Laboratorium

1. Daftar Pemeriksaan Lab yang Dilakukan Di Dalam RS Prima Husada Malang

No	Jenis Pemeriksaan	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4.879	4486	4915
	Hematologi	2.074	2062	2406
	Serologi dan Molekuler	520	553	568
	Urine	545	292	371
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-

	Feses	35	71	54
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	-	-	1
	Pemeriksaan Histopatologi	18	8	25
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	28	8	11
4	Narkoba	9	50	67
5	Covid-19	70	76	69

2. **Daftar Pemeriksaan Lab Yang Dilakukan Diuar RS Prima Husada Malang**

No	Jenis Pemeriksaan	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	24	1
	Hematologi	4	3	0
	Serologi dan Molekuler	21	14	24
	Urine	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	-	1	-
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	5	7	9
	Pemeriksaan Histopatologi	69	66	87
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	15	19	5
4	PCR	-	-	1
5	Tumor Marker	2	20	2

Analisis

Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :

- 1. Patologi Anatomi : 243 sampel
- 2. Patologi Klinik : 93 sampel
- 3. Bakteriologi/Mikrobiologi : 39 sampel
- 4. Tumor Marker : 24 sampel
- 5. PCR : 1 sampel (kasus covid-19 sudah jarang ditemui)

Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan

b. Tabel Data Radiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	NOV 2023	DES 2023	JAN 2024
1. Radiodiagnostik	Umum	80	125	437
	BPJS Kesehatan	611	545	720
	BPJS TK	15	80	40
	Asuransi Swasta	20	15	80
	Jasaraharja	185	160	100
Total		911	925	1377
2. Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	80	125	437
	BPJS Kesehatan	611	545	720
	BPJS TK	15	80	40
	Asuransi Swasta	20	15	80
	Jasaraharja	185	160	100
Total		911	925	1377
3. Foto Dengan Rol Film	Umum	80	125	437
	BPJS Kesehatan	611	545	720
	BPJS TK	15	80	40
	Asuransi Swasta	20	15	80
	Jasaraharja	185	160	100
Total		911	925	1377
4. CT Scan tanpa kontras	Umum	15	8	-
	BPJS Kesehatan	104	80	11
	BPJS TK	6	4	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	75	10	-
Total		200	102	11
5. CT Scan dengan kontras	Umum	-	-	-
	BPJS Kesehatan	15	60	-
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	-	-	-
Total		15	60	0
6. USG tanpa kontras	Umum	70	52	44
	BPJS Kesehatan	107	110	150
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	10	-	-
	Jasaraharja	-	-	-
Total		187	162	194

Analisis

1. Pelayanan pemeriksaan rontgen di Bulan Januari mengalami kenaikan dari 2 bulan sebelumnya, dikarenakan jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan juga mengalami kenaikan.
2. Pelayanan pemeriksaan CT Scan mengalami penurunan drastic, disebabkan oleh Alat CT Scan yang rusak, sehingga pasien-pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut dirujuk pemeriksaan ke Radiologi luar (RSUD Lawang) sembari menunggu perbaikan.
3. Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.

Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak yaitu:

- a) Rontgen : 3213 pasien
- b) USG : 543 pasien
- c) CT-Scan : 388 pasien

Hal ini disebabkan oleh permintaan rontgen lebih banyak, dimana pasien usia >40tahun membutuhkan pemeriksaan rontgen thorax PA untuk skrining maupun jika ada keluhan, sedangkan pemeriksaan CT Scan hanya dilakukan jika indikasi. Selain itu, jenis pemeriksaan rontgen lebih banyak dibandingkan jenis pemeriksaan USG dan CT Scan

Rencana Tindak Lanjut

1. Follow up perbaikan Alat CT Scan, menunggu sparepart datang, estimasi Bulan Februari 2024
2. Mengajukan MOU dengan RSUD Lawang
3. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan jika sudah diperbaiki untuk menaikkan pendapatan.

c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Unit dan Penjamin	Nov 2023		Des 2023		Jan 2024	
	Jenis Resep		Jenis Resep		Jenis Resep	
	Racik	Non Racik	Racik	Non Racik	Racik	Non Racik
1. Rawat Inap						
Umum	37	536	64	622	37	677
BPJS Kesehatan	117	5680	195	5437	191	6610
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	1	38	0	2	0	70
Jasaraharja	1	38	0	2	0	70
Total	156	6292	259	6063	228	7427
2. Poliklinik						
Umum	232	463	285	712	221	450
BPJS Kesehatan	1593	8000	1752	7808	1913	8582
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	5	0	3	0	5
Jasaraharja	0	5	0	3	0	5
Total	1825	8473	2037	8526	2134	9042
3. Kamar Operasi						
Umum	0	11	0	10	0	13
BPJS Kesehatan	0	410	0	322	0	398
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	7	0	0	0	9
Jasaraharja	0	7	0	0	0	9
Total	0	435	0	332	0	429
4. IGD						
Umum	61	606	89	586	31	346
BPJS Kesehatan	63	931	65	1032	85	1337
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	9	0	1	0	16
Jasaraharja	0	9	0	1	0	16
Total	124	1555	154	1620	116	1715
Total Resep	2105	16755	2450	16541	2478	18613

Analisis

Dari table diatas diketahui bahwa jumlah resep masuk di Bulan Januari mengalami kenaikan dibandingkan 2 bulan terakhir berbanding lurus dengan jumlah kunjungan pasien.

Perbedaan jumlah resep dapat disebabkan dari berbagai hal seperti kunjungan pasien, jumlah dokter yang tidak praktek atau izin atau cuti, jumlah tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut

- 1. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan minat pasien untuk melakukan kunjungan ulang ke RS agar jumlah kunjungan dan jumlah resep meningkat setiap bulannya
- 2. Mengadakan layanan pengantaran obat di Bulan Februari 2024 dengan harga terjangkau untuk menurunkan jumlah antrian pasien di Ruang Tunggu

d. Tabel Data Laundry

No	Unit	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
Linen				
1	VVIP	1kg	1kg	1kg
2	VIP	1kg	1kg	1kg
3	Kelas I	49kg	39kg	81kg
4	Kelas 2	501kg	487kg	507kg
5	Kelas 3	1765kg	1677kg	1461kg
6	Maternitas kelas 1	37kg	32kg	33kg
7	Maternitas kelas 2	302kg	287kg	245kg
8	Maternitas kelas 3	547kg	498kg	669kg
9	ICU	23kg	19kg	205kg
10	Kamar Operasi	2014kg	2001kg	2230kg
11	Poliklinik	13kg	9kg	27kg
12	IGD	86kg	72kg	75kg
13	Laborat	5kg	4kg	4kg
14	Radioogi	2kg	1kg	3kg
15	Dapur/Gizi	5kg	3kg	3kg
16	CSSD	4kg	2kg	5kg
Total Linen Tercuci		5.355kg	5.133kg	5550kg
Bahan Habis Pakai				
1	Alkali	1	1	1
2	Emulsi	1	1	1
3	Oxy	0	1	1
4	Netral	1	1	1
5	Softener	18	17	26
6	Rapika	38	35	41
7	Detergen	7	6	16
8	Pemutih	6	5	19
9	LPG	12	11	18
Total		84	78	124

Analisis

- 1. Dari tabel diatas diketahui bahwa linen kotor meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien.
- 2. Linen kotor paling banyak dari Unit IRNA dengan kelas perawatan kelas 3, dimana total ruangan kelas 3 adalah 49TT dari 140TT.

3. Terdapat kerusakan mesin cuci rumah tangga sebanyak 3 unit, dalam perbaikan oleh vendor dan mendapat backup 1 unit mesin cuci.

Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pengajuan detergen liquid/matic setelah dilakukan uji coba, untuk menghindari mesin korosif.
2. Melakukan pengajuan mesin cuci industry supaya kapasitas lebih besar dan efisiensi waktu
- 3.

e. Tabel Data CSSD

No	Hal	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	Chemical Alcalide	1800ml	1000ml	1500ML
2	Chemical Alkazyme	38pcs	20pcs	21
3	Kassa Masuk	34roll	34roll	54roll
4	Kassa Keluar	1688pouches	1691pouches	1899pouches
5	BHP Pouces	4.5roll	6roll	5.5roll
6	Indikator Adhesive	2roll	3roll	1roll
7	Indikator Strip Steam	2box	3box	2box
Alat yang disetor				
8	Unit IKO	402set	360set	391set
9	IRJA	120set	132set	101set
10	IRNA 5C	3set	3set	7set
11	IRNA 3A dan 4A	6set	4set	5 set
12	IRNA 3C ANAK	1set	1set	2 set
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	15set	9set	8 set
14	IRNA 2C VIP	1set	1set	4set
15	IRNA ICU	9set	3set	10set
16	IGD	135set	141set	126set
17	MATERNITAS	201set	200set	203set
18	PERINA	101set	88set	108set
Jumlah		994set	942set	965set

Analisis

1. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 1.153 set, diikuti dari Unit Maternitas 604 set dan IGD 402 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

Rencana Tindak Lanjut

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

f. Tabel Data Instalasi Gizi

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIET			PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		NOV 2023	DES 2023	JAN 2024	
1	Diabetes Melitus	192	245	298	122
2	Rendah Garam	336	318	389	122
3	Jantung	164	162	176	109
4	Rendah serat	224	327	354	108
5	TKTP	874	879	1158	132
6	Makanan biasa	25	29	34	117
7	Makanan Lunak	26	28	17	61
8	Rendah Lemak	157	149	165	111
9	Rendah Protein	53	55	102	185
10	Bubur Halus	120	120	133	111
11	Cair	32	48	60	125
12	Rendah Purin	63	87	79	91
13	Tinggi Protein	39	42	45	107
14	Blender	22	29	23	79
15	Tinggi serat	15	4	0	0
16	Tinggi Kalsium	82	62	65	105
17	Rendah Kalsium	12	15	24	160
18	Rendah Sisa	3	0	0	0
Total		2439	2599	3122	120



Analisis

Rata-rata pemberian diet paling banyak tahun 2023 ada pada diet TKTP, RG yaitu sebanyak 1066,3, 653,3, rata-rata pemberian diet paling rendah tahun 2023 ada pada diet Rendah kalium dan Rendah sisa yaitu sebanyak 9,8 dan 3,8.

Jumlah pemberian diet pasien di rawat inap, dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.

g. Instalasi Rekam Medis

Tabel Daftar 10 Besar Penyakit di Rawat Jalan pada Bulan Januari 2024

NO	CODE ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11	DM Type 2 / Noninsulin-dependent diabetes mellitus	931
2	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	535
3	M17	Gonarthrosis [arthrosis of knee]	370
4	M54.5	LBP (Low Back Pain)	332
5	I25	Chronic ischemic heart disease	331
6	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	303
7	J03	Acute tonsillitis (1003)	295
8	H53	Visual disturbances	292
9	I50.0	CHF / Congestive heart failure	249
10	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	246

Analisis :

Dari data di atas terbanyak adalah penyakit diabetes melitus dengan jumlah bulan januari 2024 931 pasien dari data di atas penderita DM mengalami peningkatan ,pasien di bulan januari 2024 pasien.dikarenakan bulan januari 2024 pasien juga meningkat sehingga penderita dm semakin banyak

Rencana Tindak Lanjut :

- Menyediakan data pasien dan no telfon untuk tindak lanjut ke bagian manajemen, data tersebut bisa dilakukan untuk tindak lanjut ke bagian manajemen seperti melakukan :
- Diadakan program senam kaki untuk penderita DM.
- Membagikan leaflet tentang senam kaki DM.
- Berikut link data pasien yang sakit Diabetes Melitus
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iR8zsxrFcoSHnqD25HwDmUUMbPyDbbe6/edit#gid=921693695>
- Hasil dari follow up humas dan marketing :
 - Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatric
 - Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan
 - Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap

Tabel Daftar 10 besar penyakit di Rawat Inap Pada Bulan Januari 2024

DAFTAR 10 BESAR PENYAKIT			
NO	KODE	DIAGNOSA	JUMLAH
1	P24.9	Neonatus Aterm	89
2	E86	Volume Depletion	77
3	E11	Diabtes Mellitus	42
4	k21.9	Gastro Esophageal Reflux Disease	38
5	O63.0	Gravida + Kala I Fase Aktif	29
6	O34.2	Gravida + Berkas Sectio Caesaria	25
7	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	25
8	J18.0	Broncho Pneumonia	24
9	A01.0	Typhoid Fever	23
10	J18.9	Pneumonia	22

Analisis :

Dari data di atas menunjukkan 89 neonatus aterm naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit.

Dalam struktur organisasi RS Prima Husada Jabatan Struktural di Tingkat direksi sudah terpenuhi, seperti jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Untuk jabatan di beberapa komite sudah terisi seperti di komite Etik RS dan Komite Tenaga Kesehatan Lain yang sudah terisi sehingga permasalahan-permasalahan seputar etik dan tenaga kesehatan lain mulai mendapat perhatian dari manajemen.

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Pada bulan November Kunjungan pasien di RS Prima Husada Malang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan bulan Januari 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Januari 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 Februari 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah